



MINISTERIO
DE SANIDAD

AMIR

PRUEBAS SELECTIVAS CUADERNO DE EXAMEN

MEDICINA - VERSIÓN: 0
SIMULACRO 17

NÚMERO DE MESA:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

Nº DE D.N.I. O EQUIVALENTE PARA EXTRANJEROS:

APELLIDOS Y NOMBRE:

ADVERTENCIA IMPORTANTE ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- 1. MUY IMPORTANTE:** Compruebe que este Cuaderno de Examen, lleva todas sus páginas y no tiene defectos de impresión. Si detecta alguna anomalía, pida otro Cuaderno de Examen a la Mesa. **Realice esta operación al principio**, pues si tiene que cambiar el cuaderno de examen posteriormente, se le facilitará una versión "0", que no coincide con su versión personal en la colocación de preguntas y **no dispondrá** de tiempo adicional.
- El cuestionario se compone de 200 preguntas más 10 de reserva. Tenga en cuenta que hay 30 **preguntas que están ligadas a una imagen**. Todas las imágenes están en un cuadernillo de imágenes separado.
- Compruebe que el **número de versión** de examen que figura en su "Hoja de Respuestas", **coincide** con el número de versión que figura en el cuestionario. Compruebe también el resto de sus datos identificativos.
- La "Hoja de Respuestas" está nominalizada. Se compone de dos ejemplares en papel autocopiativo que deben colocarse correctamente para permitir la impresión de las contestaciones en todos ellos. Recuerde que debe firmar esta Hoja.
- Compruebe que la respuesta que va a señalar en la "Hoja de Respuestas" corresponde al número de pregunta del cuestionario. **Sólo se valoran** las respuestas marcadas en la "Hoja de Respuestas", siempre que se tengan en cuenta las instrucciones contenidas en la misma.
- Si inutiliza su "Hoja de Respuestas" pida un nuevo juego de repuesto a la Mesa de Examen y **no olvide** consignar sus datos personales.
- Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de cuatro horas y media improrrogables y que están prohibidos el uso de calculadoras y la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro dispositivo con capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos.
- No se entregarán**, en ningún caso, **los cuestionarios** con las preguntas de examen. Las distintas versiones de los cuadernos de examen se publicarán en la Web del Ministerio de Sanidad, al cierre de la última mesa de examen.

1. Pregunta vinculada a la imagen nº 1:

Mujer de 29 años, embarazada de 20 semanas, en estudio por intensa astenia. En la exploración se aprecia eritema facial (ver imagen adjunta), úlceras orales no dolorosas, y alopecia no cicatricial. En la analítica presenta importante linfopenia, anemia y anticuerpos anticardiolipina positivos (que según refiere no es la primera vez que se positivizan). Comenta que hace unos años tuvo embarazo con muerte fetal de causa desconocida en la semana 30. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento que debe seguir?:

1. Lupus eritematoso sistémico; aspirina e hidroxiclороquina.
2. Síndrome de Behçet; aspirina y prednisona 10 mg al día hasta el final del embarazo.
3. Lupus eritematoso sistémico; aspirina y prednisona 10 mg al día hasta el final del embarazo.
4. Lupus eritematoso sistémico; hidroxiclороquina, aspirina, heparina a dosis profilácticas y prednisona a dosis bajas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente con probable LES; nos dan una imagen de eritema en alas de mariposa y además alopecia no cicatricial, aftas orales, linfopenia, anemia y ac antifosfolípido, cumpliendo así criterios de lupus. Ante el antecedente de aborto tardío, se trata de un Síndrome Anti Fosfolípido obstétrico asociado a LES. El tratamiento de futuros embarazos se basa en la heparina a dosis profilácticas. Además añadimos corticoides para tratar las lesiones cutáneas, y no nos olvidamos de la hidroxiclороquina, tan importante en todo lupus.

2. Pregunta vinculada a la imagen nº 2:

Mujer de 54 años con antecedentes de tabaquismo, alergia a betalactámicos, hipertensión desde hace 8 años en tratamiento con enalapril, y colecistectomía por colelitiasis sintomática. En análisis de control hecho por su Médico de Cabecera presenta calcemia de 10,9 mg/dL (normal 8,1-10,4). Las proteínas y albúmina son normales. Se acompaña de PTH 95 pg/mL (normal <50), y fósforo 2,5 mg/dL (normal 2,4-4,3 mg/dL). La función renal, resto de iones, perfil hepático, coagulación y hemograma son normales. Se realiza una gammagrafía con Tc-MIBI que se muestra en la imagen. El tratamiento más adecuado sería:

1. Adenomectomía única con cirugía mínimamente invasiva.
2. Paratiroidectomía subtotal.

3. Cinacalcet para control de la calcemia, y valorar bisfosfonatos en función de la densidad mineral ósea.
4. No precisa tratamiento.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tenemos a una paciente con hiperparatiroidismo primario (hipercalcemia con tendencia a la hipofosfatemia, elevación de PTH). Se ha hecho un estudio de localización, observando un adenoma paratiroideo único (la fase tardía, donde se pierde la captación tiroidea, muestra un adenoma inferior izquierdo, ver imagen comentada). El tratamiento del adenoma paratiroideo es quirúrgico, siempre y cuando se cumpla alguna de las indicaciones: edad < 50 años, hipercalcemia sintomática o mayor de 1 mg/dL por encima del límite de la normalidad, deterioro de la función renal, osteoporosis, dificultad de seguimiento, petición expresa del paciente... Como nuestra paciente no cumple criterios quirúrgicos, únicamente está indicado el seguimiento (opción 4). El cinacalcet es un fármaco antagonista de la PTH que se utiliza en los hiperparatiroidismos sintomáticos sin posibilidad de cirugía (no es el caso).

3. Pregunta vinculada a la imagen nº 3:

Un paciente de 43 años de edad sufre un episodio de pancreatitis aguda y, pese a recibir el tratamiento médico adecuado y encontrarse asintomático, presenta a la semana y media una nueva elevación de la amilasemia. Se realiza una TC abdominal que se muestra en la imagen. Ante estos hallazgos, ¿qué opción debemos considerar de elección para el tratamiento?:

1. Actitud expectante.
2. Somatostatina (perfusión iv) u octreotido sc.
3. Drenaje percutáneo guiado por ECO/TC abdominal.
4. Drenaje endoscópico guiado por ecoendoscopia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre el manejo del pseudoquiste pancreático preguntado ya en múltiples ocasiones. La imagen muestra un pseudoquiste en la cola del páncreas, adyacente al bazo. Se trata de una imagen nodular de densidad agua y contornos homogéneos. Si os fijáis en la escala numérica que aparece a la derecha, el pseudoquiste mide aproximadamente 4,5-5 cm. Actualmente el manejo es expectante independientemente del tamaño mientras el paciente esté asintomático.

4. Pregunta vinculada a la imagen nº 4:

Adolescente de 18 años con hipertensión arterial sistémica, ausencia de pulso arterial periférico en extremidades inferiores y una radiografía de tórax que muestra las alteraciones óseas que se ven en la imagen. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. En el electrocardiograma se suelen apreciar signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo.
2. El diagnóstico se efectuará mediante ecocardiografía 2D-Doppler color y/o RM.
3. Es frecuente auscultar un soplo sistólico en región interescapular.
4. El tratamiento de elección es médico (hipotensores).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La Radiografía de tórax muestra el signo de Roesler, que son muescas en el reborde inferior costal, que aparecen por protusión de las colaterales de la aorta. Este hallazgo es típico de la coartación aórtica, una de las cardiopatías congénitas más preguntadas. En la exploración, los pulsos femorales están ausentes o muy disminuidos, existiendo una diferencia de 20 mm Hg con los pulsos de miembros superiores. Además, existe un soplo mesosistólico en el área aórtica y región interescapular (respuesta 3 correcta), debido a la estenosis en la aorta que supone la coartación. En el ECG se aprecia sobrecarga del VI y eje desviado a la izda (respuesta 1 correcta). El diagnóstico de elección nos lo da la arteriografía, pero también es útil la ecocardiografía o la RM (respuesta 2 correcta). La coartación está asociada con multitud de patologías, entre las que cabe destacar el síndrome de Turner, aneurismas en el polígono de Willis o válvula aórtica bicúspide. El tratamiento de elección es QUIRÚRGICO (respuesta 4 FALSA), algo ya preguntado en examen mir de años anteriores.

5. Pregunta vinculada a la imagen nº 5:

Una mujer joven en edad fértil, no fumadora, consulta por disnea de esfuerzo y tos. Presenta antecedentes personales de neumotórax recurrente. En la radiografía de tórax se aprecia un patrón intersticial. Se realiza TC torácica que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos considera que es más probable?:

1. Bronquiolitis respiratoria.
2. Linfangioleiomiomatosis.
3. Microlitiasis alveolar.
4. Histiocitosis X pulmonar.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La TC de tórax muestra quistes aéreos diseminados, de predominio en bases. No es un patrón intersticial típico, pero sí que es un patrón intersticial. Entre las intersticiales hay dos que tiene una clínica "rara", pues en vez de dar disnea progresiva dan problemas pleurales de repetición, del tipo neumotórax y derrame pleural recidivante. Las dos tienen nombres raros: histiocitosis X y linfangioleiomiomatosis. La linfangioleiomiomatosis es una de esas enfermedades en las que tenéis que pensar directamente y sin dudar: mujer joven con disnea de esfuerzo, tos, neumotórax recidivante y quilotórax es el caso típico. No tiene relación con el tabaco,

en cambio parece que existen factores hormonales en su patogenia y se puede tratar con terapia hormonal.

6. Pregunta vinculada a la imagen nº 6:

Paciente de 36 años con antecedentes de trasplante renal en tratamiento inmunosupresor. Consulta por cuadro de una semana de evolución de fiebre y tos productiva con esputo denso y blanquecino. Se realiza radiografía de tórax que se muestra en la imagen. En el cultivo de esputo se observan filamentos arrosariados gram positivos. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?:

1. Amoxicilina-Clavulánico.
2. Eritromicina.
3. Tetraciclinas.
4. Trimetoprim-Sulfametoxazol.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen muestra un absceso pulmonar cavitado. Nuestro paciente presenta una nocardiosis pulmonar "de libro", pero no es una pregunta fácil por no ser muy repetida en el MIR. Es una muy buena pregunta para repasar todo lo que hay que saber de la nocardiosis para el MIR. Nos presentan al paciente prototipo de la nocardiosis: inmunodeprimido (transplantado renal en tratamiento inmunosupresor). El cuadro clínico también es muy típico: neumonía subaguda con nódulos pulmonares cavitados y nos dan un dato muy específico: microscopía de esputo con filamentos retorcidos ramificados o arrosariados gram positivos (recordad que son ácido ácido alcohol resistentes) La nocardiosis en el 50% de los casos se asocia a enfermedad extrapulmonar (sobre todo abscesos cerebrales). El tratamiento de elección es el cotrimoxazol (opción 4 correcta)

7. Pregunta vinculada a la imagen nº 7:

Mujer de 50 años, sin factores de riesgo cardiovascular que acude por disnea de esfuerzo de reciente aparición. Se realiza un ecocardiograma transtorácico que objetiva estenosis valvular mitral grave. Su electrocardiograma se muestra en la imagen, y nos sugiere:

1. Infarto inferior.
2. Asociación de estenosis aórtica severa.
3. Asociación de insuficiencia mitral.
4. Hipertensión pulmonar grave.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El ECG típico de los pacientes con estenosis mitral muestra un crecimiento de la aurícula izquierda (onda P mitral, ancha y mellada por aumento del componente auricular izquierdo) si están en ritmo sinusal, o bien la caída en fabricación auricular, que es muy frecuente. Cuando existe

hipertensión pulmonar (HTP) grave asociada, la onda P demuestra crecimiento de la aurícula derecha, siendo alta y picuda en II y positiva en V1, conocida como onda P pulmonale (en el ECG del caso es negativa porque predomina el crecimiento de la AI sobre el de la AD). Además, en estos casos, el eje se desvía a la derecha, y aparecen signos de hipertrofia del ventrículo derecho, como es el aumento de la onda R en precordiales derechas (V1-V2) y onda S prominente en precordiales izquierdas (V4-V6) (respuesta 4 CORRECTA). El patrón S1Q3T3 que se aprecia en la imagen es indicativo de sobrecarga de cavidades derechas. En este caso la sobrecarga es debida a la HTP, pero recordad que también puede aparecer en un TEP (sobrecarga el VD debido precisamente a aumentar la presión pulmonar).

8. Pregunta vinculada a la imagen nº 8:

Hombre de 45 años, asintomático y sin antecedentes clínicos de interés. En un electrocardiograma rutinario de una derivación que se realiza por una revisión en el trabajo se observan, cuando se estaba registrando la derivación DIII, los hallazgos que se muestran en la imagen (tira superior). Se decide actitud expectante, y al siguiente año el mismo paciente vuelve a pasar la revisión del trabajo. En el ECG realizado aparece ahora (cuando estábamos registrando la derivación DI) los hallazgos que se muestran en la imagen (tira inferior). El resto del ECG es normal. El paciente refiere que el último mes se ha mareado un par de veces estando sentado, pero que se le ha pasado rápidamente; no ha presentado otros síntomas. Es derivado a un cardiólogo, que realiza un ecocardiograma en la consulta que es normal. ¿Cuál sería ahora la actitud más adecuada?:

1. Hay que realizar una coronariografía.
2. Iniciar amiodarona.
3. Realizar un ECG Holter de 24 horas para valorar un registro electrocardiográfico durante más tiempo.
4. Implantar un DAI (desfibrilador automático implantable).

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El primer ECG muestra extrasístoles ventriculares monomorfos (con la misma morfología, sin otros hallazgos de interés). Las extrasístoles ventriculares son un tipo de arritmia muy frecuente que puede aparecer hasta en el 60% de los adultos. En el ECG aparecen como complejos QRS prematuros, anchos, sin onda P que les preceda. Cuando aparecen en pacientes sin cardiopatía, no empeoran el pronóstico, y no está indicado su tratamiento. Sólo deben tratarse si son sintomáticas o tienen muchísima densidad (por ejemplo, >10000 al día). En estos casos se emplean betabloqueantes, calcioantagonistas o la ablación. Por ello, tras el primer ECG se llevó a cabo una actitud expectante. Por el contra-

rio, en el segundo ECG el paciente presenta ahora varias EV seguidas, esto es, una taquicardia ventricular monomorfa no sostenida (TVMNS). Al contrario que las EV aisladas, la presencia de TVMNS no es habitual en pacientes sanos y hay que sospechar una causa subyacente, la más frecuente de las cuales sería la cardiopatía isquémica. Pero realizar una coronariografía de entrada no estaría indicado, sería mejor realizar una prueba de detección de isquemia no invasiva (por ejemplo, una ecocardiograma de esfuerzo). Además, el paciente comenta episodios sintomáticos (mareo) estando en reposo sentado, lo cual ante los hallazgos del ECG debe hacernos pensar en que algún episodio de taquicardia ventricular ha podido ser sintomático o sostenido. Por lo tanto, entre las opciones que nos ofrecen lo más indicado sería hacer un ECG Holter de 24 h y comprobar así la densidad de extrasístoles o si aparecen eventos arrítmicos que se asocien a síntomas (correlacionar síntomas con la aparición de la taquicardia), ya que, si existen síntomas en relación con la arritmia habrá indicación de tratamiento.

9. Pregunta vinculada a la imagen nº 9:

Una mujer de 32 años acude a un servicio de urgencias por un cuadro de pérdida de fuerza en ambas piernas y dificultad para orinar de instauración en 48 horas. En la exploración se aprecia un nivel sensitivo asociado a una hiperreflexia difusa con signo de Babinski bilateral. Un año antes fue evaluada en oftalmología por una pérdida de agudeza visual en el ojo derecho que recuperó completamente en 6 semanas. Se realiza RMN de cráneo que se muestra en la imagen. Se decide iniciar tratamiento modificador de la enfermedad. ¿Cuál de los fármacos tiene mayor riesgo de producir leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP)?:

1. Teriflunomida.
2. Acetato de glatiramer.
3. Interferón beta 1-a.
4. Natalizumab.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre el tratamiento de la EM. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una infección grave desmielinizante del SNC por reactivación del virus JC, que se encuentra acantonado en los oligodendrocitos en la mayor parte de la población. Es una enfermedad devastadora y en muchas ocasiones mortal y con gran índice de secuelas neurológicas. Los casos de LMP se producen en el contexto de VIH (deplección de linfocitos T) o bien con el tratamiento con el natalizumab. El natalizumab es un anticuerpo monoclonal contra la integrina, que es la molécula que permite el paso de linfocitos T al SNC. Al no haber linfocitos T en el SNC, la reactivación de este virus se hace más probable. Por tanto, se debe hacer un seguimiento estrecho a los pacientes en tratamiento con este fármaco.

10. Pregunta vinculada a la imagen nº 10:

Acude a su consulta de atención primaria un varón de 46 años con historia de lumbalgia de larga evolución, de predominio matutino y asociada a rigidez. Aporta con él una radiografía que se muestra en la imagen, y que según dice ayudó para llegar al diagnóstico de su enfermedad. En relación a la enfermedad que sospecha, indique cuál es su manifestación extraarticular más frecuente:

1. La nefropatía IgA.
2. La afectación pulmonar intersticial de campos superiores.
3. La uveítis anterior aguda.
4. La uveítis posterior con coriorretinitis.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La Rx muestra sacroilitis bilateral, lo cual junto a la lumbalgia es diagnóstico de espondilitis anquilopoyética. En la Rx vemos las articulaciones sacroiliacas alteradas predominando esclerosis subcondral de tipo reactivo y mayor amplitud de espacios articulares por erosiones óseas, alteraciones que son compatibles con una sacroilitis bilateral. La manifestación extrarticular más frecuente de la espondilitis anquilosante es la uveítis anterior. La espondilitis anquilosante presenta otras manif. extrarticulares, las "10 A": - uveítis Anterior. - insuficiencia Aórtica - Aneurisma de la Aorta Ascendente - Amiloidosis - nefropatía IgA - hipergammaglobulinemia IgA - fibrosis pulmonar Apical - colonización pulmonar por *Aspergillus* - subluxación AtlóAxoidea (aunque esta sea una alteración también típica de la artritis reumatoide) - quistes Aracnoideos

11. Pregunta vinculada a la imagen nº 11:

Paciente varón de 53 años de edad que acude a la consulta por dolor en el primer dedo del pie izquierdo de una semana de duración. La inspección del pie se muestra en la imagen. Entre sus antecedentes personales destaca una hipertensión arterial tratada con diuréticos. Respecto a la patología que presenta el paciente, ¿cuál de las siguientes es FALSA?:

1. La colchicina es muy útil, reduciendo el número y la intensidad de los ataques en pacientes tratados o no con fármacos hipouricemiantes.
2. La disminución del aclaramiento renal de ácido úrico es la causa más común de hiperuricemia.
3. La identificación de cristales de urato monosódico en líquido sinovial permite un diagnóstico preciso de la enfermedad.
4. El inicio del tratamiento hipouricemiente ha de comenzarse en el brote agudo asociado a AINEs.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El cuadro descrito en la pregunta se corresponde con un ataque de gota (podagra o afectación de la primera metatarsofalángica, que es su forma de presentación más frecuente y que se muestra en la imagen). Además, nos dan un dato en el enunciado que nos orienta a pensar en eso y es que el paciente estaba tomando diuréticos, que es la causa identificable más frecuente de hiperuricemia. Es muy importante saber que en la gota el inicio del tratamiento hipouricemiente se debe retrasar hasta que el paciente no tenga dolor. Esperar unas 2-3 semanas después de resuelto el ataque para comenzar el hipouricemiente es suficiente. Si se dan hipouricemiantes en el ataque agudo o inmediatamente tras él, se corre riesgo de precipitar un nuevo ataque de gota.

12. Pregunta vinculada a la imagen nº 12:

Indique de entre las siguientes opciones la que se corresponde con una complicación típica de la fractura que se observa en la imagen:

1. Compresión del nervio mediano.
2. Síndrome compartimental.
3. Lesión vascular de la arteria radial.
4. Embolia grasa.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La Rx muestra una fractura de la extremidad distal del radio con desplazamiento dorsal en la proyección lateral, lo que se corresponde con la denominada fractura de Colles, preguntada hasta la saciedad. Esta fractura es típica de mujeres postmenopáusicas, y ocurre al caer sobre la mano en extensión. Las complicaciones más frecuentes y típicas de las fracturas de la extremidad distal del radio son la consolidación en mala posición, la compresión del nervio mediano y el síndrome de Sudeck. Además, en el caso concreto de la fractura de Colles debéis recordar la rotura del tendón extensor largo del pulgar.

13. Pregunta vinculada a la imagen nº 13:

Mujer de 32 años de edad con antecedentes en su juventud de bulimia en tratamiento con antidepresivos y lamotrigina. Acude a urgencias por cuadro de unas semanas de evolución de astenia y aparición de hematomas en extremidades. En el hemograma se objetiva 900 leucocitos/mm³ (5% S; 91% L; 4% M); hemoglobina de 4,3 g/dl; VCM 89 fl; 6000 plaquetas/mm³. En el estudio morfológico no se objetivan formas blásticas. Se realiza biopsia de médula ósea que se muestra en la imagen. ¿Cuál sería el tratamiento más conveniente?:

1. Inmunoterapia con timoglobulina y ciclosporina.
2. Trasfusiones periódicas.
3. Corticoides.
4. Trasplante de progenitores hematopoyéticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La imagen muestra una biopsia de médula ósea con un predominio de adipocitos y un fondo hipocelular. En un paciente con pancitopenia y biopsia hipo-acelular se debe sospechar una aplasia de médula ósea siempre y cuando no presente ESPLENOMEGALIA, ADENOPATÍAS ni FIBROSIS en de médula ósea. Además, el antecedente de tomar fármacos sospechosos sugiere una posible etiología de la enfermedad (hay infinidad de fármacos que pueden causar aplasia de MO, pero tranquilos que no hay que saberlos). En los casos de aplasia medular grave está indicado el trasplante ALOGÉNICO de precursores hematopoyéticos si la edad del paciente y sus comorbilidades lo permiten. En este caso: Mujer joven sin otros antecedentes de interés se debe optar por el trasplante. Recuerda que en la aplasia medular nunca se podrá optar por un trasplante autólogo porque se trata de una enfermedad primaria de la médula que es incapaz de producir las células de las tres series hematopoyéticas. (Respuesta 4 correcta).

14. Pregunta vinculada a la imagen nº 14:

Un hombre de 35 años fue hospitalizado debido a cefaleas, fiebre y confusión. Siete meses antes había recibido un trasplante renal, después de lo cual había recibido fármacos inmunodepresores para evitar el rechazo. Se tomó una muestra de LCR en la que había un recuento de 56 células/mm³ con un 96% de leucocitos polimorfonucleares, concentración de glucosa de 40 mg/dl y concentración de proteínas 172 mg/dl. La tinción de Gram del LCR fue negativa para microorganismos, pero en los cultivos crecieron los microorganismos que se aprecian con tinción de Gram en la imagen. ¿Cuál es la causa más probable de la meningitis de este paciente?:

1. Neisseria meningitidis.
2. Streptococcus pneumoniae.
3. Streptococcus agalactiae.
4. Listeria monocytogenes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La tinción de Gram muestra bacilos gram positivos, que se ven como “bastones” azules/morados (si fueran gram negativos se verían de color rosa). Esta pregunta se contesta simplemente conociendo como se ven en la tinción de Gram las distintas bacterias que aparecen en las opciones. Veamos cada opción. 1. Incorrecta. El meningococo es un diplococo Gram negativo (no un cocobacilo Gram +) 2. Incorrecta. El neumococo es un coco Gram positivo (no es un cocobacilo) 3. Incorrecta. Es un coco Gram +. 4. Correcta. Recordad que la Listeria es un bacilo o cocobacilo Gram + (los bacilos Gram + que hay que saberse para el MIR son Listeria, Clostridium y Bacillus). Recordad que pese a llamarse “Listeria monocitogenes”, la pleocitosis mononuclear típica es

infrecuente y lo más frecuente es una pleocitosis neutrófila (como el resto de bacterias “normales”).

15. Pregunta vinculada a la imagen nº 15:

Paciente que acude a su consulta de atención primaria por aparición de lesiones cutáneas palmoplantares que se muestran en la imagen. Con respecto a la entidad que sospecha, todas las siguientes respuestas son ciertas, EXCEPTO:

1. Erupción de comienzo brusco y de predominio acral.
2. Generalmente en el mismo paciente las lesiones son monomorfas.
3. Coincide con un brote activo de herpes simple.
4. Es infrecuente en niños y ancianos.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La imagen muestra lesiones en diana palmares, características del eritema multiforme. El eritema multiforme consiste en una erupción de inicio brusco, de predominio acral (respuesta 1 verdadera), poco frecuente en niños, jóvenes y ancianos (respuesta 4 verdadera). Las lesiones pueden adoptar diferente morfología (por eso se llama multiforme) pero dentro de un mismo paciente las lesiones suelen ser monomorfas (respuesta 2 verdadera). La opción claramente FALSA es la 3, pues el eritema exudativo multiforme no siempre se relaciona con el VHS, y cuando lo hace, no aparece al mismo tiempo que el brote de herpes, sino unos días después, pues aparece por mecanismo inmune.

16. Pregunta vinculada a la imagen nº 16:

Paciente de 52 años de edad que acude a consulta manifestando que desde hace tres días nota visión borrosa con molestias en el ojo derecho que se acentúan cuando está en lugares muy iluminados o en la calle si hace sol. Al ser explorado encontramos una discreta hiperemia conjuntival y tras la tinción con colirio de Fluoresceína sódica observamos los hallazgos que se muestran en la imagen. Esto nos sugiere que estamos ante:

1. Queratitis bacteriana.
2. Queratitis vírica.
3. Queratoconjuntivitis epidémica.
4. Queratitis por acanthamoeba.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En la imagen se aprecia una figura lineal ramificada de unos 5 mm de longitud sobre la córnea central, esto es, una úlcera dendrítica. Nos describen la clínica típica de una queratitis: ojo rojo doloroso, con inyección ciliar, fotofobia, y visión borrosa por afectación a la transparencia de la córnea. La tinción con fluoresceína (que nos muestra los déficit epite-

liales), nos orienta a su etiología. La queratitis vírica cursa con úlceras epiteliales dendríticas (ramificadas), y suele estar causada la mayoría de las veces por VHS, o bien por Herpes zóster. (Respuesta 2 CORRECTA). No se trata de una queratitis bacteriana, pues en este caso se observaría un infiltrado corneal grisáceo e incluso hipopión (respuesta 1 falsa). Tampoco se trata de una queratitis por Acanthamoeba, pues no deberían decir que el paciente es portador de lentes de contacto (respuesta 4 falsa). Por último, no se trata tampoco de una queratoconjuntivitis epidémica, que cursaría con clínica de conjuntivitis, con secreción serosa y reacción folicular acompañante, siendo muy típica la presencia de una adenopatía preauricular (respuesta 3 falsa).

17. Pregunta vinculada a la imagen nº 17:

Un paciente de 43 años diagnosticado de sinusitis un mes antes, acude a Urgencias por una crisis tónico-clónica generalizada. La familia refiere que durante la semana anterior se había quejado de cefalea y vómitos. En la exploración el paciente se encuentra somnoliento. Se realiza fondo de ojo que se muestra en la imagen. El resto de la exploración era normal. El diagnóstico más probable, en este caso, CONTRAINDICARÍA:

1. Iniciar tratamiento empírico con antibióticos.
2. Iniciar tratamiento anticomitial.
3. Realizar punción lumbar diagnóstica.
4. Iniciar tratamiento con Dexametasona.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El fondo de ojo, que incluye la papila del nervio óptico pero no la mácula, muestra edema de papila: la papila pierde sus bordes, que se ven borrosos, y se encuentra sobre-elevada e hiperhémica, con congestión vascular por dilatación venosa. Lo más importante en esta pregunta es recordar las contraindicaciones de la punción lumbar: TCE, Cáncer o tumor cerebral, focalidad neurológica, HTIC/papiledema, disminución del nivel de conciencia e inmunodepresión o ADVP. Podría tratarse de una encefalitis o absceso cerebral (antibióticos) o un tumor con efecto masa por edema (dexametasona). Para el diagnóstico etiológico realizamos un TAC y para evitar las crisis daremos tratamiento anticomitial.

18. Pregunta vinculada a la imagen nº 18:

Mujer de 50 años diagnosticada hace 6 meses de síndrome mieloproliferativo, que presenta desde hace una semana una erupción en cara y zona del escote que se muestra en la imagen; se acompañan de fiebre de 39,5°C. En la analítica sanguínea destaca además leucocitosis neutrofílica. El diagnóstico de sospecha es:

1. Erisipela.
2. Candidiasis.
3. Síndrome de Sweet.
4. Eritema multiforme.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En la imagen se aprecian placas eritematosas, de aspecto infiltrativo-edematoso. En el MIR, cuando nos hablan de lesiones cutáneas, habitualmente en cara y escote (DERMATOSIS), neutrofilia (NEUTROFÍLICA) y fiebre (FEBRIL), aparecidas de forma AGUDA, lo juntamos todo y tenemos la solución a la pregunta: dermatosis neutrofílica febril aguda, también llamado síndrome de Sweet. Suelen ser preguntas fáciles porque te dan todos los datos, como en este caso, pero hay que ser pillo para saber agruparlos! Recordad que se trata con corticoides sistémicos, y que se puede asociar a tumores generalmente hematológicos, siendo más frente la leucemia aguda mieloide.

19. Pregunta vinculada a la imagen nº 19:

Varón de 47 años de edad, pescador de profesión, que cuatro días después de volver de capturar marisco presenta fiebre, escalofríos, las lesiones que se aprecian en la imagen en la mano derecha, así como linfangitis y linfadenopatía epitroclear y axilar ipsilateral. El agente etiológico más probable es:

1. Streptococcus pyogenes.
2. Aeromonas hydrophila.
3. Clostridium perfringens.
4. Vibrio vulnificus.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las características epidemiológicas y clínicas de este paciente sugieren una infección de la herida causada por V. vulnificus. Recuerda que la presencia de celulitis, ampollas, necrosis, linfangitis y linfadenopatía son característicos.

20. Pregunta vinculada a la imagen nº 20:

El diagnóstico radiológico más probable según la imagen radiológica mostrada es:

1. Obstrucción intestinal.
2. Perforación intestinal.
3. Cáncer de colon.
4. Íleo paralítico.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

En esta radiografía se ven todos los signos de una obstrucción intestinal (OI). Hay asas de intestino delgado dilatadas y organizadas, con edema de pared que crea un patrón en pilas de monedas. Lo que no se objetiva es aire en colon ni en ampolla rectal por lo que podría ser una OI completa. Es una imagen básica que hay que saber identificar con facilidad porque es una patología frecuente que ha sido preguntada y es susceptible de volver a ser preguntada.

21. Pregunta vinculada a la imagen n° 21:

Acude a urgencias un paciente de 82 años, hipertenso con cardiopatía hipertensiva, diabético tipo II en tratamiento oral y obeso, por disnea de reposo asociada a aumento de edemas e intolerancia al decúbito. Refiere que lleva una semana con tos, febrícula y expectoración amarillenta; no aqueja dolor pleurítico ni dolor anginoso. En la exploración muestra TA 155/75, FC 94, saturación de oxígeno 88% basal, ingurgitación yugular, edemas en ambos MMII hasta rodillas, auscultación cardiaca con ritmo de galope R3, auscultación pulmonar con crepitantes bibasales e hipofonesis en base izquierda. Se realiza una radiografía que se muestra en la imagen. ¿Qué descripción se corresponde con esta imagen radiológica?:

1. Infiltrado basal izquierdo con derrame asociado, sugerente de infiltrado neumónico.
2. Infiltrado perihilar bilateral con cardiomegalia y derrame asociado, sugerente de insuficiencia cardiaca.
3. Infiltrado perihilar bilateral con derrame asociado, sugerente de neumonía atípica bilateral.
4. Atelectasia basal izquierda con derrame asociado, sugerente de TEP.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Tenemos una radiografía (de un varón, puesto que no hay silueta mamaria, y operado del corazón, puesto que hay cerclajes esternales) con una silueta cardiaca un poco ensanchada, con infiltrados alveolares perihiliares bilaterales, y derrame pleural bilateral de franco predominio derecho. Luego pienso como primera opción en insuficiencia cardiaca.

22. Pregunta vinculada a la imagen n° 22:

Atiende usted en urgencias a un varón de 57 años, fumador, hipertenso, obeso, colecistectomizado, con angina estable, que acude por cuadro de dolor torácico izquierdo, punzante, no irradiado, acompañado de tos con expectoración verdosa. Refiere sensación distérmica con escalofríos, no termometrada. En la exploración se encuentra sudoroso, febril, taquicárdico a unos 90 lpm, eupneico a unos 18 rpm sin trabajo respiratorio; no se auscultan crepitantes ni sibilancias. Realiza usted una radiografía, obteniendo la imagen mostrada. ¿Cómo describiría los hallazgos?:

1. Atelectasia de lóbulo inferior izquierdo.
2. Infiltrado alveolar en lóbulo inferior izquierdo.
3. Infiltrado alveolar en lingula.
4. Infiltrado alveolar en lóbulo superior izquierdo.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

En esta radiografía no se aprecia bien ningún infiltrado evidente en los campos pulmonares. Pero fíjate bien en la silueta cardiaca. Tiene una zona de mayor densidad, y si te fijas atentamente veras que aunque se insinúa el contorno del diafragma izquierdo, realmente no se ve completamente la línea hasta llegar al mediastino. Eso nos informa de que hay un infiltrado superpuesto al corazón. Los infiltrados superpuestos al corazón son difíciles de diagnosticar si no se buscan activamente. Pueden ser anteriores al corazón (lingula) o posteriores (lóbulo inferiores). Cuando están en lingula, contactan con el corazón, por lo que hacen signo de la silueta con éste y se pierde el contorno cardiaco izquierdo. En cambio, cuando son posteriores no hacen signo de la silueta con el corazón y puede verse silueta con el diafragma. Es lo que se llama neumonía retrocardiaca, y es difícil de diagnosticar en la placa posteroanterior, siendo necesaria la lateral para obtener seguridad diagnóstica.

23. Pregunta vinculada a la imagen n° 23:

Varón de 60 años con antecedentes de tabaquismo importante, hipercolesterolemia y cardiopatía isquémica, acude a consultas externas de dermatología por aparición súbita de múltiples lesiones cutáneas asintomáticas principalmente en tronco, que se muestran en la imagen. Dichas lesiones tienen una superficie untuosa al tacto. El diagnóstico más probable sería:

1. Melanoma maligno con satelitosis cutánea.
2. Síndrome de Gorlin.
3. Hiperpigmentación medicamentosa.
4. Queratosis seborreicas.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Se aprecian múltiples placas verrucosas, de superficie rugosa, untuosas al tacto, bien delimitadas y de tamaño variable, con tapones córneos en superficie, lo cual es característico de la queratosis seborreica.

24. Pregunta vinculada a la imagen n° 24:

Cuartigesta, de 28 años, alcanza dilatación completa tras un periodo de dilatación estrictamente normal. Al pasar a prueba de parto el registro cardiotocográfico, que se obtiene mediante monitorización interna, se muestra como el de la imagen. Al tacto vaginal descubre una presentación longitudinal, cefálica y bregmática o de sincipucio, en transversa derecha, que alcanza con los pujos maternos un II plano de Hodge. Señale la actitud obstétrica más adecuada:

1. Dejar evolucionar el período expulsivo del parto.

2. Realizar una cesárea.
3. Abreviar el periodo expulsivo mediante un fórceps.
4. Abreviar el periodo expulsivo mediante una ventosa.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Registro tocográfico sin aceleraciones y con variabilidad casi silente, que obliga a abreviar el periodo expulsivo de parto. Como es una presentación cefálica transversa derecha y II plano, sólo cabe la cesárea como única opción

25. Pregunta vinculada a la imagen nº 25:

Mujer de 36 años que es traída a urgencias por haber presentado su primera crisis comicial, que según refiere el médico que la atendió en la ambulancia se ha acompañado de pérdida de consciencia con período postcrítico posterior del que ya se ha recuperado. La paciente no recuerda nada de lo sucedido. La exploración neurológica es normal. Usted no encuentra evidencia de que haya existido relajación de esfínteres, pero observa una mordedura en el borde anterolateral derecho de la lengua. La imagen corresponde a la TC craneal que se realizó. A la luz de su diagnóstico de presunción, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Se trata de una lesión ocupante de espacio intraparenquimatoso cerebral.
2. En ocasiones pueden hallarse calcificaciones en estos tipos de tumores, formando los llamados cuerpos de Psammoma.
3. El tumor más frecuente en mujeres es el meningioma, aunque en términos globales el tumor cerebral primario más epileptógeno es el oligodendroglioma.
4. Este tumor no suele captar contraste en anillo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Técnica de examen: todas las respuestas orientan a meningioma excepto al primera, ya que sabemos que el meningioma es un tumor de la meninge y no del parénquima. Como seguramente has adivinado se trata de un meningioma a nivel frontotemporal izquierdo. RESPUESTA 1: incorrecta, si te fijas el tumor es extraparenquimatoso, de bordes nítidos, y no invade estructuras cerebrales aunque sí las comprime. El resto de respuestas son verdaderas. Aprovecha para repasar las lesiones cerebrales que captan contraste en anillo (metástasis, glioblastoma, linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central, toxoplasmosis y absceso cerebral).

26. Pregunta vinculada a la imagen nº 26:

Remiten al servicio de urgencias desde su residencia a una paciente que ha sufrido una caída mientras caminaba. Se trata de una paciente

de 91 años con antecedentes de cardiopatía isquémica en tratamiento con AAS 100 mg/24, diabetes mellitus en tratamiento con Insulina, insuficiencia renal crónica, deterioro cognitivo moderado dependiente para el aseo y camina con un bastón. Se realiza la radiografía que se muestra en la imagen. Señale el tratamiento más adecuado:

1. Se trata de una fractura intracapsular y se debe realizar una osteosíntesis con tornillos canulados.
2. Debido a la comorbilidad del paciente realizaremos tratamiento conservador de la fractura mediante reposo en cama 3-4 semanas y movilización posterior progresiva según dolor.
3. Debido a la comorbilidad del paciente debemos realizar un tratamiento mínimamente invasivo para causar el menor daño adicional posible, además esta fractura permite realizar este tipo de tratamiento quirúrgico.
4. El tratamiento de elección en este tipo de fracturas es el enclavado endomedular o un dispositivo tipo tornillo deslizante-placa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la fractura nos muestran una fractura pertrocanterea. En nuestra mente, estas fracturas se operan "SIEMPRE", independientemente de la edad y comorbilidades (salvo que estemos ante una muerte inminente, y ya estaríamos hablando de otra cosa), por lo que la patología de la paciente no constituye una contraindicación para realizar tratamiento quirúrgico (opción 2 incorrecta), además el paciente, aunque dependiente, camina con un bastón. Respecto al tratamiento de elección, como dice la opción 4, se puede optar por un enclavado endomedular (+++) o por un dispositivo tipo tornillo-placa deslizante. Aunque el concepto de la opción 2 no es incorrecto, hemos de procurar ser lo menos agresivos con el paciente, la opción 4 es claramente verdadera. La osteosíntesis con tornillos canulados (opción 1 falsa) es el tratamiento de las fracturas subcapitales no desplazadas y en el paciente joven.

27. Pregunta vinculada a la imagen nº 27:

Una niña de 11 años, natural de Siria pero que vive en España desde hace 10 años, acude a Urgencias de su Hospital por aumento del perímetro abdominal junto con ortopnea y disnea de esfuerzo que ha sido progresiva hasta el reposo durante los últimos 5 días. A la exploración física se encuentra disneica y taquipneica, sudorosa, con PA de 70/30 mmHg y FC de 123 lpm. Se realiza un ecocardiograma; en la imagen se muestra una proyección apical 4 cámaras del mismo. ¿Cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA?:

1. El seno "y" del pulso venoso estará disminuido o ausente.
2. La presión venosa yugular estará aumentada.
3. Durante la inspiración, en el ecocardiograma veremos el septo interventricular desplazarse hacia el ventrículo derecho, comprimiéndolo.
4. Existirá pulso paradójico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Nos encontramos ante un derrame pericárdico severo en el ecocardiograma (el espacio que existe entre el corazón, sujeto por su pedículo al pericardio, y el pericardio parietal que vemos rodeando a la imagen por fuera, es derrame pericárdico), con la AD colapsada y con signos clínicos de compromiso hemodinámico como son la hipotensión arterial y los signos de descarga adrenérgica asociados (taquicardia, palidez, diaforesis...). Por tanto, existe sospecha de taponamiento cardíaco y sólo faltaría para confirmarlo la presencia de una presión venosa yugular aumentada, signo de aumento de las presiones venosas al estar las cavidades derechas del corazón (que trabajan a baja presión) comprimidas por la presión que genera el líquido pericárdico. La curva de presión venosa del taponamiento tiene un seno "x" prominente y un seno "y" disminuido o ausente. Otro signo clásico del taponamiento cardíaco es el pulso paradójico; al inspirar el paciente aumenta el retorno venoso a cavidades derechas, y la presión de dichas cavidades, aumentada extrínsecamente por la presión del líquido pericárdico, empuja el septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo (opción 3 correcta): el llenado del VI disminuye, y por tanto el volumen sistólico también disminuye, con lo que la PAS conseguida disminuye; si tomamos el pulso al paciente, veremos cómo durante la inspiración es más débil que durante la espiración. Por último, el ECG típico del taponamiento mostrará voltajes bajos (cualquier cosa que se interponga entre el corazón y la piel disminuirá los voltajes obtenidos en el ECG de superficie, como puede ser grasa -obesos-, agua -derrame pericárdico- o colágeno/fibrosis -miocardiopatías restrictivas, especialmente la amiloidosis-); el signo ECG más típico (aunque es infrecuente) del taponamiento es la alternancia eléctrica, que consiste en la variación de la amplitud de los QRS de latido a latido como consecuencia de la oscilación del eje eléctrico del corazón al "nadar" éste en el líquido pericárdico y poderse mover dentro del mismo al latir ("swinging heart").

28. Pregunta vinculada a la imagen nº 28:

Niño de 2 años con fiebre de 6 días de evolución de 39 °C acompañado de poliadenopatías, poliartralgias, dolor abdominal, eritema palmar y plantar y lesiones mucocutáneas en cara (ver imagen). Su actitud sería:

1. Paracetamol 7 días. Evitar administrar ácido acetilsalicílico por riesgo de síndrome de Reye.
2. Prednisona a dosis altas y después pauta descendente.

3. Salicilatos a 80-100 mg/kg/día inicialmente y gammaglobulinas intravenosas
4. Amoxicilina-clavulánico durante 7 días vía oral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El paciente cumple criterios diagnósticos de enfermedad de Kawasaki: fiebre, conjuntivitis, labios eritematosos u secos, adenopatía cervical, y eritema palmoplantar. El tratamiento de la enfermedad de Kawasaki se basa en gammaglobulina iv + salicilatos para prevenir la aparición de aneurismas coronarios.

29. Pregunta vinculada a la imagen nº 29:

Mujer de 63 años, que acude a consulta por presentar, en las últimas semanas, torpeza en la mano derecha y pérdida de fuerza en la pierna homolateral de inicio insidioso. Añade, en la entrevista clínica, cierta dificultad para tragar desde dos meses atrás, especialmente para líquidos. En la exploración neurológica, la motilidad ocular extrínseca está conservada, y el resto de nervios craneales no muestra alteración objetivable. El reflejo nauseoso está conservado, así como la sensibilidad y la coordinación. Como parte de la exploración, usted pide al paciente que realice la pinza manual, representada en la imagen. Usted encuentra, además, un balance muscular de 3/5 en prácticamente todos los grupos musculares del hemicuerpo derecho, donde también observa una marcada hiperreflexia, con respuesta cutáneo-plantar extensora. Usted conoce, además del diagnóstico de sospecha, que una de las siguientes es INCORRECTA:

1. Es frecuente encontrar alteraciones sensitivas y cognitivas al inicio de la enfermedad.
2. No esperaría encontrar alteración esfinteriana en estadios iniciales.
3. Las fasciculaciones linguales son un hallazgo típico de esta entidad clínica.
4. Es probable que los mismos síntomas progresen y se desarrollen en el hemicuerpo izquierdo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La ELA es una enfermedad que cursa con una tetraparesia progresiva asimétrica (primero comienza una extremidad y sucesivamente va a añadiendo otras partes del cuerpo) en la que encontramos en la exploración datos de primera motoneurona (Babinski, hiperreflexia) y de segunda motoneurona (imagen: atrofia del primer interóseo de la mano derecha, muy típica). No suele asociar alteraciones de esfínteres, sensitivas ni cognitivas.

30. Pregunta vinculada a la imagen nº 30:

El gráfico que observe en la imagen se utiliza para:

1. Medir el efecto clínico de los diversos estudios incluidos en un metaanálisis.
2. Medir la heterogeneidad de los estudios incluidos en un metaanálisis.
3. Medir la calidad de los estudios incluidos en un metaanálisis.
4. Medir el sesgo de publicación de un metaanálisis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos presentan un funnel plot, que como sabéis, sirve para medir el riesgo de sesgo de publicación de un metanálisis.

31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el papilomavirus humano (HPV) NO es cierta?:

1. Los serotipos 16 y 18 son los causantes del 70% de los cánceres de cérvix uterino.
2. La vacuna tetravalente ha demostrado disminución del riesgo de neoplasia de cérvix en mujeres no infectadas previamente.
3. La inmunidad que se adquiere ya se ha comprobado que es de por vida.
4. La vacuna tetravalente también reduce el riesgo de lesiones vaginales asociadas al HPV en mujeres.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El HPV es un ADN virus epiteliotrofo que tiende a invadir las células epiteliales del cuello uterino situadas en la zona de transformación. Las cepas oncogénicas más frecuentes son la 16 y la 18. Las cepas no oncogénicas (6 y 11) son las causantes de patologías no malignas como los condilomas acuminados del periné. También es el agente etiológico causal de otras neoplasias como la de vulva, vagina, ano y algunas de la cavidad oral. La vacuna tetravalente protege de la infección y por tanto de cualquier patología relacionada con ellas frente a las cepas 6,11,16 y 18. Pero la protección se limita siempre que no se esté previamente infectada por alguna de ellas. Si ya existe infección protegerá solo de las cepas no infectadas y tampoco de la patología que se pueda desarrollar por la infección. No se ha demostrado que la inmunidad sea a largo plazo.

32. ¿Cuál de las siguientes se considera una pauta preferente para el tratamiento del VIH en nuestro país?:

1. Rilpivirina más emtricitabina (FTC) y Tenofovir alafenamida (TAF).
2. Elvitegravir-cobicistat más emtricitabina (FTC) y Tenofovir alafenamida (TAF).

3. Efavirenz más emtricitabina (FTC) y Tenofovir alafenamida (TAF).
4. Dolutegravir más emtricitabina (FTC) y Tenofovir alafenamida (TAF).

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Cualquiera de ellas son válidas, tal y como se recogen en las guías GESIDA para el tratamiento del VIH. Sin embargo solo la opción 4 es una pauta preferente puesto que ha demostrado ser una pauta aplicable a la mayoría de los pacientes y que en ensayos clínicos aleatorizados han mostrado una eficacia superior frente a otras o mostrando no-inferioridad presentan ventajas adicionales en tolerancia, toxicidad o un bajo riesgo de interacciones farmacológicas. Las otras dos pautas preferentes serían raltegravir más FTC/TAF o Dolutegravir más abacavir/lamivudina.

33. Paciente de 46 años en tratamiento desde hace 1 año con fenitoína. Se encuentra bien controlado y sin ninguna otra sintomatología. La dosis administrada es de 100 mg/8 h y la última dosis administrada fue hace 8 horas previa a la extracción. Se obtiene un nivel de 6.50 (Rango terapéutico de 10-20 ug/mL). ¿Qué actitud tomaría con el paciente teniendo en cuenta ese nivel?:

1. Reduciría el intervalo entre dosis.
2. Cambiaría de fármaco.
3. Aumentaría la dosis.
4. Mantendría la misma pauta.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

No hay que modificar la pauta por varias razones: la primera porque es normal que esté por debajo del rango ya que la pauta es cada 8h y la extracción se hizo 8h después de la última dosis. El rango terapéutico se define en el pico de dosis (4h en este caso). Por otro lado nos dicen que lleva un año con ese tratamiento y está asintomático y bien controlado. ¿Por qué cambiarlo?

34. Paciente de 69 años de edad, recibió un trasplante ortotópico de corazón hace 10 años. Se encuentra en tratamiento estable con tacrólimus, 3 mg cada 12 horas, y dosis bajas de prednisona. Hace cinco días presentó un cuadro respiratorio agudo, para el que se le indicó tratamiento con claritromicina, 500 mg/12 horas, por vía oral. Acude a urgencias con temblor, disminución del nivel de conciencia y lenguaje incoherente. Se objetivó una concentración en sangre de tacrólimus 13 horas tras la administración de 20,1 ng/ml. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica más plausible?:

1. Dada la edad del paciente y los antecedentes, es probable que presentara insuficiencia renal,

- que empeoró por la infección respiratoria y que es responsable del cuadro clínico.
- La dosis de claritromicina administrada fue elevada para la probable insuficiencia renal del paciente, acumulándose y dando lugar a los síntomas referidos.
 - Los síntomas relatados son frecuentes con concentraciones sanguíneas elevadas de tacrólimus, como es el caso, por lo que puede pensarse que se ha estado administrando durante mucho tiempo una dosis demasiado elevada del inmunosupresor.
 - La claritromicina ha podido inhibir la eliminación de tacrólimus, máxime si se ha administrado una dosis no ajustada a la función renal del paciente, y la acumulación de este fármaco es la responsable de la situación.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una intoxicación por tacrólimus debido a que la claritromicina es un inhibidor del complejo de citocromos y por tanto disminuye el metabolismo de los fármacos que se administran conjuntamente.

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la Dosis Diaria Definida (DDD) es FALSA?:

- Es la mejor forma de estimar el consumo de un medicamento.
- La DDD debe considerarse como la dosis recomendada por la comunidad científica.
- Es una unidad internacional de medida establecida por la OMS.
- Suele expresarse como DDD/1000 habitantes/día.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Para posibilitar el análisis cualitativo y cuantitativo del consumo de medicamentos se definió la Dosis Diaria Definida (DDD) que corresponde a la dosis diaria media de mantenimiento de un fármaco para su principal indicación. La referencia a un determinado ámbito geográfico y temporal indica el número de Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (n° de DDD/1.000Habitantes/Día) o DHD, que permite comparar consumos de diferentes ámbitos. Para medir el consumo farmacéutico con este parámetro —número de DDD—, se debe calcular previamente la cantidad de principio activo expresada en unidades físicas (mg, UI, etc.) y luego dividir esa cantidad por la DDD asignada a ese principio activo, expresada en la misma unidad: N° de DDD de p. activo = Cantidad de p. activo en unidades físicas (mg,...) / DDD del p. activo

36. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es el que puede generar un mayor número de interacciones medicamentosas?:

- Ciprofloxacino.
- Ceftazidima.
- Azitromicina.
- Rifampicina.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La respuesta correcta es la 4 (rifampicina) por el potencial de este fármaco para producir interacciones medicamento-sas al activar el citocromo p450. ACTIVADORES DE p450: - Barbitúricos / Fenitoína - Rifampicina - Etanol (otros: tabaco, quinidina) INHIBIDORES DE p450: - Azoles - Macrólidos (especialmente eritromicina; la azitromicina tiene menor capacidad inhibitoria) - Ritonavir - Cimetidina

37. ¿Cuál de los siguientes microorganismos que infectan el tracto intestinal causa bacteriemia con mayor frecuencia?:

- Vibrio cholerae.
- Salmonella enteritidis.
- Campylobacter jejuni.
- Yersinia enterocolitica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Las bacterias citadas son enterobacterias causantes de cuadros de gastroenteritis. La que causa con mayor frecuencia bacteriemia es Salmonella enteritidis y por tanto una GEA en la que se aísla este patógeno hay que tratarla en caso de que exista riesgo de infección metastásica (neonatos, mayores de 50 años por su riesgo de ateromatosis, drepanocitosis, portadores de prótesis articulares o vasculares, inmunodeprimidos). Además, recordad que la bacteriemia recurrente por Salmonella en paciente VIH pertenece a la categoría C.

38. Señale cuál de los siguientes antibióticos no ofrece cobertura frente a Pseudomonas aeruginosa:

- Ceftazidima.
- Ceftarolina.
- Ciprofloxacino.
- Piperacilina-Tazobactam.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Es importante conocer los antibióticos activos frente a Pseudomonas: piper/tazo, ticarcilina/clavulánico, ceftazidima, ceftarolina, carbapenems, monobactámicos, aminoglucósidos, quinolonas -especialmente Ciprofloxacino-, polimixina B y colistina.

39. Ante un cuadro de fiebre de 39°C, cefalea y afectación del nivel de consciencia en un paciente de 16 años, sin inmunodeficiencia conocida ni sospechada, ¿qué determinación en LCR le interesaría menos conocer en un primer acercamiento etiológico?:

1. PCR de herpes virus humano 1 y 2.
2. Aglutinación látex de *Cryptococcus neoformans*.
3. Antígenos bacterianos de *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae* y *Streptococcus pneumoniae*.
4. Gram y cultivo bacteriológico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Ante un caso así deberíamos plantearnos el diagnóstico diferencial entre una meningitis y/o encefalitis. La causa más frecuente de meningitis aguda es la vírica y dentro de los agentes etiológicos los enterovirus (también posible el VHS-2). Como causas bacterianas de meningitis en este rango de edad destacan la *N. meningitidis* como más frecuente, pero también posibles el *H. influenzae* y el *S. pneumoniae*. Dentro de las encefalitis destacar el VHS-1 causa más frecuente si es esporádico y los Enterovirus si cursa en brotes epidémicos. El *Criptococo* es la causa más frecuente de meningitis en el VIH, y rara si no existe ninguna inmunodeficiencia de base.

- 40. En la enfermedad de Alzheimer se produce una degeneración de la corteza cerebral. Las lesiones que se observan en la corteza cerebral, además de las placas seniles, son:**

1. Degeneración neurofibrilar.
2. Cuerpos de Lewy.
3. Espongiosis.
4. Infiltración inflamatoria.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La enfermedad de Alzheimer tiene como diagnóstico de confirmación criterios neuropatológicos. Existe disminución del número de neuronas corticales principalmente a nivel del hipocampo, ovillos neurofibrilares intraneuronales (proteína tau fosforilada), placas seniles o neuríticas extraneuronales (proteína amiloide) y disminución del número de neuronas núcleo basal de Meynert con disminución de la acetilcolina. Los cuerpos de Lewy están presentes principalmente en la demencia por cuerpos de lewy (aquí a nivel neocortical) pero también en la enfermedad de parkinson idiopática (en el tronco encefálico y ganglios basales). La espongiosis es típica de las enfermedades por priones (cretzfeld-Jacob y otras).

- 41. Una de las siguientes características morfológicas, NO corresponde a la glomerulonefritis proliferativa aguda post-estreptocócica:**

1. Afectación difusa de penachos glomerulares.
2. Infiltración glomerular por neutrófilos.
3. Proliferación de células endoteliales y mesangiales.
4. Depósitos mesangiales de IgA.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En la GMN aguda postinfecciosa se observa exudación (PMN) y proliferación celular en todo el glomérulo (difusa) al microscopio óptico. En la microscopía electrónica destacan las denominadas jorobas o "humps" que son depósitos de material electrodens subepiteliales. En la inmunofluorescencia existen depósitos granulares de C3, IgG y fibrina en todas las zonas del glomérulo: subendoteliales y subepiteliales. Los depósitos mesangiales de IgA son característicos de la GMN mesangial IgA (respuesta 4 falsa, por tanto CORRECTA).

- 42. ¿Cuál de estos tumores tiroideos tiene mejor pronóstico?:**

1. Carcinoma folicular de tiroides.
2. Carcinoma medular de tiroides.
3. Carcinoma papilar de tiroides.
4. Carcinoma anaplásico de tiroides.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta teórica, directa y sencilla. El cáncer de tiroides con mejor pronóstico es el Ca. papilar y el segundo en orden el Ca. folicular. El de peor pronóstico es el anaplásico.

- 43. Una mujer de 25 años presenta en una citología cervicovaginal de rutina la presencia de coilocitos. La biopsia cervical demuestra la presencia de CIN de alto grado. Mediante técnicas de hibridación se pone de manifiesto la existencia de HPV tipos 16-18. ¿Cuál es la significación biológica y pronóstica de este hallazgo?:**

1. Que el genoma vírico se halla integrado en el ADN celular del huésped y que el riesgo de desarrollo de un carcinoma invasivo es alto.
2. Que existe ya un carcinoma microinvasor.
3. Que el ADN viral permanece en forma episómica libre en la célula huésped y que el riesgo de desarrollo de carcinoma infiltrante es muy alto.
4. Que el ADN viral permanece en forma episómica libre en la célula huésped y que el riesgo de desarrollo de carcinoma infiltrante es bajo.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El HPV invade la célula epitelial del cuello uterino y puede dejar su ADN en forma de episoma (sin unirlo al genoma del huésped) (es lo más frecuente) o bien insertarlo en el genoma del huésped y poner a trabajar toda la maquinaria celular para producir réplicas de sí mismo. Cuando esto ocurre, se producen las proteínas E (sobre todo E7) que se unen a proteínas supresoras de tumores como la p53. Este es el inicio del proceso carcinogénico. La evolución de la patología pasa por una serie de lesiones que se inician como CIN

(neoplasia intraepitelial cervical) I, II y III, precursores del cáncer cervical in situ y posteriormente del cáncer invasivo. Un CIN III implica gran riesgo de desarrollo de cáncer invasor. Los coilocitos son células cervicales obtenidas por citología que indican infección por el VPH.

44. ¿Cuál de las siguientes venas no pertenece al territorio venoso profundo?:

1. Safena interna.
2. Femoral superficial.
3. Femoral común.
4. Iliaca.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las venas del territorio venoso profundo recogen la sangre de los músculos y huesos y constituye el 80% del retorno venoso de MMII. Las venas superficiales contienen la sangre del TCS y tegumentos y está constituido por la safena interna y externa. La safena interna nace en la cara interior del pie y continua por la cara interna de la pierna hasta desembocar en la ingle en el cayado de la safena interna (triángulo de Scarpa). La safena externa nace en el borde externo del pie y sigue un trayecto posterior hasta desembocar en el hueco poplíteo en el cayado de la safena externa.

45. La arteria hemorroidal superior que irriga al recto es una rama de la arteria:

1. Iliaca externa.
2. Mesentérica inferior.
3. Iliaca interna.
4. Mesentérica superior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La vascularización arterial del recto se realiza a través de tres arterias, que son la arteria hemorroidal superior, rama terminal de la mesentérica inferior, la arteria hemorroidal media, rama de la arteria hipogástrica y la arteria hemorroidal inferior, rama de la arteria pudenda interna. La arteria sacra media nace de la aorta a nivel de su bifurcación dando algunas ramas a la parte inferior del recto y del canal anal.

46. ¿Dónde se origina la arteria coroidea anterior?:

1. Arteria carótida común.
2. Arteria carótida interna.
3. Arteria cerebral media.
4. Arteria cerebral anterior.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La arteria carótida interna forma gracias a sus ramas una de las partes del polígono de Willis cerebral. Da origen a la arteria cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante posterior, la coroidea anterior y la arteria oftálmica. La otra zona del polígono se origina en las arterias vertebrales

que se unen y forman el tronco basilar para bifurcarse posteriormente y dar la arteria cerebral posterior. De las arterias vertebrales surgen la arteria espinal anterior y la arteria cerebelosa posteroinferior o PICA. El tronco basilar origina la AICA (arteria cerebelosa anteroinferior) y la SCA (arteria cerebelosa superior).

47. En el contexto de una lesión en el hemisferio cerebral derecho, el paciente presenta dilatación de la pupila derecha y alteración en los movimientos del ojo derecho. Estos síntomas son debidos a:

1. Herniación subfalcina o subfalcial (cingular).
2. Herniación transtentorial (uncinada, temporal mesial).
3. Herniación amigdalor.
4. Acidosis metabólica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La herniación transtentorial o del uncus supone el desplazamiento de la parte medial del lóbulo temporal hacia la apertura de la tienda del cerebelo, causando compresión del tercer par (el primer signo suele ser una midriasis unilateral y posteriormente oftalmoplejia), hemianopsia homónima contralateral (por compresión de la arteria cerebral posterior), hemiparesia contralateral y coma con rigidez de decerebración por compresión del mesencéfalo (SRAA). La herniación subfalciana supone que la circunvolución cingular (interhemisférica) se desplaza hacia el otro lado por debajo de la hoz del cerebro y puede comprimir la arteria cerebral anterior dando la clínica compatible con este territorio arterial. La herniación amigdalor es el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas hacia el agujero occipital comprimiendo el bulbo. La acidosis metabólica cursa con taquipnea (respiración de Kussmaul), síntomas inespecíficos como astenia y en casos graves alteración de la contractilidad cardíaca.

48. Señale la respuesta correcta en relación a la respuesta inmune:

1. Los 3 principales tipos de tejido linfoide periférico son el bazo, los nódulos linfáticos y el tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT).
2. Los linfocitos y las líneas mieloides derivan de una célula madre mesenquimal pluripotente.
3. Los mastocitos están especializados en la respuesta inmune contra virus y secretan sustancias que alejan a los eosinófilos y basófilos en lugar de inflamación.
4. Los linfocitos T maduran en la médula ósea.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son leucocitos forman parte de la inmunidad innata cuya latencia de acción es de minutos. Los mastocitos intervienen principalmente

en las reacciones de hipersensibilidad tipo I y secretan distintos mediadores entre los que destacan los factores quimiotácticos (atren) a eosinófilos y basófilos. Los linfocitos T proliferan en la médula ósea pero maduran en el timo. Los linfocitos y líneas mieloides derivan de la célula madre multipotente de la médula ósea pero no mesenquimal. Por tanto la verdadera es la 1.

49. Los linfocitos T activados no presentan una de las siguientes moléculas en su superficie:

1. HLA II.
2. CD25.
3. CD 40.
4. Receptor de IL2.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil sobre los marcadores de superficie. Los linfocitos T activados presentan en su membrana todas las moléculas, menos CD40. CD 40 es una molécula de superficie de linfocitos B que se une a CD40-L de los linfocitos T, Esta unión es una unión co-estimuladora encargada de darle la segunda señal a los linfocitos B que requieren para su activación.

50. Señale la respuesta FALSA respecto a las inmunoglobulinas humanas:

1. Las inmunoglobulinas se sintetizan en los órganos linfoides, pero son capaces de realizar su función efectora lejos de su lugar de síntesis.
2. Todos los diferentes isotipos de inmunoglobulinas (IgG, IgA, IgM, IgE, IgD) pueden ser transportados a través de diferentes compartimentos y fluidos, incluyendo la placenta.
3. En sus funciones efectoras, los anticuerpos utilizan tanto la región variable para la unión al antígeno como las regiones constantes de la molécula.
4. Los mecanismos de opsonización mediados por inmunoglobulinas implican la participación de células y receptores ajenos a las células B productoras de anticuerpos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Cuando el linfocito B se diferencia en el centro germinal del folículo linfóide en célula secretora de Anticuerpos migra a la médula ósea donde madura a célula plasmática y secreta anticuerpos al torrente sanguíneo que actúan a larga distancia. La región variable de la Ig tiene la función de unión al antígeno pero la región constante es la que tiene las funciones más importantes: activación de complemento, paso transplacentario, unión a receptores de células... La Ig G es la más importante en la función de opsonización de células fagocíticas como los neutrófilos y macrófagos. La citotoxicidad celular mediada por anticuerpos recae principalmente en la IgG por las células NK, pero también existe una ADCC

por IgE capaces de reconocer y eliminar helmintos. La única inmunoglobulina que atraviesa la placenta es la Ig G.

51. Una paciente de 70 años de edad con antecedentes de asma corticodependiente y cáncer de mama tratado con quimio y radioterapia, ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria severa y patrón radiológico de neumonía intersticial. La analítica revela linfopenia y un número muy bajo de células T circulantes, con CD4/CD8 invertido. ¿Cuál es la causa más probable de la inmunodeficiencia que presenta el paciente?:

1. Un síndrome de Chediak-Higashi con expresión incompleta.
2. Una deficiencia congénita de la molécula CD4 con presentación en la edad adulta.
3. Un cuadro de inmunodeficiencia secundaria.
4. Una deficiencia de moléculas de adhesión leucocitaria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La causa más frecuente de inmunodeficiencia tanto primaria como secundaria es el tratamiento inmunodepresor y anti-neoplásico. Además cualquiera de las cuatro primeras opciones ninguna afectaría al cociente CD4/CD8. La enfermedad de chediak-higashi es una alteración en los lisosomas que son grandes, defectuosos y no se fusionan. La enfermedad granulomatosa crónica supone un defecto en el metabolismo oxidativo a nivel de los neutrófilos, monocitos y eosinófilos y provoca infección crónica por microorganismos catalasa positivos.

52. El control de la expresión de los genes es crucial para la evolución. Señale cuál de las respuestas siguientes es verdadera:

1. Los cromosomas de los humanos y los chimpancés son muy distintos.
2. Las secuencias de ARN mensajero (ARNm) son decodificadas en conjuntos de 4 nucleótidos.
3. Todas las células actuales usan el ARN como su material hereditario.
4. Los genes que codifican para nuevas proteínas pueden ser creados mediante la recombinación de exones.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tradicionalmente se ha dicho que el hombre proviene del mono, pues su material genético difiere escasamente. La traducción consiste en la síntesis de proteínas a partir de mRNA en los ribosomas. Su dirección es 5' a 3' y se basa en el código genético según el cual cada triplete de nucleótidos (codón) traduce un único aminoácido, si bien cada aminoácido puede ser representado por varios tripletes (código degenerado). Existen 20 aa codificados que son transportados por el tRNA. La traducción se inicia con el TRIPLETE AUG (me-

tionina) y termina por UAA, UAG o UGA. Las mayoría de las células usan el ADN como material hereditario. Existen muchos genes afuncionales, es decir, que no se transcriben ni se traducen en proteínas. La transcripción es la síntesis de una molécula de mRNA a partir de otra de DNA. Es un proceso selectivo cuyo punto de inicio está indicado por un promotor (caja TATA), al que se fija el aparato transcriptor. El mRNA está compuesto por secuencias codificantes (exones) y no codificantes (intrones), y posteriormente sufre un proceso de maduración o splicing en el que se pierden los intrones y se le incorporan a su extremo 5' el casquete "cap" y al 3' la cola "poli-A". Por tanto el gen funcional, que se va a traducir consta solo de exones. Recombinando secuencias de exones se pueden crear nuevos genes con nuevas proteínas.

53. Señale cuál de las siguientes respuestas es FALSA con respecto al control genético:

1. Todos los tipos celulares de un organismo multicelular contienen el mismo ADN.
2. Las células de diferentes tipos sintetizan un conjunto de proteínas diferentes.
3. El control genético es muy estricto para evitar mutaciones, lo que implica que cada gen mantiene el control sobre una única proteína.
4. La expresión génica puede ser regulada a varios niveles de la vía que conduce desde el ADN al ARN y a la proteína.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta sería anulable pues aunque la opción 3 es la que han dado como correcta al ser falsa, la opción 1 es discutible pues se sabe que dentro de un mismo organismo pueden existir mosaicismos (diferentes líneas celulares) y el ejemplo más claro es el Sd. de Turner. Cada célula de un mismo tipo expresa una serie de genes activos y por tanto expresa un conjunto de proteínas, de ahí la diferente función de los órganos y sistemas. En el MIR nos encontramos estas preguntas y que finalmente no se anulan por lo que hay que saber buscar la respuesta que más se adecua a lo que nos quieren preguntar.

54. Respecto al surfactante pulmonar es FALSO que:

1. Aumenta la tensión superficial de la superficie del interior alveolar.
2. Reduce el esfuerzo para distender los pulmones.
3. Su secreción en el feto comienza en el sexto/séptimo mes del embarazo.
4. Su déficit puede ser responsable de atelectasias.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El surfactante pulmonar disminuye la tensión superficial del interior alveolar, no la aumenta (la tensión superficial es la fuerza que hace que los alveolos tiendan a colapsarse; el sur-

factante, al disminuir dicha tensión, evita que los alveolos colapsen y los mantiene abiertos para permitir el intercambio gaseoso). Esta formado por una mezcla de fosfolípidos y proteínas, que reduce la tensión superficial y mantiene abiertos los alveolos, reduciendo así el trabajo respiratorio. Se sintetiza a partir del sexto mes, si bien no es detectable en líquido amniótico habitualmente hasta el séptimo.

55. ¿Cuál de los siguientes receptores de la membrana plaquetaria participa en la formación de los enlaces cruzados responsables de la agregación plaquetaria?:

1. Receptor GP Ib.
2. Receptor GP IIb/IIIa.
3. Receptor P2Y12.
4. Receptor P2X1.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

No es rentable estudiarse cada tipo de receptor plaquetario, aunque sí es conveniente saber el GpIb/IX y el GpIIb/IIIa. El primero de ellos interviene en la fase de adhesión plaquetaria al unirse al factor vW subendotelial y su déficit origina el síndrome de Bernard-Soulier o enfermedad de las plaquetas gigantes. El GpIIb/IIIa interviene en la agregación plaquetaria al unir las plaquetas al fibrinógeno y su déficit es la causa de la denominada trombocitopatía de Glanzmann.

56. Un paciente varón de 54 años de edad fue remitido por el médico de Atención Primaria al especialista de Aparato Digestivo por episodios de disfagia para sólidos y líquidos junto a dolor torácico de 2 meses de evolución. Al paciente se le realizó una panendoscopia oral que descartó lesiones neoplásicas y en la manometría esofágica se observó un trazado compatible con una acalasia. ¿Cuál de los siguientes tratamientos le parece el más efectivo?:

1. Medidas higiénicas (comer despacio y dieta blanda) y en los episodios descritos la toma de anticolinérgicos.
2. Inyección endoscópica de toxina botulínica en el esfínter esofágico inferior.
3. Miotomía laparoscópica del esfínter esofágico inferior.
4. Dilatación neumática endoscópica del esfínter esofágico inferior.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ha caído varias veces en el MIR, el tratamiento más efectivo y seguro a largo plazo de la acalasia primaria es la miotomía del esfínter esofágico inferior o de Heller preferentemente por vía laparoscópica +/- técnica antireflujo. Recordad que la técnica diagnóstica de elección es la manometría esofágica. La dilatación con balón tiene una eficacia inicial similar a la cirugía pero a medida que se van haciendo dilataciones

se pierde la eficacia. La inyección botulínica tiene un efecto que dura unos 6 meses. Las medidas higiénicodietéticas y el tratamiento médico son de muy baja eficacia.

57. Mujer de 80 años, con cardiopatía isquémica e HTA, que sigue tratamiento con ácido acetilsalicílico y que refiere un ritmo intestinal con estreñimiento. Acude a Urgencias por comenzar con un cuadro de malestar general y emisión de sangre fresca roja por ano. En la exploración física solo destaca dolor muy leve a la palpación en abdomen, que está blando, y el tacto rectal muestra restos de sangre roja. Presenta Hb 11,2 g/dl, Hto. 35%, urea 55, creatinina 1,2 mg/dl. Colonoscopia: se objetivan restos hemáticos, múltiples divertículos y a nivel de sigma se observa rezumado activo de sangre en un divertículo. Indique cuál de las siguientes respuestas es la actitud más adecuada realizar:

1. Gammagrafía con tecnecio.
2. Suspensión del ácido acetilsalicílico.
3. Hemicolectomía derecha de urgencia.
4. Tratamiento endoscópico del divertículo sangrante.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Estamos delante de la hemorragia digestiva baja de origen diverticular. Es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja en mayores de 65 años una vez se ha descartado la patología rectoanal benigna. La gammagrafía con tecnecio se utiliza en el diagnóstico del divertículo de Meckel (opción 1 FALSA) y la suspensión del ácido acetil salicílico simplemente sirve para disminuir la cantidad pero no es la causante del sangrado (opción 2 FALSA). Los datos analíticos, la exploración física y la ausencia de inestabilidad hemodinámica, nos indican que la hemicolectomía de urgencia no sería la primera opción (y menos derecha si lo que está sangrando es el colon sigmoide). (Opción 3 FALSA). En la mayoría de casos de hemorragia diverticular el sangrado cede espontáneamente, pero en el caso de esta paciente que ya tiene anemia de base y malestar general, lo que nos interesa es parar la hemorragia de la manera menos agresiva posible ya que hemos localizado el punto sangrante (opción 4 CORRECTA).

58. Ante la sospecha clínica de la presencia de un síndrome de sobrecrecimiento bacteriano en un paciente, todas las siguientes afirmaciones son ciertas EXCEPTO una, señale la respuesta FALSA:

1. La biopsia intestinal es la prueba diagnóstica.
2. Presencia de anemia.
3. Déficit de vitaminas liposolubles.
4. Antecedentes de cirugía gastrointestinal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La parte proximal del intestino suele ser estéril, gracias a 3 factores: acidez gástrica, peristaltismo y liberación de inmunoglobulinas. Las causas más frecuentes de sobrecrecimiento bacteriano son: hipoclorhidria por gastrectomía (opción 4 CORRECTA), hipofunción pancreática, hipogammaglobulinemia, alteraciones anatómicas e hipomotilidad intestinal. Se manifiesta por esteatorrea y anemia macrocítica (opción 2 CORRECTA) por malabsorción de vitamina B12 que no se corrige con F. intrínsec y mejora con ATB. (opción 3 CORRECTA). El diagnóstico definitivo se realiza por cultivo del aspirado duodenal o yeyunal cuando se aíslan > de 100.000 bacterias/ml. (opción 1 FALSA) aunque esta prueba en la práctica no se usa. Normalmente, se utiliza la respuesta a antibioterapia (rifaximina o antibióticos de amplio espectro) como medida diagnóstico-terapéutica.

59. En los resultados de las biopsias colónicas obtenidas durante una colonoscopia de despistaje rutinaria, en un paciente de 35 años, con colitis ulcerosa extensa de 17 años de evolución, se aprecia displasia de alto grado, confirmada por dos patólogos con experiencia. El paciente tiene en la actualidad un excelente estado general, estando asintomático desde el punto de vista digestivo. No presenta alteraciones analíticas significativas. Recibe tratamiento de mantenimiento con azatioprina y mesalazina oral a dosis adecuadas, realizando una vida sociolaboral normal. La opción que recomendamos a nuestro paciente será:

1. Plantear asociar tratamiento con metotrexato que potencie el efecto inmunosupresor obtenido ya previamente con la azatioprina, para disminuir el grado de displasia epitelial.
2. Repetir dentro de 4 años la exploración, tranquilizando a nuestro paciente y recomendando que mantenga el mismo tratamiento que venía realizando.
3. Valoración quirúrgica para realización de proctocolectomía precoz.
4. Valoración quirúrgica para realizar resección segmentaria colónica precoz de la zona donde se ha encontrado la displasia grave.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La displasia de alto grado es indicación de cirugía programada independientemente de la actividad de la enfermedad, pues en muchos casos que se detecta displasia de alto grado hay carcinoma in situ en la pieza quirúrgica. Luego nos quedan sólo dos opciones viables (opción 3 y 4). Se realizará cirugía de todo el colon con PROCTOCOLECTOMÍA TOTAL CON ANASTOMOSIS ILEOANAL, conservando el esfínter anal (opción 3 CORRECTA) dado que si realizásemos una colectomía segmentaria dejaríamos colon afecto por colitis ulcerosa que probablemente en los próximos años volvería a complicarse y obligaría a una nueva intervención

60. Un paciente de 42 años acude a la consulta para consultar acerca del cribado de cáncer colorrectal, ya que está preocupado porque un amigo suyo acaba de ser diagnosticado de esta patología. No hay antecedentes de cáncer colorrectal en su familia. ¿Qué estrategia de cribado le parece más adecuada en este caso?:

1. Realizar una colonoscopia inicial a los 45 años y revisiones endoscópicas cada 3 años.
2. Realizar una colonoscopia inicial a los 45 años y revisiones endoscópicas cada 5 años.
3. Realizar una colonoscopia inicial a los 45 años y revisiones endoscópicas cada 10 años.
4. Realizar un test de sangre oculta en heces a partir de los 50 años, con periodicidad bianual.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Actualmente, el screening poblacional en España se realiza a partir de los 50 años con un test de sangre oculta en heces cada 2 años (o bien colonoscopia cada 10 años, pero es de elección el test de sangre oculta en heces). En pacientes con un solo antecedente familiar de primer grado, el criterio de screening es el mismo que para la población general.

61. Un paciente de 39 años está diagnosticado de infección por VIH (grupo B-3) y de cirrosis hepática (alcohol e infección por virus C). Hace 3 meses había tenido un ingreso hospitalario por descompensación edematoascítica. Sigue tratamiento con antirretrovirales, espironolactona y propranolol en profilaxis primaria. ¿Cuál de los siguientes hallazgos de la exploración física es el MENOS probable en este paciente?:

1. Lipoatrofia facial.
2. Ginecomastia bilateral.
3. Reflujo hepatoyugular.
4. Ictericia en escleróticas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Opción 1 CORRECTA. Lipoatrofia facial. Puede ser, como consecuencia de los antirretrovirales, si es que toma AZT o D4T (por ser los más clásicos). Opción 2 CORRECTA. Ginecomastia bilateral. Puede ser, como efecto de la espironolactona o de la cirrosis avanzada. La opción 3 es la más improbable. (FALSA) Para que aparezca reflujo hepatoyugular tienes que tener compromiso de ventrículo derecho, y no hay ningún antecedente de insuficiencia cardíaca en este paciente. Arañas vasculares. Puede ser, como estigma de cirrosis. Opción 4 CORRECTA: La ictericia aparece en pacientes cirróticos cuando la bilirrubina aumenta por encima de 3-4 mg / dL y es un signo de mal pronóstico ya que traduce disfunción hepática importante (recordad que es una variable que se incluye tanto en el Child como en el MELD).

62. Enrique es un varón de 85 años con antecedente de cardiopatía isquémica y portador de dos stents coronarios. Asimismo, tiene antecedentes de EPOC grado C con reagudizaciones frecuentes. Hace 4 meses recibió un ciclo de levofloxacino por una reagudización de su EPOC con resolución de la clínica respiratoria. Tres días tras finalizar el antibiótico comenzó con diarrea abundante, dolor abdominal y febrícula, siendo diagnosticado con los estudios microbiológicos en heces (GDH y toxina) de colitis por *C. difficile*. Inicialmente respondió bien a metronidazol, pero tuvo una recidiva de la infección por *C. difficile* que fue tratada con vancomicina oral. Tras esta recidiva presentó otra, dos semanas después, de mayor gravedad, que motivó el ingreso hospitalario actual y está siendo tratada de nuevo con Vancomicina vía oral. ¿Cuál considera que sería el tratamiento de elección en este caso?:

1. Fidaxomicina.
2. Rifaximina.
3. Anticuerpos antitoxina de *C. difficile*: Bezlotoxumab.
4. Trasplante de microbiota fecal de donante emparentado.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La infección recidivante por *C difficile* es un problema sanitario de primer orden asociado al uso creciente de antibióticos y al envejecimiento de la población. Los pacientes que la padecen suelen ser ancianos y con numerosas comorbilidades. Con cada recidiva, es más probable que los antibióticos no sean efectivos ya que la principal causa de esta infección es la disbiosis (alteración de las poblaciones bacterianas en la microbiota colónica que favorece la proliferación de cepas patógenas de *C difficile* que en condiciones de eubiosis no causan patología alguna) que tiende a agravarse con el uso de antibióticos. En los episodios iniciales se utiliza Metronidazol, Vancomicina ORAL y Fidaxomicina. El trasplante de microbiota fecal ("trasplante de heces") es un procedimiento ampliamente utilizado y efectivo para restaurar la microbiota colónica y curar la infección recidivante por *C difficile*. Este procedimiento está avalado por amplia evidencia científica (y recomendado en guías de práctica clínica) y es el tratamiento de elección a partir de la segunda recidiva (tercer episodio, contando el inicial) de la infección / colitis por *C difficile*.

63. Enfermo de 48 años diagnosticado de cirrosis hepática alcohólica al que venimos controlando desde hace años. No ha conseguido dejar de beber alcohol. Desde hace 2 años presenta ascitis, que responde cada vez peor al tratamiento diurético. En el momento actual toma 120mg/día de furosemida, 300 mg/día de espironolactona y tiene ascitis a tensión. Analíticamente destaca bilirrubina de 4,7 mg/dL, Na 121 mEq/L, K 4,7

mEq/l y creatinina 1,6 mg/dL. ¿Cuál es la actitud terapéutica más correcta en el momento actual?:

1. Proponer entrada preferente en un programa de trasplante hepático.
2. Establecer un régimen de paracentesis evacuadoras periódicas con reposición coloidal.
3. Insertar un TIPS.
4. Aumentar aún más las dosis de diuréticos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta POLEMICA. En un paciente que bebe alcohol sin duda se puede hacer paracentesis periódicas pero un TIPS aumentaría más su supervivencia y trataría mucho más efectivamente la ascitis. Hay bibliografía que apoya la superioridad del TIPS sobre las paracentesis seriadas y más teniendo en cuenta que es un paciente joven que sólo presenta ascitis como descompensación. El aumento de creatinina y de bilirrubina traducen mala función hepática y renal que son contraindicaciones relativas para el TIPS por lo que al final dieron por CORRECTA la opción 2. La opción 1 es FALSA porque está contraindicado el trasplante si aún sigue bebiendo (son necesarios 6 meses de abstinencia) por la escasez de órganos y por la posibilidad de mejoría de la hipertensión portal con la abstinencia del alcohol.

64. Una paciente de 60 años presenta ictericia de varios días de evolución, con coluria y acolia. No refiere ninguna otra sintomatología acompañante, excepto prurito intenso, que le ha llevado a presentar, en la exploración, lesiones cutáneas de rascado. Entre los antecedentes destaca colecistectomía por colelitiasis hace 20 años. En la ecografía abdominal urgente se observa dilatación de la vía biliar intrahepática. La vía biliar distal parece normal y no se visualiza el páncreas por obesidad. El diagnóstico más probable de esta paciente es:

1. Colangitis esclerosante.
2. Estenosis iatrogénica de la vía biliar.
3. Hepatitis colestásica.
4. Colangiocarcinoma hiliar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El colangiocarcinoma hiliar o tumor de Klatskin (opción 4 CORRECTA) se sitúa en la bifurcación de los conductos hepáticos y produce síntomas obstructivos antes que en los tumores de otras localizaciones. Suele debutar entre los 50 y 70 años con ictericia obstructiva indolora. opción 2 FALSA: una colelitiasis residual o una estenosis iatrogénica a los 20 años de la colecistectomía y que den clínica ahora es poco probable. Opción 3 FALSA: No nos dan ningún dato que apunte a hepatitis como aumento de las transaminasas o factores de riesgo. Opción 1 FALSA: la colangitis esclerosante en el MIR casi siempre se asocia a varón joven con CU.

65. Paciente de 81 años que padece cor pulmonale crónico, diagnosticado de cáncer de recto situado a 8 cm del margen anal, de 3 cm de tamaño sin afectación linfática en estadíaje (T1N0) ecografía endorrectal y RM. ¿Cuál es la operación más apropiada?:

1. Resección anterior baja de recto.
2. Amputación de recto.
3. Microcirugía transanal endoscópica (TEM).
4. Escisión local transanal.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los datos epidemiológicos en esta pregunta son la clave. Nos dicen que tiene 81 años y padece cor pulmonale, por tanto tenemos que recurrir a una cirugía lo más mínimamente invasiva que podamos. (opción 3 CORRECTA). La microcirugía endoscópica transanal (MET) es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva que ha emergido porque ofrece varias ventajas sobre la resección transanal tradicional al brindar una visualización y exposición mejoradas, permitiendo la resección más precisa de los tumores localizados entre 2 a 18 cm del margen anal. Esta técnica es primariamente usada para tumores rectales seleccionados (tanto benignos como malignos). Sin embargo, la MET puede también ser usada para tratamiento no curativo en pacientes que no son aptos para una cirugía mayor o cuando el cáncer ha avanzado a un estadio en donde la curación mediante resección radical no es probable. Series prospectivas han mostrado una morbilidad similar, pero una estadía hospitalaria más corta, tasas de resección incompleta más bajas y pocas recidivas, en relación con la resección transanal.

66. El método diagnóstico de elección en coloproctología para evaluar la integridad de los esfínteres del canal anal y el grado de infiltración de las lesiones parietales ano-rectales es:

1. Rectoscopia.
2. TAC pélvico.
3. Ecografía endorrectal/anal.
4. Anuscopya.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Para ver el grado de infiltración tumoral y la integridad de los esfínteres la mejor técnica es la ecoendoscopia. (opción 3 CORRECTA). Los esfínteres anales son tejido muscular por lo que para su visualización hay que utilizar o TC o RM. Su cercanía a la luz intestinal y la inocuidad de la ecografía endoanal hace que está sea la prueba de elección. Recordad que la ecoendoscopia permite la punción-aspiración de masas mediastínicas y delimitar la extensión local de tumores digestivos con gran precisión, sin embargo, no permite la detección de metástasis a distancia, concepto preguntado en el MIR 2007.

67. Paciente de 37 años que desde hace 4 días presenta dolor en región anal y desde hace 2 días fiebre. En Urgencias se le observa una zona indurada, tumefacta, fluctuante y enrojecida en la región perianal derecha. A la presión es muy dolorosa. ¿Cuál es el origen más probable de su patología actual?:

1. Fisura anal.
2. Hemorroides internas.
3. Rectocele.
4. Fístula perianal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de un absceso perianal. Como veis esa opción no aparece entre las respuestas pero si la fístula perianal que es la fase crónica del absceso. (opción 4 CORRECTA). Lo que hay es una fístula que cuando se abscesifica da un cuadro agudo, pero es la misma enfermedad (por lo menos para el MIR, aunque en la vida real hasta un 50% de los pacientes con un absceso no tendrán fístula)

68. ¿Cuál de los siguientes parámetros NO es indicador de gravedad en una hepatitis aguda?:

1. Bilirrubina total mayor de 15 mg/dL.
2. INR de 2.
3. ALT de > 5.000 UI.
4. Hipoglucemia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta es importante fijarse en que nos piden indicadores de gravedad en HEPATITIS AGUDA. Los criterios de Child-Pugh incluyen valores de bilirrubina sérica, albúmina sérica, tiempo de protrombina, presencia de encefalopatía de origen hepático, grado de ascitis, y NO incluyen a la hipoglucemia ni a los niveles de transaminasas entre sus criterios, pero ATENCIÓN: Child-Pugh NO es una clasificación de gravedad de hepatitis agudas, sino de hepatopatías crónicas. No queda muy claro de qué tipo de hepatitis aguda nos están hablando: viral, alcohólica, tóxica... En la hepatitis aguda alcohólica se usa el índice de Maddrey, para discriminar a pacientes que se benefician de tratamiento con corticoides. Incluye tiempo de protrombina (INR) y niveles de bilirrubina. En las hepatitis agudas con insuficiencia hepática son criterios de mal pronóstico la encefalopatía, la hipoglucemia y el alargamiento del tiempo de protrombina (INR). La BR también normalmente va asociado a una peor función hepática. Las cifras de transaminasas NO revelan mayor gravedad de la hepatitis aguda. (Opción 3 FALSA). Recordad que las transaminasas son marcadores de DAÑO hepático pero no de FUNCIÓN hepática.

69. Señale la afirmación FALSA en relación con la resección laparoscópica del colon:

1. Casi todas las enfermedades del colon y recto, susceptibles de tratamiento quirúrgico, se pueden abordar mediante laparoscopia.

2. En la cirugía del cáncer de colon y recto, la disección ganglionar que se puede realizar por laparoscopia es más limitada que la efectuada por laparotomía.
3. En la cirugía del cáncer de colon y recto, las tasas de supervivencia a largo plazo de los pacientes intervenidos por laparoscopia o laparotomía son similares.
4. El abordaje laparoscópico favorece un alta hospitalaria postoperatoria más precoz que tras una resección de colon convencional.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Vuelven a preguntar por la técnica laparoscópica, en este caso hace referencia a las indicaciones de la laparoscopia en los tumores. Actualmente está admitido que la vía laparoscópica puede usarse para tratar tumores siempre que se use una técnica adecuada, para ello en el CCR es necesario reseccionar los ganglios linfáticos que es algo que sí se puede hacer por laparoscopia. (opción 2 FALSA). La única duda podría ser la opción 3 (CORRECTA) pero ya existen ensayos clínicos correctamente realizados que han demostrado que la supervivencia a largo plazo es similar sea cual sea el abordaje que se utilice, lo que es razonable si tenemos en cuenta que la cirugía que se realiza no se modifica por el abordaje utilizado.

70. Indique la respuesta correcta:

1. El signo de Kussmaul es un aumento de la presión venosa central durante la inspiración.
2. Los soplos continuos pueden auscultarse tanto en estenosis como insuficiencias valvulares severas.
3. En el pulso venoso yugular la onda "a" se debe a la distensión venosa producida por la contracción de la aurícula izquierda.
4. El pulso alternante es típico de la miocardiopatía hipertrófica.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre Fisiología cardiaca. Vamos a ir analizando respuesta por respuesta. - Respuesta 1 CORRECTA: el signo de Kussmaul es una elevación paradójica de la presión venosa yugular o central durante la inspiración, presente en pacientes con dificultad para el llenado del ventrículo derecho. Es muy típico de la pericarditis constrictiva, pero aparece también en la miocardiopatía restrictiva, el taponamiento cardiaco o en infartos del ventrículo derecho. - Respuesta 2 falsa: los soplos continuos, que aparecen durante todo el ciclo cardíaco, tanto en sístole como en diástole, se deben a la existencia de un flujo sanguíneo constante a través de una derivación que comunica dos territorios con un gradiente de presión permanente. Aparecen típicamente en el ductus arterioso permeable, a veces en la coartación aórtica, también ante la presencia de fistulas sistémicas o arteriales, y pueden apreciarse asimismo a la auscultación de una rotura de un aneurisma del seno de Valsalva. - Respuesta 3 falsa: el pulso venoso yugular refleja lo que ocurre a nivel del corazón de-

recho, no del izquierdo. La onda a se debe a la contracción de la aurícula DERECHA al final de la diástole (patada auricular). - Respuesta 4 falsa: el pulso alternante, que consiste en la aparición de pulsos fuertes y débiles de forma alterna, se asocia con disfunción miocárdica grave, que aparece por ejemplo en la miocardiopatía dilatada, donde está comprometida la función sistólica. En la miocardiopatía hipertrófica lo que existe es una falta de relajación del ventrículo, una alteración de la función diastólica, por lo que no existen problemas de contracción ventricular.

71. Varón de 70 años, hipertenso mal controlado de larga evolución. Se realiza un ecocardiograma que muestra datos compatibles con cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección del 60%. Respecto a esta entidad es cierto que:

1. La relación E (máxima velocidad de flujo en el llenado rápido) /A (máxima velocidad en la fase de contribución auricular) se eleva por encima de 1 cuando se deteriora la función diastólica.
2. No existe correlación entre el grado de hipertrofia ventricular y la gravedad de las arritmias.
3. La fracción de eyección no se encuentra disminuida en la mayoría de los hipertensos.
4. La mayoría de los fármacos antihipertensivos reducen las cifras tensionales, pero no la masa ventricular izquierda.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La miocardiopatía hipertensiva aparece como una respuesta del corazón a la hipertensión arterial. En un primer momento, el ventrículo izquierdo aumenta su espesor (hipertrofia concéntrica) para compensar la sobrecarga de presión. Pero finalmente, si la sobrecarga continua, el ventrículo termina claudicando, y se dilata (hipertrofia excéntrica). - La respuesta 1 es falsa, pues se trata de una hipertrofia concéntrica que produce insuficiencia cardíaca diastólica (dificultad para la relajación ventricular). Al ventrículo izquierdo le cuesta más relajarse y llenarse normalmente durante la diástole (la onda E se empequeñece), siendo muy importante la "patada auricular" en la última fase diastólica (la onda A cobra importancia, relación $E/A < 1$). Por ello, cuando se pierde esa "patada auricular" (FA), se exacerban los síntomas en estos pacientes. - La respuesta 2 es falsa, pues existe una correlación clara entre el grado de hipertrofia y la aparición de arritmias cardíacas. - La respuesta 3 es CORRECTA, pues la mayoría de hipertensos tienen disfunción diastólica, y no sistólica, y la fracción de eyección se mantiene dentro de la normalidad. - La respuesta 4 es falsa, pues los antihipertensivos, además de reducir la tensión arterial, afectan a diferentes mediadores que contribuyen a la hipertrofia ventricular de forma independiente a la simple respuesta a la sobrecarga de presión. Por ejemplo, se sabe que la angiotensina II, además de su efecto vasoconstrictor y de estimular a la aldosterona y al SNS, tiene por sí sola un efecto mitógeno

sobre los miocitos, contribuyendo directamente al desarrollo de la hipertrofia ventricular. En la imagen se muestra un ecocardiograma transtorácico, proyección paraesternal eje largo, de un ejemplo de cardiopatía hipertensiva severa. Fíjate en el aumento de grosor miocárdico del VI, de forma circunferencial. En la miocardiopatía hipertrófica este engrosamiento miocárdico suele ser más llamativo (llegando incluso a formas extremas) y se suele distribuir de forma irregular (formas septales, apicales...)

72. Paciente varón de 56 años, estudiado por hipertensión arterial hace 9 años, momento en el que se evidenció un bloqueo de rama izquierda en el ECG y se inició tratamiento con un antagonista de los receptores de angiotensina con buen control tensional. Acude a la consulta del cardiólogo refiriendo desde hace 3 meses episodios ocasionales de molestias torácicas, siempre al subir cuestras, y que ceden al detener la marcha. El último de estos episodios le sucedió hace 10 días. ¿Cuál de las siguientes pruebas cree recomendada para la detección de isquemia miocárdica en este paciente?:

1. Gammagrafía cardíaca con Tecnecio 99.
2. Tomografía axial computarizada (TAC) multicorte y angio-TAC.
3. Coronariografía.
4. ECG de esfuerzo en tapiz rodante.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Las pruebas de detección de isquemia miocárdica deben conocerse de cara al MIR. La prueba más empleada es la ergometría, normalmente en un tapiz rodante, que monitoriza al paciente mediante ECG, tensión arterial y frecuencia cardíaca, y considera además la clínica que éste nos refiera. Sin embargo, en ocasiones no es posible emplear la ergometría, debido a que los pacientes son incapaces de realizar esfuerzo físico, o debido a alteraciones basales en el ECG (que es lo que le ocurre a nuestro paciente, que tiene un bloqueo de rama izquierda). (Respuesta 4 INCORRECTA). El bloqueo de rama derecha, en cambio, no contraindica la realización de una ergometría, aunque la hace más difícil de interpretar. En estos casos se recurre a otras técnicas más sensibles, como la gammagrafía de perfusión miocárdica que emplea Tecnecio, un isótopo que se une a las células sanas, y no se fija a células isquémicas ni necróticas. Se puede realizar la prueba estimulando con ejercicio físico, o bien mediante fármacos como dobutamina (inotropo positivo que aumenta la frecuencia y contractilidad cardíaca) o dipiridamol (vasodilatador con efecto de robo coronario). (Respuesta 1 CORRECTA). Otra prueba similar es la ecocardiografía de estrés, para la que también se puede estimular con ejercicio físico o con los fármacos antes mencionados. En este caso se evalúa la contractilidad segmentaria con y sin estrés, mientras también se monitoriza ECG y se evalúa la clínica del paciente. El TAC multicorte se está utilizando ante pacientes de bajo riesgo para descartar la presencia de estenosis

coronaria (su virtud es un alto valor productivo negativo), despistaje de isquemia previo a cirugía de valvulopatías, y en pacientes que tienen un by-pass aortocoronario. No es una prueba habitual de detección de isquemia (respuesta 2 INCORRECTA). Por último, la realización de una coronariografía de entrada se reserva para pacientes con SCASEST de alto riesgo, que no es el caso de nuestro paciente (respuesta 3 INCORRECTA). Se adjunta un ejemplo de ECG con bloqueo de rama izquierda. Fíjate en el patrón rS en V1 y R en V6.

73. En términos de mortalidad, ¿cuál de los siguientes supuestos se beneficiaría MENOS de una coronariografía?:

1. Paciente de 50 años con angina inestable hasta hacerse de pequeños esfuerzos y disfunción ventricular severa en el ecocardiograma.
2. Paciente de 50 años con dolor posiblemente anginoso, refractario a tratamiento médico, con tests no invasivos no diagnósticos para isquemia.
3. Paciente de 50 años en tratamiento médico por cardiopatía isquémica, que presenta angina ocasional de grandes esfuerzos y FEVI conservada.
4. Paciente de 50 años sin angina, pero que se va a someter a una cirugía de reposición valvular aórtica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Vamos a ir analizando cada opción. 1. En pacientes con angina de pequeños esfuerzos, o inestable, y disfunción ventricular severa, la coronariografía puede ser una opción terapéutica (respuesta 1 correcta). 2. Ante un paciente con dolor posiblemente anginoso, pero en el que las pruebas de detección de isquemia no son diagnósticas, está indicada una coronariografía para confirmar o descartar el origen isquémico del dolor (respuesta 2 correcta). 3. Un paciente con cardiopatía isquémica ya conocida que sólo presenta dolor ante grandes esfuerzos y sin disfunción ventricular, es el que menos se beneficia de una coronariografía. Si necesitáramos emplear alguna prueba de detección de isquemia, deberíamos recurrir antes a pruebas no invasivas como la ergometría (respuesta 3 INCORRECTA). 4. Ante todo paciente que vaya a ser sometido a cirugía de sustitución valvular, de más de 45 años en varones o 55 en mujeres, está indicado realizar una coronariografía para despistaje de cardiopatía isquémica que pudiera afectar al curso de la intervención quirúrgica, (respuesta 4 correcta). En caso de presentar lesiones coronarias se realizaría, además de la sustitución valvular, cirugía de revascularización coronaria de los segmentos afectos.

74. La tensión arterial:

1. Mejora si se reduce el consumo de alcohol por debajo de 25-30 g diarios.
2. Supone un factor de riesgo solo si supera 140/90 mmHg.

3. Permanece inalterada durante el día si el sujeto está tranquilo.
4. Si está alta es un factor de riesgo mayor para el desarrollo de insuficiencia cardíaca o ictus, aunque el tabaco supone mucho mayor riesgo para estas 2 patologías.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La hipertensión arterial se define como una tensión arterial mayor o igual a 140/90 mmHg, en mayores de 18 años y sin enfermedad aguda. - Se considera una tensión normal aquella por debajo de 120/80, y se sabe que la prehipertensión, (TA 120-139/80-89) sí que supone un incremento de riesgo cardiovascular (respuesta 2 falsa). - La tensión arterial varía a lo largo del día en función del grado de actividad, el momento del día, el ritmo circadiano... (respuesta 3 falsa). - La HTA se considera un factor de riesgo para ICC o ictus, equiparable al riesgo que representa el tabaquismo (respuesta 4 falsa). - La tensión arterial está regulada por un complejo conjunto de mecanismos, que incluyen tanto al sistema renal como al sistema endocrino y nervioso (sistema renina angiotensina aldosterona, sistema nervioso simpático...). - La respuesta CORRECTA es la 1, pues medidas higiénico-dietéticas como la disminución del peso, el aumento de la actividad física y una dieta baja en sodio, rica en frutas y verduras, disminuyen la tensión arterial y pueden contribuir a su control en pacientes hipertensos.

75. La opción terapéutica más recomendada en el momento actual para el aneurisma de aorta abdominal de gran tamaño en pacientes de alto riesgo quirúrgico es:

1. Resección del aneurisma e injerto quirúrgico convencional.
2. Inducción de la trombosis del saco y by-pass axilo-bifemoral.
3. Tratamiento endovascular con implantación de endoprótesis.
4. Vigilancia del crecimiento aneurismático.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El tratamiento de los aneurismas de la aorta abdominal depende de su tamaño y su sintomatología. El tto conservador está indicado en aquellos asintomáticos menores de 5.5 cm. Para el resto de casos está indicado el tratamiento quirúrgico (tamaño mayor de 5.5 cm, sintomáticos, rápido crecimiento...). Lo más frecuente es que se realice una resección de la parte aneurismática y se implante un injerto de dacrón. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo quirúrgico, lo más recomendable es la colocación de una endoprótesis mediante una técnica percutánea (opción 3 CORRECTA), ver imagen.

76. Paciente de 74 años de edad, sintomático, diagnosticado de estenosis valvular aórtica severa degenerativa calcificada que conserva ritmo sinusal y la función ventricular izquierda dentro de parámetros normales. ¿Cuál cree usted que sería la actitud terapéutica correcta?:

1. No está indicada la intervención por su avanzada edad.
2. Estaría indicada la intervención, pero esperando al deterioro de la función ventricular izquierda.
3. Está indicada la intervención quirúrgica para sustitución valvular aórtica por una prótesis biológica y así evitar la anticoagulación oral.
4. Está indicada la intervención quirúrgica para sustitución valvular aórtica por una prótesis mecánica y posterior anticoagulación oral de por vida.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

En todos los pacientes con estenosis aórtica severa y sintomática, está indicado el tratamiento quirúrgico mediante sustitución valvular por prótesis. Sólo en los niños con estenosis congénitas puede intentarse realizar una valvuloplastia, aunque se trata de una medida provisional. La edad no es una contraindicación para la cirugía. Actualmente en individuos de 75 o más años o con riesgo quirúrgico moderado o alto, o rechazados para cirugía existe la opción de implantar una prótesis aórtica por vía transapical o transfemoral (TAVI). Respecto al tipo de prótesis que emplearemos, las prótesis mecánicas se reservan para pacientes jóvenes (menores de 60-65 años), o que requieran anticoagulación por otro motivo. Estas prótesis son más duraderas, pero requieren anticoagulación de por vida. Las prótesis biológicas se emplean en pacientes mayores (como el de nuestro caso clínico), o bien cuando está contraindicada la anticoagulación crónica. En estos casos sólo se emplea anticoagulación los 3 primeros meses (hasta la endotelización de la superficie protésica).

77. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con referencia al uso de agonistas beta-2 adrenérgicos en crisis de broncoespasmo?:

1. Los beta-2 adrenérgicos carecen de efectos estimulantes cardíacos.
2. Son eficaces por vía oral.
3. Consiguen relajación de la musculatura lisa de vías aéreas de pequeño y gran calibre.
4. Tienen efectos antiinflamatorios bronquiales.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Los agonistas beta son útiles en la crisis de broncoespasmo porque relajan la musculatura lisa del bronquio consiguiendo su dilatación (opción 3 CORRECTA). Es falso que tengan efectos anti-inflamatorios (opción 4 FALSA), para eso se utilizan los corticoides. No son útiles por vía oral (opción 2 FALSA) y por este motivo se administran por vía inhalatoria; en casos graves pueden administrarse intravenoso. Poseen efectos estimulantes cardíacos (opción 1 FALSA), por lo que es típica la taquicardización con el tratamiento. Su potencia es la mayor de todas (mas que anticolinergicos y que corticoides, y muy superior a las teofilinas)

78. Un paciente de 65 años diagnosticado de EPOC, es trasladado al hospital por disnea progresiva y expectoración purulenta. Durante el traslado en la ambulancia se le administra oxígeno y fluidoterapia. A su llegada el paciente está obnubilado y tembloroso. Se auscultan crepitantes en la base derecha. La gasometría arterial muestra un pH: 7,08, pO₂: 90, pCO₂: 106. El tratamiento inicial más adecuado sería:

1. Retirar oxígeno y administrar bicarbonato sódico.
2. Reducir flujo de oxígeno a 1 L/min y administrar bicarbonato sódico.
3. Mantener flujo de oxígeno y administrar acetazolamida.
4. Intubación y ventilación mecánica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos hablan de un paciente EPOC que se ha descompensado, probablemente por una infección respiratoria. Recordad que en estos pacientes la administración de oxígeno debe realizarse de forma cuidadosa nunca superando una FiO₂ del 24-26%, pues si damos oxígeno a concentraciones superiores podemos causar de forma iatrogénica una depresión del centro respiratorio con retención masiva de CO₂, como en el caso de la pregunta. La mejor actitud ante un paciente en insuficiencia respiratoria hipercapnica (PCO₂ > 50) que además tiene disminución del nivel de consciencia es dar soporte ventilatorio mediante intubación y ventilación mecánica. Repasad las indicaciones de ventilación mecánica en el manual de neumología, pues son muy preguntadas. Recuerda que la presencia de alteración del nivel de consciencia, inestabilidad hemodinámica o fatiga muscular son indicaciones clínicas (sin necesidad de gasometría) de ventilación mecánica. La hipercapnia es indicación desde el primer momento de ventilación en la insuficiencia respiratoria hipercápica aguda (PaCO₂>45 mmHg), pero en la insuficiencia respiratoria crónica agudizada la indicación se establece si la hipercapnia es progresiva o cursa con acidez significativa (pH<7,30)

79. Uno de los siguientes hallazgos NO sería esperable en un paciente con antecedente de exposición al asbesto. ¿Cuál es?:

1. Mesotelioma pleural.
2. Adenopatías mediastínicas calcificadas.
3. Atelectasia redonda.
4. Carcinoma broncogénico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La exposición al asbesto puede causar distintas formas de afectación pulmonar, entre las que se incluyen: a) asbestosis (fibrosis) pulmonar, b) lesiones pleurales benignas (placas hialinas, fibrosis y derrame pleural benigno), c) atelectasia redonda, d) mesotelioma maligno pleural y e) carcinoma

broncopulmonar. Como veis las adenopatías mediastínicas calcificadas NO se incluyen en la patología pulmonar causada por asbesto. Aquí os querían confundir con la silicosis donde sí son típicas las adenopatías calcificadas en cáscara de huevo.

80. Hombre de 55 años afectado de carcinoma broncogénico, presenta en la TAC torácica una masa pulmonar de 4 cm de diámetro y adenopatías paratraqueales de diámetro > 1 cm. ¿Cuál de estas propuestas sería la acertada para el planteamiento terapéutico?:

1. Indicación de tratamiento quirúrgico sin más estudios previos.
2. Administración directa de un tratamiento oncológico neoadyuvante.
3. Desestimación definitiva de la indicación quirúrgica.
4. Realización de un TAC-PET y/o video-mediastinoscopia previas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Siempre que nos hablen de adenopatías mediastínicas de >1 cm en el contexto de una masa pulmonar debemos sospechar que dichas adenopatías son metastásicas. Si así fuera, se trataría de un N2 o un N3 (dependiendo de si son paratraqueales ipsi o contralaterales, dato que no se nos ha especificado) de modo que nos encontraríamos con una neoplasia en estadio III, irresecable en casi todos los casos. El hecho de que operemos o no al paciente depende de esas adenopatías. Es por tanto crucial determinar el origen de las mismas, puesto que podrían ser de origen no tumoral convirtiendo de ese modo la neoplasia en un estadio que sí fuera resecable. La forma clásica de explorar los ganglios mediastínicos era quirúrgica mediante mediastinoscopia; hoy sabemos que el TAC-PET ofrece una altísima fiabilidad para distinguir adenopatías neoplásicas de las que no lo son y por ello para muchos se ha convertido en la técnica de primera elección. Otra opción válida sería la ecoendoscopia (EBUS)

81. Un hombre fumador de 50 años, consulta por ronquera, afonía e hipo. En la exploración ORL se evidencia parálisis de la cuerda vocal izquierda como única anomalía. ¿Dónde localizaría la lesión?:

1. Cavum.
2. Mediastino posterior.
3. Lígula.
4. Pleura.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Tenemos a un paciente con parálisis recurrencial, izquierda. Las parálisis recurrenciales se deben habitualmente a infiltración tumoral. El recurrente discurre por el mediastino medio. Un cancer de faringe en el cavum podría lesionar el vago, pero de forma global, no el recurrente pues aun no

se ha separado. La causa más probable sería un tumor del mediastino medio, o invadiendo el mediastino medio. Como no se da la opción, asumimos que un tumor de mediastino posterior podría llegar a invadir el recurrente. Esta pregunta MIR real no es demasiado afortunada, pues no está la mejor opción posible. Un cancer de pulmon puede fácilmente invadir el recurrente por contigüidad si invade el mediastino (y constituye un T4). Un cancer central del pulmon izqdo podría dar esta lesión, pero la opción de lingula no especifica ni que el tumor sea central ni que el tumor esté invadiendo el mediastino medio desde allí.

82. Un paciente fumador diagnosticado de EPOC presenta en la espirometría forzada un volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1) del 31% del predicho, una capacidad vital forzada (FVC) del 80% del predicho y una relación FEV1/FVC del 40%. Según estos resultados, el paciente presenta:

1. Una obstrucción al flujo aéreo GOLD 1.
2. Una obstrucción al flujo aéreo GOLD 2.
3. Una obstrucción al flujo aéreo GOLD 3.
4. Una obstrucción al flujo aéreo GOLD 4.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta requiere dos conceptos: el diagnóstico diferencial entre obstrucción y restricción, y la clasificación de la gravedad de la obstrucción. El patrón espirométrico se interpreta mirando el índice de Tiffeneau (que es el criterio diagnóstico de obstrucción) y la CPT (que es el diagnóstico de restricción). Cuando nos dan una espirometría simple no tendremos la CPT, así que podremos aproximarnos con la CVF. En este caso, la CVF es normal, lo que descarta un componente restrictivo (si estuviera baja no lo diagnosticaría, tan sólo lo sugiere). Por lo que se trata de un trastorno obstructivo aislado, ya que $FEV1/FVC < 70\%$ y la CVF es normal. La segunda parte es establecer la gravedad de la obstrucción. La clasificación que usamos en el EPOC es GOLD, donde un FEV1 entre 30 y 49% es considerado como obstrucción grave (grado GOLD 3).

83. Un paciente de 38 años de edad acude trasladado a nuestro servicio de urgencias tras sufrir una herida por arma blanca a nivel de hemitórax derecho en el octavo espacio intercostal; a su ingreso presenta: tensión arterial de 120/60 mmHg; frecuencia cardíaca de 92 lpm y frecuencia respiratoria de 22 rpm; la auscultación del hemitórax derecho demuestra disminución de los ruidos respiratorios y la percusión del hemitórax demuestra timpanismo. ¿Cuál es la mejor conducta a seguir?:

1. Tomografía computarizada de tórax.
2. Toracotomía urgente.
3. Observación clínica.
4. Radiología simple de tórax y según hallazgos colocación de drenaje pleural.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Tenemos un caso de neumotórax traumático de fácil diagnóstico, tanto por los antecedentes como por la exploración clínica. La exploración que nos dará el diagnóstico es la radiografía de tórax (recordad que en caso de neumotórax de pequeño tamaño es extraordinariamente útil la radiografía de tórax en espiración forzada; en la aplicación se muestra un neumotorax en inspiración y espiración forzadas para que veáis que en espiración se hace más evidente) (opción 1 FALSA). No se sospecha un hemotorax dada la clínica y que el paciente esta estable, luego descartamos la opción de intervención urgente (opción 2 FALSA). En un neumotorax leve se hace observación, en uno extenso el tratamiento consiste en reexpandir el pulmón mediante un tubo de drenaje pleural. La opción CORRECTA es la 4 ya que tenemos que saber la cuantía del neumotórax para saber qué actuación es la más conveniente. (opción 3 FALSA): con cámara apical <3 cm el tratamiento es reposo y observación, y si a los 3 días no se ha resuelto se coloca el tubo con aspiración. En cambio si es >3 cm apical o con clínica grave (inestabilidad hemodinámica o respiratoria) se coloca el tubo en el momento que se diagnostica.

84. En el examen neurológico de un paciente varón de 67 años cuyos antecedentes patológicos usted desconoce, objetiva mediante campimetría por confrontación una pérdida de visión del campo visual del lado derecho. Este hallazgo le hará sospechar:

1. Que ha podido tener un infarto de la arteria cerebral media izquierda.
2. Que ha podido tener un infarto en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda.
3. Que tiene una lesión del nervio óptico derecho.
4. Que tiene una lesión en el quiasma óptico.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Se trata de una hemianopsia homónima derecha: no ve el campo nasal del ojo izquierdo ni el campo temporal del derecho, por lo tanto habrá lesión de las vías visuales por detrás del quiasma (cintillas ópticas, radiaciones ópticas o corteza occipital). Si estuviera afectada la arteria cerebral anterior (opción 2 FALSA) tendría clínica de hemiparesia y hemihipoestesia crural contralateral o bien signos de afectación del lóbulo prefrontal, que son los territorios vasculares que le corresponden. La afectación del nervio óptico derecho daría una anopsia monocular ipsilateral (amaurosis de ese ojo sólo). (opción 3 FALSA). La afectación del quiasma óptico daría una hemianopsia heterónima (se perderían los dos campos nasales o los dos temporales). (opción 4 FALSA). La correcta es la opción 1 ya que la afectación de la arteria cerebral media, como su territorio vascular incluye el lóbulo temporal y parietal por donde transcurren las radiaciones ópticas, su afectación puede manifestarse con una hemianopsia contralateral. También nos podrían decir que se trata de un infarto en territorio de la arteria cerebral posterior izquierda, pero no existe esa opción. Además, nos

gustaría que en este caso nos dijera que existe respeto de la visión macular (aunque no siempre es así).

85. En un paciente de 58 años sin antecedentes de interés que acude a urgencias con una hemiparesia derecha y afasia motora de noventa minutos de evolución, que tiene una glucemia de 132, con una coagulación normal y una TAC craneal sin hallazgos, usted indicaría:

1. Traslado a Unidad de Ictus al estar contraindicada la terapia reperfusora.
2. Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular.
3. Fibrinólisis con rt-PA y trombectomía mecánica, si no hay contraindicaciones para ellas.
4. Fibrinólisis con rt-PA y esperar efectividad clínica. En caso de no mejorar tras 1h, valorar trombectomía mecánica.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Ante una focalidad neurológica brusca, tenemos que pensar que se trata de un ictus. El TC craneal es normal, lo que quiere decir que no es hemorrágico, por lo que tendrá que ser isquémico. Nos refieren que lleva 90 minutos de evolución y no nos indican ninguna contraindicación, por lo que cumpliría criterios para realizar tratamiento reperfusor con fibrinólisis intravenosa y trombectomía mecánica. Los tiempos límite para aplicar la fibrinólisis son $T < 4,5h$ y para trombectomía $T < 6h$ en territorio carotídeo (se puede aplicar también trombectomía en 6-24h de evolución si hay territorio salvable en pruebas de neuroimagen). Actualmente el tratamiento es combinado si no hay contraindicaciones para ninguna de ellas y NO se espera a ver si la fibrinólisis es efectiva para realizar la trombectomía.

86. Una mujer de 26 años acude a urgencias refiriendo una cefalea intensa que ha comenzado bruscamente mientras miraba un escaparate hace 2 h y persiste. La exploración neurológica completa y sistémica son normales. Tiene antecedentes de migrañas, aunque describe este dolor como diferente. Señale cuál de las siguientes es correcta:

1. Esta paciente podría tener un problema urgente con más de un 40% de mortalidad.
2. En este caso, una TAC craneal sería una radiación no justificada y una mala gestión de los recursos.
3. Lo más adecuado sería instaurar tratamiento sintomático con analgesia y remitirla a consultas de Neurología.
4. Una punción lumbar no aportaría nada porque la paciente está afebril.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

CEFALEA INTESA y BRUSCA en el MIR tiene que haceros pensar en HSA. Que no os hagan dudar con los antecedentes de migraña, y más si dice que el dolor es distinto al habitual. Recordad que la causa más frecuente de HSA espontánea es la rotura de aneurismas saculares y que la mortalidad global es del 40-50%, con un 10% el primer día y hasta un 40% el primer mes. De los que sobreviven más de la mitad presentan déficits neurológicos por la hemorragia o sus complicaciones. Por tanto es una patología muy grave, el diagnóstico y tratamiento de la cual no se tiene que demorar (opción 3 FALSA). El TAC es la prueba diagnóstica de elección (opción 2 FALSA) y la primera a realizar, se ven un 95% de las HSA. En el caso de que el TAC sea normal debe hacerse una PL que demuestre la presencia/ausencia de sangre en el LCR. (opción 4 FALSA).

87. Varón de 52 años, fumador, recientemente diagnosticado de carcinoma pulmonar de células pequeñas. Consulta por un cuadro de 2 semanas de evolución que asocia cefalea opresiva fronto-nucal que aumenta con la tos, visión doble binocular en mirada hacia la derecha y episodios de oscurecimiento visual rápidamente transitorio en ambos ojos. En la exploración se pone de manifiesto rigidez nuchal, parálisis del sexto par derecho y papiledema bilateral. Una tomografía computarizada sin y con contraste es anodina. Se efectúa una punción lumbar que da salida a un LCR hipertenso (28 cm de H₂O) claro, con proteinorraquia de 65 mg/dL, glucorraquia de 10 mg/dL (glucemia: 98 mg/dL), ADA normal, ligera pleocitosis linfocitaria (15 células por mm³), cultivos negativos y ausencia de células malignas. Una resonancia magnética con gadolinio muestra captación leptomenígea basal y en la convexidad bilateral. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?:

1. Linfoma del sistema nervioso central.
2. Meningitis fúngica.
3. Meningitis tuberculosa.
4. Meningitis carcinomatosa.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Al leer “recientemente diagnosticado de carcinoma pulmonar de células pequeñas” y clínica de síndrome meníngeo tenéis que pensar en meningitis carcinomatosa. La captación de contraste en las meninges también nos da pistas. La TBC puede dar captación en cisternas basales pero es más raro que lo haga a nivel de la convexidad. El hecho de que no haya células malignas es una trampa, ya que la rentabilidad de la punción lumbar para detectar este tipo de células no es muy alta y se debe repetir hasta en 3 ocasiones para descartarla con cierta seguridad. La invasión neoplásica del espacio subaracnoideo suele producirse por vía hematogena por carcinomas o leucemias/linfomas. Los carcinomas más frecuentes son el cáncer de pulmón (microcítico y adenocarcinoma), mama, melanoma, y el del tracto digestivo. Las

leucemias son más frecuentes en niños y más frecuentes las linfoblásticas > mielolásticas. El empleo sistemático de quimioterapia intratecal e irradiación craneal del sistema nervioso como profilaxis ha hecho disminuir la incidencia de meningitis linfoblástica. También hay diseminación leptomenígea en los tumores primarios del sistema nervioso: meduloblastoma, pinealoblastoma, germinoma, ependimoma y glioblastoma. El diagnóstico de la carcinomatosis leptomenígea se basa en el examen del LCR y en la RM. La captación de contraste por las leptomeninges en la RM con gadolinio es muy sensible en las metástasis, sin embargo no es patognomónica de carcinomatosis leptomenígea (DD con hipotensión intracraneal tras PL y meningitis infecciosa). La mayoría de pacientes tienen un LCR patológico aunque no se evidencien células malignas. Los hallazgos de LCR son el aumento de presión de apertura, pleocitosis, hipoglucorraquia y aumento de proteínas, todo ello es inespecífico pero patológico. La demostración definitiva de carcinomatosis leptomenígea se basa en la verificación de células neoplásicas en el LCR. La primera punción lumbar demuestra una citología neoplásica positiva en el 50% de los casos. Esta cifra aumenta hasta el 90% en la tercera punción lumbar y en laboratorios experimentados. La citometría de flujo puede facilitar el diagnóstico de células neoplásicas en el LCR.

88. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos NO son característicos del síndrome de la estenosis del canal lumbar?:

1. Mejoría de los síntomas con la flexión del tronco.
2. Hiperreflexia rotuliana y aquilea bilateral.
3. Claudicación de la marcha.
4. Pulsos pedios presentes.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La degeneración artrósica de las articulaciones entre vértebras ocasiona estenosis del canal lumbar, que comprime las raíces de la cola de caballo. El resultado es que, cuando la columna se mueve, las raíces son comprimidas. Como consecuencia de ello, la persona que sufre esta enfermedad presenta dolor lumbar irradiado a ambas piernas, junto con hormigueo y sensación de pérdida de fuerza, al poco tiempo de caminar, lo que le obliga a detenerse. Con el tiempo, esta distancia que es posible caminar antes de aparecer el dolor se va acortando. La OPCIÓN 2 es falsa porque no puede dar clínica de la motoneurona (hiperreflexia) si lo que se ve afectado son las raíces nerviosas (por debajo de L2 ya no existe médula, solo raíces). El paciente generalmente presenta alivio sintomático con maniobras de flexión y aumentan al estar de pie. A diferencia de la hernia discal, la persona tiende a tener una postura antiálgica en flexión del tronco. Esto se debe a que, al flexionar el tronco, los ligamentos posteriores se estiran, aumentando el diámetro del canal vertebral. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con la claudicación vascular por ateromatosis de las arterias que irrigan los miembros inferiores.

89. Mujer de 60 años que consulta por cuadro de 4 meses de evolución de pérdida de fuerza progresiva en miembros inferiores y disfonía. En la exploración realizada no presentaba fasciculaciones, los pares craneales estaban conservados, no presentaba déficits campimétricos, el balance muscular en miembros superiores estaba conservado aunque presentaba amiotrofia en primer interóseo izquierdo. En miembros inferiores presentaba paresia proximal bilateral asimétrica, estando el miembro inferior derecho a 4/5 y miembro inferior izquierdo a 3/5; a nivel distal presentaba una paresia del grupo anteroexterno derecho a 4/5 siendo el resto del balance normal; las sensibilidades superficial y profunda estaban conservadas, los reflejos osteotendinosos estaban exaltados en los 4 miembros con aumento de área reflexógena siendo la respuesta plantar izquierda extensora y la derecha flexora. Un estudio de resonancia nuclear magnética cerebral y de columna completa de bajo campo fue normal. ¿Cuál sería la actitud más lógica a realizar de inicio?:

1. Solicitar un estudio electromiográfico con estimulación repetitiva por la alta sospecha de enfermedad de placa neuromuscular.
2. Solicitar una bioquímica urgente ante la sospecha de una parálisis hipopotasémica.
3. Determinación de anticuerpos antiGM1 ante la alta sospecha de una neuropatía motora multifocal con bloqueos de conducción.
4. Realizar un estudio electromiográfico con estudio de unidades motoras.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta puede resultar complicada por la longitud de su enunciado y por el gran número de datos semiológicos que aporta. Cuando nos cuenten afectación asimétrica de 1º y 2º motoneurona tenemos que pensar en la ELA. Típicamente presenta amiotrofia asimétrica, debilidad asimétrica y exaltación de los reflejos miotáticos. El hecho de que la paciente no tenga las fasciculaciones típicas de ELA no la descarta, simplemente hace que sea un caso menos típico. En la ELA no hay alteraciones sensitivas, esfinterianas ni cognitivas como norma general. Siguiendo el algoritmo diagnóstico, una vez descartadas otras causas de alteración de la motoneurona con RM normal, la prueba diagnóstica esencial es el EMG donde se objetiva gran denervación. La estimulación repetitiva se utiliza en el diagnóstico diferencial de Miastenia Gravis, Eaton Lambert y Botulismo.

90. Mujer de 78 años, hipertensa, diabética y anticoagulada con acenocumarol por fibrilación auricular. Consulta por un cuadro agudo, sin trauma previo, de intenso dolor cervicodorsal irradiado a miembro superior derecho

que aumenta con las maniobras de Valsalva y debilidad rápidamente progresiva de miembros derechos. En la exploración destaca hemiparesia derecha y síndrome de Horner también derecho. No hay afectación facial. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos le parece más probable?:

1. Hematoma epidural cervical.
2. Aneurisma de aorta ascendente.
3. Hernia de Chiari de tipo I.
4. Trombosis de la arteria vertebral izquierda.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta difícil. Opción 1 CORRECTA: El hematoma epidural espinal espontáneo es una patología infrecuente. Está dada principalmente por neoplasias, coagulopatías, TERAPIAS ANTICOAGULANTES, enfermedad de Paget y malformaciones vasculares. La localización más frecuente la constituye la columna dorsal, siendo su presentación clínica característica un intenso dolor AGUDO con o sin irradiación radicular en ausencia de trauma, continuando con compromiso sensitivo y/o motor que progresa dentro de minutos u horas pudiendo alcanzar la paraplejia. El hecho de que el dolor aumente con las maniobras de Valsalva nos tiene que hacer sospechar de patología con afectación radicular. Opción 2 FALSA: los aneurismas de aorta suelen ser asintomáticos o bien dan a la larga insuficiencia aórtica. Opción 3 FALSA: la malformación de Chiari tipo I (herniación de la parte inferior del encéfalo: las amígdalas cerebelosas y la parte inferior del cerebelo por el agujero occipital hacia el canal vertebral) aunque sea congénita, es asintomática o bien se manifiesta en la adolescencia o en adultos jóvenes dando clínica de cefalea recurrente (no un solo episodio) asociada al Valsalva, dolor cervical y espasticidad PROGRESIVA en casos graves. opción 4 FALSA: los infartos cerebrales no duelen. Además, de ser un infarto en territorio de la arteria vertebral izquierda se produciría una paresia de miembros derechos y un Sd. de Horner izquierdo ya que la vía simpática baja a lo largo de mesencéfalo, protuberancia y bulbo sin decusarse. Posteriormente sale del SNC para ascender a lo largo de la arteria carótida ipsilateral.

91. En relación con las fracturas postraumáticas de la base craneal, es INCORRECTO que:

1. Afectan con más frecuencia la fosa anterior y el peñasco del hueso temporal.
2. La presencia de hematoma periorcular o retroauricular debe hacer sospechar su existencia.
3. La ausencia de salida de líquido cefalorraquídeo por nariz u oído excluye la existencia de brecha dural acompañante y, por tanto, el riesgo de meningitis.
4. El germen más frecuentemente implicado en las meningitis secundarias a brecha dural postraumática es el neumococo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Ya sabéis que la opción que utilice la palabra EXCLUYE en el MIR, nos tiene que hacer sospechar de que esa respuesta es la FALSA. La salida de LCR por el oído o nariz en fracturas de la base del cráneo NO es frecuente y su ausencia no quiere decir que no haya brecha dural. Si aparece es muy sugestivo, pero el que no aparezca no significa que no tenga brecha dural. Este concepto ya se preguntó en el MIR del año 2000, por lo tanto no lo podéis fallar.

92. En un paciente diagnosticado de Enfermedad de Parkinson hace un año todos los siguientes síntomas nos harían dudar del diagnóstico EXCEPTO uno de ellos:

1. Ausencia de respuesta a L-dopa.
2. Asimetría de los síntomas.
3. Incontinencia urinaria u ortostatismo frecuentes.
4. Inestabilidad postural con caídas frecuentes.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Atención: se tiene que marcar la respuesta que es característica de Enfermedad de Parkinson!! opción 1 y 3 FALSAS: aunque la disfunción autonómica puede darse en la enfermedad de Parkinson, es típica de otra patología, la atrofia multisistema (antiguamente se catalogaba en el subtipo Shy-Drager). En la enfermedad de Parkinson lo típico es que haya respuesta al tratamiento con levodopa. Opción 2 CORRECTA: la asimetría de los síntomas es típica del Parkinson. Opción 4 FALSA: parálisis de la mirada hacia abajo y la Inestabilidad postural con caídas frecuentes debe hacernos pensar en parálisis supranuclear progresiva (PSP).

93. Mujer de 62 años que acude a la consulta por presentar dolor en el borde interno del antebrazo y a nivel del dedo anular y meñique de la mano derecha. También explica hormigueos, frialdad y pérdida de sensibilidad. ¿Qué tipo de neuropatía por compresión tiene la paciente?:

1. Compresión proximal nervio cubital.
2. Síndrome del canal carpiano.
3. Sección del nervio cubital.
4. Atrapamiento nervio mediano y cubital a nivel de la muñeca.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil. El dedo anular y meñique están inervados por el nervio cubital y su COMPRESIÓN produce la clínica descrita en el anunciado. Su sección produciría degeneración de la función nerviosa: motora, sensibilidad propioceptiva, tacto, temperatura, dolor y componente simpático por este orden.

94. Un paciente es llevado a urgencias por haber sido hallado desorientado en la calle. Tiene alrededor de 60 años y aspecto descuidado. Huele a

alcohol. La exploración física revela un paciente desorientado, confuso y apático. Está levemente atáxico y presenta múltiples telangiectasias cutáneas. TA: 140/85 mmHg; pulso 84 lpm y frecuencia respiratoria 16 rpm. ¿Cuál de las siguientes medidas sería INCORRECTA en una evaluación inicial en la visita de urgencias?:

1. Punción lumbar tras realización de fondo de ojo.
2. TC craneal.
3. Hemograma completo y bioquímica básica.
4. Administración de glucosado al 5% i.v. y posteriormente tiamina i.v.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Si sospechamos que un paciente tiene encefalopatía de WERNICKE causado por déficit de Vit B1 (alcohólico, atáxico, sdr. confusional...) debemos asegurarnos de que se le administra ANTES TIAMINA que glucosa, ya que la tiamina o vit B1 es un cofactor en el metabolismo de la glucosa y su déficit puede exacerbarse con la administración inicial de glucosa.

95. En una gestante de 20 semanas diagnosticada de hipertiroidismo por enfermedad de Graves-Basedow, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado?:

1. Antitiroideos a dosis altas más levotiroxina para mantener eutiroidismo.
2. Antitiroideos a dosis bajas.
3. Tiroidectomía subtotal
4. Yodo - 131

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La enf. de Graves es muy preguntada en el MIR y conviene dominarla a la perfección. En cuanto a su tratamiento, es muy útil recordar el siguiente esquema: - En < 20 años: 1ª elección: antitiroideos. 2ª elección: cirugía (en el MIR no se usa yodo 131 para evitar teratogenia). - De 20-40 años: 1ª elección: antitiroideos. 2ª elección: yodo131**. - En > 40 años: 1ª elección: yodo131**. 2ª elección: cirugía. - En embarazadas: sólo control sintomático si es posible. Si precisa tratamiento son de elección los antitiroideos. Durante el 1º trimestre propiltiouracilo (menor riesgo de teratogenia); durante el 2º y 3º trimestre metimazol/carbimazol, pues el riesgo de teratogenia es menor en este periodo, mientras que el PTU tiene mayor riesgo de hepatitis tóxica. Si el cuadro es muy grave y no se controla con antitiroideos, la cirugía es el tratamiento de segunda línea.

96. Acude al Servicio de Urgencias una mujer de 56 años con clínica de aproximadamente de 9 meses, de debilidad, cansancio, anorexia, pérdida de peso (4-5 Kg), molestias gastrointestinales (náuseas y vómitos), hiperpigmentación e hipotensión arterial (90/50 mmHg). En la

analítica destacaba: glucemia: 62 mg/dl; sodio, 126 mEq/l y potasio: 5,9 mEq/l. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es correcta?:

1. La impresión diagnóstica es que se trata de una insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison.
2. La causa más frecuente de enfermedad de Addison es la autoinmune, por ello habitualmente no se realizan pruebas de imagen de suprarrenales para el diagnóstico etiológico.
3. Ante la sospecha de insuficiencia suprarrenal primaria, la determinación de cortisol y ACTH basal es lo más sensible para establecer el diagnóstico.
4. La dosis sustitutiva en la insuficiencia suprarrenal primaria es habitualmente de 15-30 mg/día de hidrocortisona en dosis divididas y suele ser necesario también administrar 0'05-0'1 mg de fludrocortisona diarios por vía oral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Para contestar esta pregunta basta con saber una cosa y ser un tío pillo del MIR. Si no sabes lo que tiene la paciente, te lo dice la opción 1 y además todas las demás opciones hacen referencia a esa enfermedad, así que la 1 parece correcta. Las dosis no hay que saberlas para el MIR, así que la 4 también parece correcta. Así que dudamos entre la 2 y la 3, que es donde hay que saber una cosa para decidir: la prueba de diagnóstico más sensible y gold standard en el Addison es el test de ACTH (se mide el cortisol tras dar ACTH, y si no aumenta el cortisol lo suficiente es que las suprarrenales fallan). OJO!! La primera prueba a realizar es la toma del cortisol basal (si es <3 confirma), ¡pero no es la más sensible! En cuanto a la opción 2: antiguamente la TBC era la causa más frec. de insuf. suprarrenal y se hacían pruebas de imagen para demostrarlo (las suprarrenales aparecen pequeñas y calcificadas), pero hoy en día la causa más frec. es la autoinmune y estas pruebas no son rutinarias.

97. En un hombre de 44 años con síndrome de Cushing por un tumor carcinoide bronquial productor de ACTH, qué respuesta es FALSA:

1. El paciente presenta desde hace aproximadamente 6 meses debilidad muscular de predominio proximal, aumento de peso y tensión arterial, cambios emocionales intensos y aspecto cushingoide.
2. En la analítica presentaba una glucemia de 370 mg/dl y una alcalosis hipopotasémica. Los niveles de ACTH eran elevados (350 pg/ml).
3. La resonancia nuclear magnética de región hipofisaria con gadolinio fue normal. El tumor carcinoide se identificó con una TAC torácica.
4. Ante un síndrome de Cushing ACTH dependiente, la prueba de supresión con dosis bajas de dexametasona es una medida útil para el diagnóstico etiológico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada, y que repasa la clínica, diagnóstico y tratamiento del Cushing: para el MIR, lo más importante es el diagnóstico. - Clínica (respuestas 1 y 2 correctas): recordad la obesidad troncular, HTA, hiperglucemia y alcalosis hipopotasémica (efecto mineralcorticoide del exceso de cortisol) que son muy preguntadas. - Diagnóstico (respuesta 3 correcta, la 4 es la falsa): para diagnosticar un Cushing, se hace primero un test de screenig (cortisol en orina o test de supresión con 1 mg de dexametasona -test de Nugent-), y luego se confirma con un test diagnóstico (test de Liddle débil -supresión con 2 mg de dexametasona-, cortisoluria >3 veces lo normal, o cortisol plasmático a las 23 h elevado). IMPORTANTÍSIMO!!! Hay que saber muy bien el algoritmo diagnóstico del Cushing, y saber diferenciar que prueba de supresión es de screening (1 mg -Nugent-), de diagnóstico de confirmación (2 mg -Liddle débil-), o de diagnóstico etiológico (8 mg -Liddle fuerte-). Por tanto, la opción 4 es la falsa porque nos hablan del Liddle débil ("dosis bajas de dexametasona"), que no sirve para el diagnóstico etiológico (se debe usar el Liddle fuerte).

98. Una mujer de 29 años es enviada a la consulta para valoración y para descartar una diabetes mellitus. Como antecedentes familiares, su madre y una tía son diabéticas. Ella tuvo una diabetes gestacional con parto sin problemas. Su talla es de 167cm y su peso de 92Kg; IMC de 34. Aporta una analítica con una glucemia al azar de 135mg/dL. El test de tolerancia con 75g de glucosa oral muestra una glucemia en ayunas de 112mgr/dL, con valor a las 2 horas de 178mg/dL. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es la mejor para esta paciente?:

1. Comenzar tratamiento con metformina.
2. Modificaciones intensivas de su estilo de vida.
3. Comenzar tratamiento con acarbosa.
4. Repetir test de tolerancia a la glucosa al año.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Dificultad moderada. Por la descripción de la pregunta, la paciente tiene glucemia alterada en ayunas (basal entre 100 y 125 mg/dL) e intolerancia a la glucosa (glucemia tras 2 horas de sobrecarga oral entre 140 y 200 mg/dL), pero no reúne criterios de diabetes, que son: - Glucemia al azar mayor o igual a 200 en presencia de clínica cardinal o cetoacidosis - 2 Glucemias basales mayor o igual a 126 - 2 Glucemias tras 2 horas de sobrecarga oral mayor o igual a 200. - 2 Hb glicosiladas $\geq$ 6,5%. - 1 glucemia basal $\geq$ 126 + 1 glucemia tras sobrecarga $\geq$ 200. - 1 glucemia basal $\geq$ 126 + 1 Hb glicosilada $\geq$ 6,5%. - 1 glucemia tras sobrecarga $\geq$ 200 + 1 Hb glicosilada $\geq$ 6,5%. Independientemente de no ser diabética, por prediabetes y su obesidad (IMC > 30) parece evidente que lo mejor será que cambie de estilo de vida (respuesta 2 correcta), pues si no lo hace a la larga acabará desarrollando diabetes. También se tendrá que revisar la glucemia basal anualmente y hacer nuevas pruebas

de sobrecarga oral periódicamente, pero no necesariamente tras 1 año, y además lo prioritario será que cambie el estilo de vida (opción 4 falsa).

99. ¿Qué debemos sospechar ante un paciente con hiponatremia e hiperosmolaridad plasmática?:

1. Hiperproteinemia.
2. Hiperlipemia
3. Hiperglucemia.
4. Anasarca.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El algoritmo diagnóstico de la hiponatremia es MUY IMPORTANTE para el MIR, así que aunque os parezca complicado os lo tenéis que aprender ENTERO (Juanmi ya se encargará de repetíroslo hasta la saciedad). Por cierto, viene en Nefro. Ante un paciente con hiponatremia, lo primero en que nos tenemos que fijar es en la osmolaridad plasmática, que puede ser: - Baja: hiponatremia verdadera (el paciente tiene el Na bajo, y como es el principal responsable de la Osm plasmática, ésta baja). Ejemplo: tratamiento con diuréticos, especialmente tiazidas. - Normal: hiponatremia dilucional: se acumula en plasma una sustancia que arrastra agua, y eso hace que baje relativamente el Na (que cuantitativamente es normal), pero la sustancia no es osmóticamente activa y la Osm es normal. Ejemplos: hiperproteinemia (mieloma...), hiperlipidemia. - Alta: hiponatremia dilucional (como la anterior), pero esta vez se acumula en plasma una sustancia osmóticamente activa, por lo que la Osm sube. Ejemplos: hiperglucemia (respuesta 3 correcta).

100. Está claramente establecido el objetivo terapéutico de un colesterol LDL inferior a 55 mg/dl en el caso de:

1. La presencia de cardiopatía isquémica previa.
2. La presencia de obesidad mórbida (IMC >40).
3. Los varones a partir de los 45 años o las mujeres a partir de los 55.
4. El antecedente de cardiopatía isquémica o ictus previo en un padre o en un hijo si se ha producido precozmente.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Aunque las guías clínicas sobre manejo de las dislipemias están en constante evolución, las indicaciones para tener un LDL < 55 hay que saberlas y son los pacientes considerados de muy alto riesgo vascular: - Cardiopatía isquémica (respuesta 1 correcta): es la principal indicación, incluye el infarto de miocardio, pero también la angina, al enfermedad coronaria significativa y la muerte súbita de causa isquémica resucitada. - Enfermedad cerebrovascular: no solo el ictus de origen aterotrombótico, también el AIT, y la estenosis carotídea asintomática aterosclerótica >50%. - Enfermedad arterial periférica: sea el aneurisma de aorta abdominal como la afectación arterial de miembros inferiores - Insuficiencia renal crónica avanzada (FG < 30 mL/min), recordad

que estos pacientes se mueren de IAM. - Diabetes mellitus (independientemente el tipo) que asocie otros factores de riesgo mayores o lesión de órgano diana.

101. Un paciente de 70 años con obesidad moderada que padece Diabetes mellitus tipo 2, con función renal conservada, no consigue un control adecuado de los valores de glucemia pre y postprandial (glucemias capilares de 200 a 250 mg/dl) con dieta y medidas higiénico dietéticas. Señale la elección más adecuada:

1. Metformina.
2. Dieta estricta hipocalórica e inhibidores de la alfa-glucosidasa.
3. Tiazolidinedionas.
4. Insulinoterapia.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta fácil e imprescindible. Debéis dominar los antidiabéticos orales y la insulina para el MIR (todos los años hay preguntas). En el paciente diabético tipo 2 en el que no se consigue un correcto control glucémico (el objetivo es < 130 de glucemia basal, y < 180 de glucemia postprandial) pese a las medidas higiénico-dietéticas, se deben iniciar antidiabéticos orales, y el fármaco de primera elección en cualquier paciente (y especialmente si es obeso) es la METFORMINA (respuesta 1 correcta). OJO!! En la diabetes tipo 2 el tratamiento se inicia siempre con medidas higiénico-dietéticas, pero si al momento del diagnóstico el paciente está descompensado (clínica cardinal, cetoacidosis, glucemia basal > 250 o glicada muy elevada) está indicada además la insulina hasta estabilizar al paciente.

102. Varón de 56 años, que ingresa en Urgencias obnubilado y deshidratado. Se constata insuficiencia renal y una calcemia de 14 mg/dl (3,5 mmol/L). ¿Qué estrategia terapéutica adoptaría?:

1. Hemodiálisis urgente.
2. Glucocorticoides a altas dosis.
3. Calcitonina subcutánea cada 6 horas hasta controlar la calcemia.
4. Infusión de suero salino, furosemida y difosfonatos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento de la hipercalcemia (Calcio > 10,5) lo preguntan muy frecuentemente, y el orden de actuación es (respuesta 4 correcta): 1º. Suero salino. 2º. Furosemida. 3º. Bifosfonatos (de elección el zoledrónico, sobre todo en causa tumoral). Otros fármacos que se pueden usar son la calcitonina y los corticoides, pero son de segunda línea. Recuerda! La causa más frecuente de hipercalcemia es el hiperparatiroidismo 1º, salvo en el paciente hospitalizado en el que es la tumoral.

103. Respecto a la radiología de ciertas enfermedades reumáticas. Señale la FALSA:

1. En la artritis reumatoide son características las erosiones óseas.
2. La artritis psoriásica se caracteriza por la periostitis y más tarde por la fusión articular.
3. La artrosis disminuye el espacio articular y presenta osteofitos y esclerosis, con aparición de quistes y geodas.
4. El lupus eritematoso sistémico presenta con frecuencia erosiones óseas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Tenéis que conocer que artropatías son erosivas y cuales no, pues al margen de otros datos sobre radiología, simplemente sabiendo eso se contestan muchas preguntas: Las artritis erosivas son: - Artritis reumatoide (respuesta 1 verdadera) - Espondilitis anquilosante en su forma axial (no la periférica!) - Enf. de Reiter - Artritis psoriásica - Artritis sépticas. La artritis del LES no es erosiva (la opción 4 es la falsa) aunque en algunas pacientes sí se describen deformidades articulares, no mediadas por erosión sino por laxitud de tendones, ligamentos y cápsula articular. Una de estas deformidades es la artropatía de Jaccoud que te mostramos en la imagen explicativa. Recordad las descripciones radiológicas de la artrosis que aparecen en la opción 3, pues son muy importantes. En cuanto a la opción 2, la periostitis es típica de las artropatías seronegativas y es la causa de la dactilitis (dedos en salchicha), que es especialmente típica de la psoriasis.

104. Respecto a la Artritis Reumatoide. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. La determinación de los anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado (Anti-CCP) tiene valor en el diagnóstico de la artritis reumatoide de inicio y son más específicos que el factor reumatoide.
2. La manifestación pulmonar más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial, que es asintomática en los estadios iniciales en la mayor parte de los pacientes.
3. Un rasgo característico de la afectación articular periférica es la presencia de un patrón de afectación radial (participación de diversas articulaciones de un mismo dedo, con preservación de las de los otros dedos de manos o pies).
4. Los FAMEs (fármacos modificadores de la enfermedad) tradicionales se asocian con beneficios terapéuticos importantes: mejoran los signos y síntomas y retardan la evolución radiológica.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Vamos a ir analizando cada opción: - Respuesta 1 verdadera. Los anticuerpos anti-CCP sirven como criterio diagnóstico

de artritis reumatoide (AR), especialmente cuando el factor reumatoide (FR) es negativo. Los anti-CCP son más específicos y tienen mayor valor predictivo positivo que el FR. - Respuesta 2 verdadera. Según las últimas series, La manifestación pulmonar más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial. Puede haber fibrosis pulmonar en los enfermos con AR, que se revela con crepitantes secos tipo velcro y con un patrón restrictivo en la espirometría. La disnea aparece en estadios más evolucionados - Respuesta 3 falsa. Se tiende a afectar la misma articulación en varios dedos (típicamente la metacarpofalángica y/o la interfalángica proximal), no varias articulaciones del mismo dedo respetando a los demás (que es lo que ocurre en las artropatías seronegativas). De hecho, es típico de la AR el respeto de las articulaciones interfalángicas distales. - Respuesta 4 verdadera. Recordad que los FAMEs se indican desde el momento del diagnóstico como tratamiento crónico, siendo de elección el metotrexate.

105. En relación con los test de laboratorio de inmunología, para el diagnóstico y seguimiento de las Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?:

1. Los anticuerpos antinucleares (ANA) son útiles en el proceso diagnóstico, pero no tienen ningún papel en el seguimiento posterior de estas enfermedades.
2. La presencia de anticuerpos anti-Ro no es diagnóstico de Síndrome de Sjögren primario, pues puede observarse también en otras enfermedades sistémicas.
3. La ausencia o resultado negativo en el estudio de los anticuerpos anti-DNA permite descartar la presencia de un Lupus.
4. La determinación periódica de los anticuerpos anti-DNA y de los niveles del complemento, son útiles en el seguimiento de la actividad clínica del lupus.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Respuesta 1 cierta: los anticuerpos antinucleares (ANA) se usan para el diagnóstico (por ejemplo, son un criterio diagnóstico del LES), pero no son útiles en el seguimiento. - Respuesta 2 cierta: los anticuerpos anti-Ro pueden observarse en varias enfermedades sistémicas, como síndrome de Sjögren, lupus cutáneo subagudo, lupus neonatal. - Respuesta 3 falsa: los antiDNA sólo son 1 criterio más de lupus. Son anticuerpos muy específicos, pero una paciente puede tener un lupus con antiDNA negativos. - Respuesta 4 cierta: para el seguimiento de la actividad clínica del LES se usan especialmente: los niveles de Ac anti-DNAs (OJO! No otros Ac) y la disminución del complemento (especialmente C4).

106. Paciente varón de 54 años de edad, con antecedentes de trabajar en un taller, pintando chapa de coches, que acude al hospital por

cuadro de tos con expectoración hemoptoica de dos días de duración, acompañado de hematuria y disminución de la diuresis en las últimas 24 h. ¿Cuál es la exploración, entre las que se enumeran a continuación, que realizaría en primer lugar para orientar el diagnóstico?:

1. Radiología de tórax.
2. Determinación de siderocitos en esputo.
3. Determinación de ANCAS y anticuerpos antimembrana basal glomerular.
4. Mantoux.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El cuadro clínico de la pregunta (hematuria + hemoptisis) debe orientarnos a un síndrome reno-pulmonar, que puede ser explicado por varias causas aunque las más típicas son las vasculitis y la enfermedad antimembrana basal glomerular, que pueden ser identificables a través de la positividad de los ANCA o los antimembrana basal, respectivamente.

107. Una mujer de 50 años refiere dolor y deformación en las articulaciones interfalángicas distales de ambas manos. La exploración evidencia dolor a la presión en las mencionadas articulaciones y nudosidades. La paciente es diagnosticada de nódulos de Heberden. Señale la FALSA:

1. La artrosis de articulaciones interfalángicas distales predomina en mujeres.
2. La artrosis de articulaciones interfalángicas distales tiene una clara historia familiar, con herencia autosómica dominante en la mujer y recesiva en el varón.
3. Las dos artropatías que afectan con más frecuencia las articulaciones interfalángicas distales son: la artrosis y la artritis psoriásica.
4. La artritis reumatoide debe incluirse en el diagnóstico diferencial de este caso.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La articulación interfalángica distal (IFD) es la más frecuentemente afectada en la artrosis, y es más frecuente en mujeres. Tiene una herencia AD en la mujer y AR en el varón. Suele ser un problema estético con mínima repercusión funcional, pero puede también causar desviaciones en los dedos. (respuesta 1 verdadera). La artritis reumatoide típicamente respeta dicha articulación (respuesta 4 falsa). Otras enfermedades que afectan la articulación IFD son la artritis psoriásica, el Reiter, y la artritis crónica juvenil (OJO! Lo contrario que la AR).

108. Paciente de 46 años que refiere tos no productiva frecuente y disnea tras los medianos esfuerzos, sin ortopnea ni DPN. En la auscultación se objetiva una disminución global del murmullo vesicular y en la radiografía de tórax micronódulos en

todo el parénquima pulmonar y adenopatías mediastínicas e hiliares bilaterales. Tras seguir un tratamiento farmacológico, mejoró su sintomatología, con desaparición casi completa de las lesiones parenquimatosas pulmonares y persistencia de las adenopatías. De los siguientes enunciados, ¿cuál sería el diagnóstico más probable?:

1. Granuloma eosinófilo.
2. Tuberculosis.
3. Silicosis.
4. Sarcoidosis.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Sabiendo 2 cositas se acierta esta pregunta, que parece a simple vista complicada. 1º. Si en el MIR hablan de coexistencia en la placa de tórax de adenopatías hiliares + patrón intersticial (o nodulillar, reticulonodulillar, etc), debemos plantearnos 3 opciones: TBC, sarcoidosis, silicosis. La asbestosis tendría afectación pleural, y en el granuloma eosinófilo (histiocitosis X) nos hablarían de quistes y nódulos. 2º. La respuesta al tratamiento de la sarcoidosis: sólo se trata si hay afectación del parénquima pulmonar o síntomas persistentes (como en nuestro caso) con corticoides, y si responde, la afectación parenquimatosas cede pero las adenopatías permanecen (ver imagen adjunta en la aplicación). La silicosis no tiene ningún tratamiento eficaz (la descartamos). Todavía podría ser TBC, que también mejoraría con tratamiento, pero nos deberían dar en el enunciado algún dato clínico que nos hiciera inclinarnos por ella (fiebre, sudoración nocturna, datos de microbiología...), y la tos probablemente sería productiva. Así, nos inclinamos finalmente por la sarcoidosis (respuesta 4 correcta).

109. Un varón de 58 años de edad, trabajador manual, presenta dolor de características mecánicas y a veces de reposo en su hombro derecho, de 20 días de evolución que mejora con tratamiento antiinflamatorio no esteroideo. A la exploración, la movilidad de la columna cervical es normal y no dolorosa. El hombro presenta una limitación de la rotación interna y dolor a la elevación del hombro de más de 90°. La radiología simple ofrece un ascenso de la cabeza humeral y signos artrósicos leves y la ecografía una bursitis sin rotura del tendón supraespinoso. ¿Cuál de las siguientes actuaciones está CONTRAINDICADA?:

1. Aconsejar una prótesis de hombro.
2. Realizar una infiltración con anestésico local y corticoide en el espacio subacromial.
3. Solicitar una resonancia magnética del hombro.
4. Evitar los excesos de levantamiento de peso.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de la artrosis tiene una serie de pasos sucesivos (siendo de todos modos lo más importante y lo primero el tratamiento higiénico de descarga articular y la fisioterapia) - Primero se emplea tratamiento médico: analgésicos (paracetamol de primera elección, añadiendo opiodes débiles como codeína o tramadol si no hay respuesta clínica y especialmente en el anciano (los tolera mejor que los AINEs clásicos), y de segunda elección AINEs clásicos, que pasan a 1ª elección si hay mucha inflamación o derrame). - Si el paciente no responde, se pueden probar infiltraciones de corticoides (OJO!! nunca se usan por vía sistémica) en las bursas o espacios articulares. Nunca infiltrar en el espesor de tendones por riesgo de degeneración tendinosa incluso rotura. - Y por último, y sólo si el paciente no responde a la analgesia de ningún modo y la artrosis es GRAVE (en nuestro caso es leve) se indicaría la cirugía, en general con artroplastia. Así, en nuestro paciente que responde bien al tratamiento con analgésicos y la artrosis es leve, no se debe indicar una prótesis (opción 1 correcta).

110. Un mecánico de 40 años se produce una herida al escapársele un destornillador con el que hacía fuerza y clavársele en la palma de la mano izquierda. En la exploración se aprecia déficit de flexión de las articulaciones interfalángica proximal y distal del tercer dedo y sangrado continuo. Se debe sospechar:

1. Lesión de ambos tendones flexores y arcada arterial.
2. Lesión del tendón flexor profundo y arcada venosa.
3. Lesión de ambos tendones flexores y arcada venosa.
4. Lesión del tendón flexor superficial y arcada arterial.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Para el MIR, hay que saber 3 cosas sobre los cortes en la mano. 1º. Los tendones extensores van por el dorso, los flexores por la palma, y los interóseos por las caras laterales de los dedos. 2º. El sangrado venoso es continuo, mientras que el arterial es pulsátil (respuestas 1 y 4 incorrectas). 3º. Qué movimientos se afecta cuando se lesionan los tendones extensores y flexores. - Cuando se lesionan los extensores, se afecta la extensión del dedo en general (si la lesión ocurre a nivel de la interfalángica distal (IFD), aparece dedo en martillo, y si ocurre a nivel de la interfalángica proximal (IFP) aparece dedo en ojal). - Cuando se lesionan los flexores, hay que distinguir entre la lesión del flexor superficial y la del flexor profundo: la lesión del flexor superficial impide la flexión de la IFP del dedo en cuestión, y la lesión del flexor profundo impide la flexión de la IFD (OJO!! Es al revés de lo que parece!). Así, la respuesta correcta es la 3 porque el paciente no flexiona ni la IFP ni la IFD

111. En la revisión primaria de un paciente que ha sufrido un traumatismo torácico y presenta taquipnea, ausencia de ruidos respiratorios en el lado derecho, hipotensión y venas del cuello distendidas. Lo más prioritario es:

1. Radiografía de tórax.
2. Intubación orotraqueal.
3. Mascarilla facial con reservorio de oxígeno.
4. Drenaje hemitórax derecho.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta sobre el manejo ABCDE del paciente politraumatizado. Si no sabéis donde ubicar cada intervención de las que puedan poner en las respuestas (en la A, B, C...), recordad este orden del inicial ABC, con el que se contestan la mayoría de las preguntas: 1. Vía aérea permeable (liberar la oclusión que provoque la lengua o cuerpos extraños). Ojo!! Esto no es lo mismo que intubar; sólo algunos pacientes tienen indicación de intubar, en general pacientes inconscientes o con Glasgow < 8 (de nuestro paciente no dicen que esté inconsciente): respuesta 1 incorrecta. 2. Resolver neumotórax (respuesta 4 correcta; sospechamos neumotórax por la ausencia de ruidos respiratorios en un hemitórax y el antecedente de traumatismo). Debemos realizar un drenaje del hemitórax derecho urgente para asegurar la respiración. 3. Oxígeno (respuesta 3 incorrecta) 4. Control de hemorragias 5. Cuidado de amputaciones y evisceraciones 6. Fluidoterapia.

112. Paciente de 55 años, cirujano general en activo, con antecedentes de hipertensión, diabetes y angina inestable, traído a la Urgencia tras una caída en bicicleta. Radiográficamente presenta una fractura intracapsular desplazada del fémur proximal. ¿Cuál será el tratamiento más adecuado?:

1. Artroplastia parcial de cadera.
2. Reducción y osteosíntesis con tornillo-clavo deslizante.
3. Reducción y osteosíntesis con tornillos canulados.
4. Artroplastia total de cadera.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta fácil. Es muy importante conocer el algoritmo de tratamiento de las fracturas de cadera: - Fractura extracapsular (pertrocantérea): siempre osteosíntesis con clavo o placa deslizante - Fractura intracapsular (subcapital): en el paciente joven activo (< 65 años) se hace osteosíntesis con tornillos canulados (respuesta 3 correcta), en el paciente > 65 años, depende del desplazamiento ó Garden (I-II, no desplazadas: osteosíntesis con tornillos canulados; III-IV, desplazadas: artroplastia).

113. En el curso de la Enfermedad Renal Crónica, la instauración de nicturia suele significar que:

1. El riñón aumenta la diuresis para mantener el filtrado glomerular normal.
2. Se ha asociado una alteración en la secreción de ADH.
3. El mecanismo de concentración de la orina persiste intacto, aunque esté reducido el filtrado glomerular.
4. La función renal se ha reducido a la mitad aproximadamente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Debes conocer bien los estadios de insuficiencia renal crónica (IRC), ya que son preguntados ampliamente en el MIR dada su importancia en el manejo de estos enfermos y en la vigilancia de aparición de complicaciones asociadas: - Estadio I (riñón normal): FG 90-120 ml/min - Estadio II (ERC leve): FG de 60-90 ml/min. - Estadio III (IRC moderada): FG 30-60 ml/min. Cursa con elevación de creatinina y productos nitrogenados, nicturia (es uno de los primeros síntomas de la IRC e implica pérdida de la función isostenúrica) (respuesta 4 CORRECTA), anemia por déficit de eritropoyetina (- Estadio IV (IRC grave): FG 15-30 ml/min. Aparece hiperpotasemia, acidosis e hiperfosforemia. Asimismo, aparece sintomatología urémica inespecífica (náuseas, vómitos, astenia....) - Estadio V (IRC terminal): FG < 15ml/min o tratamiento renal sustitutivo. Aparece hipertensión arterial volumen dependiente, hiponatremia dilucional y clínica urémica específica y grave (encefalopatía urémica, pericarditis urémica, polineuropatía urémica...).

114. Un paciente de 48 años acude al hospital por un cuadro de fiebre de 40°C, dolor lumbar izquierdo y disuria, con una tensión arterial de 90/50 mm Hg. En la analítica de sangre destaca: Na 137 mmol/l, K 5.1 mmol/l, Cl 103 mmol/l, pH 7.42, HCO₃ 12 mmol/l, pCO₂ 20 mmHg, creatinina 1.6mg/dl. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es cierto?:

1. Acidosis mixta con anión gap elevado.
2. El paciente no presenta alteraciones del equilibrio ácido-base, ya que el pH es normal.
3. Acidosis metabólica con anión gap elevado y alcalosis respiratoria.
4. Alcalosis metabólica asociada a acidosis respiratoria.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Recuerda que $pH = HCO_3/CO_2$. El paciente tiene una acidosis ($pH < 7.35$) metabólica ($HCO_3 < 22$), parcialmente compensada por una alcalosis respiratoria ($CO_2 < 35$, está hiperventilando para compensar). Recuerda también que ante cualquier acidosis metabólica debes calcular el anion gap (valores normales de 8-16), para distinguir entre mecanismo

por ganancia de ácidos orgánicos (anion gap elevado) o por pérdida de bicarbonato (anion gap normal). El paciente tiene anion gap elevado ($Anion\ gap = Na - HCO_3 - Cl = 22$) (respuesta 3 CORRECTA).

115. Un paciente de 60 años portador de una válvula protésica mitral acude por un cuadro de fiebre, hipertensión arterial, disnea progresiva y oliguria. En la analítica se constata una creatinina sérica de 680 micromol/l (7,6 mg/dl), sedimento urinario con hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, y proteinuria de 2.8 g/24 horas. El estudio inmunológico mostró C3 sérico descendido y ANCA negativos. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?:

1. Glomerulonefritis membranosa.
2. Insuficiencia renal prerrenal.
3. Glomerulonefritis extracapilar con vasculitis necrosante.
4. Glomerulonefritis proliferativa difusa endocapilar.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para contestar las preguntas de GN debes mayoría de preguntas de caso clínico, hay que ir descartando en este orden: 1) Tipo de síndrome (S. nefrótico/al menos "edemas", S. nefrítico/al menos "hematuria"); 2) Causas de hipocomplementemia; 3) Resto de datos. CON RESPECTO A ESTA PREGUNTA: 1) Es un síndrome nefrítico (HTA, fracaso renal, hematuria y proteinuria): puedo descartar la insuficiencia renal prerrenal y la glomerulonefritis membranosa (da nefrótico) 2) Como el complemento está bajo, entre las dos que quedan me decantaré por la GMN proliferativa difusa endocapilar (también llamada GMN postestreptocócica) (respuesta 4 CORRECTA); la GMN extracapilar con vasculitis necrosante se corresponde con la GMN rápidamente progresiva de tipo III (pauciinmune), que suele tener ANCAs positivos y NO da hipocomplementemia. Fíjate además que entre las 4 opciones, la GMN proliferativa difusa es la ÚNICA que causa hipocomplementemia.

116. Un paciente de 66 años, previamente sano, acude a Urgencias refiriendo dolor lumbar bilateral y la aparición de un rash cutáneo, que relaciona con la ingesta en días previos de Ibuprofeno por molestias faríngeas. Analíticamente destaca una creatinina plasmática de 3.4 mg/dl, una hemoglobina de 12.1 g/dl, 9.800 leucocitos/mm3 con 10% de eosinófilos y 379.000 plaquetas/mm3. En la orina se objetiva hematuria microscópica y abundantes leucocitos, sin bacteriuria. Se realizó una ecografía que mostró unos riñones aumentados de tamaño, con buen grosor cortical y sin dilatación de la vía urinaria. Ante estos datos, ¿cuál de los siguientes le parece el diagnóstico clínico más probable?:

1. Enfermedad ateroembólica renal.
2. Enfermedad de membrana basal fina.
3. Nefropatía por analgésicos.
4. Nefritis intersticial por hipersensibilidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El paciente presenta un cuadro sugerente de nefritis intersticial aguda: leucocituria (sin bacteriuria) y fracaso renal agudo; suele ser típica también la proteinuria de bajo peso molecular y ocasionalmente puede aparecer hematuria. El mecanismo es muy probablemente por hipersensibilidad (alérgico): antecedente de exposición a AINE y eosinofilia. Recuerda que es típico el hallazgo de eosinofilia, así como el hallazgo en ecografía de riñones aumentados de tamaño (por el edema intersticial) (respuesta 4 CORRECTA). Su tratamiento es la retirada del fármaco, el soporte renal (hidratación, diuréticos, ...) y en ocasiones se añade corticoides.

117. En la litotricia con ondas de choque extracorpóreas (LEOC), las ondas de choque son generadas por una fuente externa al cuerpo del paciente y luego se propagan hacia el cuerpo y se focalizan en el cálculo. Estas ondas son relativamente débiles y no invasivas, se transmiten a través del cuerpo y llegan a adquirir fuerza suficiente solo en la diana para romper el cálculo. De la siguiente lista de contraindicaciones para este tipo de tratamiento hay una que se considera contraindicación absoluta, ¿cuál de ellas es?:

1. Alteraciones de la coagulación.
2. Hipertensión arterial descontrolada.
3. Embarazo.
4. Obesidad.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las contraindicaciones absolutas son se recuerdan por el acrónimo LEOC - Leucocitosis: infección activa - Embarazo - Obstrucción distal al cálculo - Coagulopatía no corregible

118. Respecto a la bacteriuria asintomática durante el embarazo, señale la afirmación ERRÓNEA:

1. La prevalencia de bacteriuria durante el embarazo se sitúa entre el 4-6%, y es similar a la prevalencia en las mujeres no embarazadas.
2. Aproximadamente un 30% de las mujeres embarazadas con bacteriuria desarrollan una pielonefritis aguda.
3. La fosfomicina trometamol es un antimicrobiano seguro durante la gestación.
4. El tratamiento de la bacteriuria asintomática durante el embarazo disminuye la incidencia de pielonefritis y cistitis durante el embarazo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El tratamiento de la bacteriuria asintomática durante el embarazo sólo disminuye la incidencia de pielonefritis pero no de cistitis.

119. Paciente varón de 46 años, intervenido hace 45 días de dos hernias discales lumbares. Presenta micciones frecuentes de escasa cantidad, incontinencia urinaria y tumoración hipogástrica. Se realiza una ecografía, que demuestra la presencia de un globo vesical, no observando otra patología de vejiga, además de comprobar que los riñones son normales y que la próstata es de un volumen de 24 cc en su medición ecográfica. Se pasa por la uretra sin dificultad hasta vejiga una sonda Foley de 16F, saliendo unos 950 cc de orina. Se realiza un estudio urodinámico, apreciando en la cistometría una hipoactividad e hipocontractilidad del detrusor, con presiones del detrusor bajas durante la fase de vaciado (o miccional) y con residuo postmiccional elevado. De las posibilidades en su enfoque terapéutico posterior, ¿qué NO estaría indicado?:

1. Cateterismo intermitente.
2. Alfabloqueantes.
3. Maniobras de compresión suprapúbica (Credé).
4. Anticolinérgicos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Todas las opciones favorecen el vaciado vesical excepto los anticolinérgicos, que favorecen el almacenamiento.

120. Hombre de 60 años, receptor de riñón donante cadáver de 65 años. Tras una cirugía sin complicaciones valorables, presenta en las primeras cuatro horas tras la conclusión de la misma, constantes vitales mantenidas, drenaje quirúrgico con débito nulo y ausencia de diuresis. Todas las siguientes causas son posibles EXCEPTO una, señálela:

1. Trombosis vascular.
2. Hemorragia de anastomosis vascular.
3. Rechazo subagudo.
4. Necrosis tubular.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Las preguntas de CIRUGÍA hay que contestarlas pensando de modo práctico como un cirujano (que es quien pone la pregunta). Una dehiscencia de anastomosis vascular provocaría gran pérdida de sangre con hipovolemia e hipotensión, y esa sangre saldría por el tubo de drenaje. En el resto de opciones no sale sangre por ningún sitio y las constantes se mantienen. El rechazo subagudo no existe, estaríamos, en todo caso ante un caso de rechazo hiperagudo (<24h).

121. ¿Cuál de las siguientes respuestas es FALSA respecto al carcinoma de células renales?:

1. Puede manifestarse con disfunción hepática.
2. Su tamaño es un factor pronóstico importante.
3. Puede cursar con hipertensión arterial.
4. La triada de dolor lumbar, hematuria y masa abdominal palpable es la forma de manifestación más frecuente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La pregunta repasa los conceptos más importantes para el MIR del Ca renal: 1. El Sd. de Stauffer es típico del Ca renal y consiste en alteración bioquímica hepática (aumento de enzimas) sin infiltración tumoral en el hígado (es paraneoplásico). 2. Si un Ca renal mide < 7 cm se permite la resección conservadora de órgano (si mide > 7 cm, se quita el riñón entero). 3. Cualquier enf. que afecte la vascularización renal puede condicionar HTA vasculorenal. 4. La triada de Lenk es muy infrecuente hoy en día, ya que la mayoría de Ca renales se diagnostican de modo incidental al realizar una Eco abdominal por otras causas.

122. Acude a su consulta un hombre de 67 años que refiere ligera astenia desde hace 2 meses y una pérdida de peso de 6 kg en el mismo plazo. No refiere fiebre, cambios en el hábito deposicional ni síndrome miccional. En la exploración física únicamente destacan: soplo sistólico panfocal II/VI y hepatomegalia no dolorosa de 1 través de dedo en línea medioclavicular. Aporta la siguiente analítica: Hemograma: hemoglobina: 7,9 g/dl; hematocrito: 22%; VCM: 75fl; leucocitos: 8800/microl; (PMN: 63%; linfocitos: 22%; monocitos 12%, eosinófilos 3%), plaquetas: 550000/microl. Bioquímica: creatinina: 0,89 mg/dl; glucosa: 112 mg/dl; Na: 142 mEq/l; K: 4,2 mEq/l; Cl: 100 mEq/l; GOT: 16UI/L; GPT: 21UI/L; GGT: 71UI/L; LDH: 88UI/L; bilirrubina: 0,91 mg/dl; sideremia: 21 microg/dl; ferritina: 12 ng/ml; TIBC: 450 microg/dl. La actitud más adecuada sería:

1. Iniciar tratamiento con hierro intravenoso. Solicitar panendoscopia oral y colonoscopia. Mantener ferroterapia hasta normalizar la cifra de ferritina.
2. Transfundir 2 concentrados de hematíes. Solicitar panendoscopia oral y colonoscopia.
3. Iniciar tratamiento con hierro oral. Solicitar panendoscopia y colonoscopia, suspendiendo la ferroterapia 10 días antes de la colonoscopia. Reanudar la ferroterapia y mantener hasta 6 meses tras corregir la anemia.
4. Iniciar tratamiento con hierro oral. Solicitar panendoscopia y colonoscopia, suspendiendo la ferroterapia 10 días antes de la colonoscopia. Reanudar la ferroterapia y mantener hasta corregir la anemia.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La pregunta mejor y más completa del examen y que denota un gran conocimiento de Medicina Interna del autor de la pregunta. Obliga a los opositores a acuñar conocimientos de varias disciplinas con razonamientos críticos. No hay que transfundirlo porque el paciente, aunque muy anémico, no está inestable. La presencia de un soplo no implica inestabilidad sino un estado hiperdinámico lógico y esperable en una paciente anémica. El paciente no está inestable y ha venido tranquilamente a nuestra consulta. (Respuesta 2 incorrecta) No se debe mantener el tratamiento hasta corregir la anemia sino hasta rellenar los depósitos, dato que suele valorarse con la normalización de las cifras de ferritina. (Respuesta 4 incorrecta). Recuerda que no se debe instaurar tratamiento con hierro intravenoso salvo que haya intolerancia al hierro oral, exista un estado malabsortivo, anemias muy severas o pérdidas digestivas muy cuantiosas. (Respuesta 1 incorrecta). La opción correcta es la 3. La ferroterapia debe suspenderse 10 días antes de la colonoscopia para una correcta exploración (el hierro no deja ver bien porque tiñe las heces de negro) y debe mantenerse no hasta la normalización de las cifras de hemoglobina sino hasta la corrección de la ferritina que suele suceder en torno a los 6 meses después de iniciar el tratamiento con hierro oral.

123. Niña de Guinea Ecuatorial de 7 años de edad que acude a urgencias por astenia importante de 3 días de evolución, febrícula, molestias faríngeas y orinas oscuras. En la exploración presenta hepatoesplenomegalia moderada ligeramente dolorosa y subictericia. En el hemograma se evidencia anemia importante de 5,6 g/dl de hemoglobina con VCM 75 fl y leucocitosis neutrofilica. En la bioquímica llama la atención un aumento de bilirrubina total de 5 mg/dl a expensas de bilirrubina no conjugada. La madre relata desde la infancia episodios similares que incluso han llevado a la transfusión en tres ocasiones previas realizadas en su país. Su familia presenta un historial de anemia y hematuria. ¿Qué prueba plantearía en este momento y cuál sería su sospecha diagnóstica?:

1. Estudio de hemoglobinas y talasemia mayor.
2. Niveles de ferritina y ferropenia severa.
3. Test de Coombs y anemia hemolítica autoinmune.
4. Estudio morfológico de sangre periférica y anemia drepanocítica.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nuestra paciente parece presentar anemia hemolítica (aumento de bilirrubina indirecta) intravascular (hemoglobinuria - orinas oscuras-). Importante: En este caso la presencia de orina oscura es secundaria a la hemoglobinuria y no a la filtración de bilirrubina por el riñón: La bilirrubina no conjugada es liposoluble y no se filtra por el riñón por lo que nunca producirá coluria. Esto ya nos permite descartar

opciones: - Opción 1: Talasemia mayor: Anemia hemolítica extravascular (no hay hemoglobinuria). - Opción 2: Ferropenia severa: No habría hemólisis y por tanto no puede haber hemoglobinuria ni aumento de la bilirrubina; tampoco cursa con hepatomegalia. Para decantarnos por una opción entre las que nos quedan, usaremos los antecedentes personales (paciente procedente de los trópicos y con una enfermedad hereditaria -antecedentes familiares-) y un dato que os puede haber resultado raro: hay microcitosis pero la anemia es hemolítica (habitualmente normocítica); la explicación es que los hematíes falciformes son pequeños. Todo esto orienta a la drepanocitosis (Opción 4 correcta). OJO!! Nuestra paciente tiene esplenomegalia, pero recordad que en la drepanocitosis es típico la anesplenía funcional por infartos de repetición, lo cual conlleva infecciones por bacterias encapsuladas que son la 1ª causa de muerte de estos pacientes (recordad la sepsis neumocócica y la osteomielitis por Salmonella).

124. Un paciente de 75 años presenta adenopatías y una linfocitosis en sangre periférica a expensas de linfocitos CD20+ y CD5+, con traslocación cromosómica t(11;14) y afectación de la mucosa del tubo digestivo, todo ello es compatible con:

1. Linfoma del Manto estadio IV.
2. Leucemia Linfática Crónica B estadio III-B.
3. Macroglobulinemia de Waldstrom.
4. Leucemia Prolinfocítica B.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta que deja claro que en el MIR hay que saberse los CDs y las translocaciones de los linfomas no hodgkin (por mucho que nos pese). Se trata de un linfoma del manto (opción 1 correcta). Lo más importante que hay que saber sobre el linfoma del manto es se parece a una leucemia linfática crónica puesto que ambas debutan con linfocitosis y presentan CD5 positivo. Sin embargo es MUCHO MÁS agresivo que la LLC y tiene el CD23 negativo (la LLC tiene CD23 positivo). Además hay que saber que expresa la ciclina D1 por la t(11;14). El tratamiento será QT agresiva. Si no sabemos que es un linfoma del manto en la pregunta nos dan un dato que nos puede servir para descartar opciones. La paciente tiene infiltración del tubo digestivo (localización extraganglionar) que es estadio IV y por tanto descartamos la opción 2

125. Con respecto al tratamiento del mieloma múltiple, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:

1. La mayoría de los pacientes experimentan remisión completa con melfalán y prednisona.
2. Se logran respuestas que alargan la supervivencia más allá de 15 años.
3. Los pacientes jóvenes pueden beneficiarse de altas dosis de quimioterapia seguida de autotrasplante en precursores hematopoyéticos.

4. Se deben utilizar estrategias de quimioterapia de inducción, consolidación y mantenimiento como en las leucemias agudas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil sobre el tratamiento del mieloma. Vayamos comentando cada opción: 1. Este tratamiento se utiliza en pacientes ancianos y no suele curar la enfermedad. 2. La supervivencia media pese al tratamiento es de 3-5 años. Con las nuevas opciones terapéuticas (inhibidores del portemos: bortezomib, carfilzomib. Antiangiogénicos: talidomida, lenalidomida. Anticuerpos monoclonales: daratumumab) los periodos libres de enfermedad son cada vez mayores y las respuestas mejores. 3. Opción correcta. Cada vez se hace más trasplante de médula ósea en enfermedades hematológicas, así que si nos encontramos opciones de trasplante, debemos considerarlas aunque no tengamos ni idea. Además, en la respuesta pone "pueden", y ya sabéis que en el MIR casi todo se "puede". 4. No se "debe" tratar el mieloma como las leucemias; hay múltiples estrategias según cada paciente (en el MIR casi nunca se "debe").

126. Un paciente de 40 años de edad con antecedentes personales y familiares de sangrados frecuentes por mucosa oral y epistaxis, presenta en el estudio de hemostasia: alargamiento del tiempo de sangría, disminución de la actividad del Factor VIII y una disminución de la agregación plaquetaria inducida por ristocetina, todo lo cual es compatible con:

1. Hemofilia A leve.
2. Tromboastenia de Glanzman.
3. Enfermedad de Bernard Soulier.
4. Enfermedad de von Willebrand.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Para responder a esta pregunta lo primero que hay que hacer es estudiar el tipo de sangrado que presenta el paciente: Sangrado de mucosa oral y epistaxis. El sangrado cutáneo-mucoso es propio de los trastornos de la hemostasia primaria. Además en el enunciado nos dicen que las pruebas que se realizan para identificar alteraciones de la hemostasia primaria (alargamiento del tiempo de sangría, alteraciones de la agregación plaquetaria inducida por ristocetina) están alteradas. (Opción 1 incorrecta). Tanto la enfermedad de Bernard Soulier como la enfermedad de Glanzmann y la enfermedad de Von Willebrand son enfermedades hereditarias secundarias a la alteración de la hemostasia primaria. Sin embargo en la enfermedad de Glanzmann no existe una alteración en las pruebas de agregación con ristocetina, se alteran con ADP, colágeno... (Opción 2 incorrecta). Está claro que el paciente presenta una de las dos enfermedades restantes: Enfermedad de Bernard Soulier o enfermedad por déficit del factor Von Willebrand. Recuerda que la enfermedad de Von Willebrand es la enfermedad hereditaria que afecta a la hemostasia más frecuente y que además los niveles de factor

VIII pueden estar bajos porque el fVW es el encargado de su transporte. (Opción 4 correcta).

127. En relación con los síndromes mielodisplásicos, señale la afirmación correcta:

1. La celularidad cuantitativa de la médula ósea está casi siempre aumentada o normal con patrón ferrocínico de eritropoyesis ineficaz.
2. La pancitopenia es un hallazgo poco frecuente (menos del 5%).
3. La presencia de citopenias o monocitosis sin anemia se da en más del 90% de los pacientes.
4. La presencia de anemia con sideroblastos en anillo es de mal pronóstico y suele conllevar una supervivencia inferior a un año.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos preguntan por las generalidades de los síndromes mielodisplásicos. - Son típicos de pacientes ancianos con predominio en varones - Suelen cursar con pancitopenia (opción 2 falsa) y alteraciones morfológicas en sangre periférica. La anemia es casi constante (opción 3 falsa) y característicamente no responde a los tratamientos habituales de la anemia (por eso estas entidades se llaman anemias refractarias). - La médula ósea es normo o hiper celular (opción 1 correcta). El diagnóstico se hace con aspirado medular. Tienen eritropoyesis ineficaz y aumentado el depósito de hierro en las células (aumenta la ferritina, la transferrina y los sideroblastos) por lo que en el tratamiento NO daremos hierro!!) - La anemia refractaria con sideroblastos en anillo (ARSA) es un Sd. mielodisplásico de buen pronóstico (opción 4 falsa).

128. Paciente de 40 años con cuadro clínico de sudoración, fiebre y pérdida de peso en las últimas semanas. En la exploración y pruebas de imagen se encontraron adenopatías mediastínicas, cervicales y retroperitoneales. Tras un estudio histológico se diagnostica de Enfermedad de Hodgkin del tipo depleción linfocítica. En la biopsia de médula ósea no se objetiva infiltración por la enfermedad. Señale de los siguientes en qué estadio del sistema Ann Arbor se encontraría este paciente:

1. Estadio III-A.
2. Estadio III-B.
3. Estadio IV-A.
4. Estadio IV-B.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La clasificación de Ann Arbor del Linfoma Hodgkin ya había sido preguntada en el MIR y lo han vuelto a hacer así que hay que saberla. Estadio I: única región ganglionar Estadio II: varias regiones ganglionares a un mismo lado del diafragma Estadio III: varias regiones a AMBOS lados del diafragma. Estadio IV: localización extranodal (médula ósea...)

A: sin síntomas B: con síntomas (pérdida de peso, fiebre tumoral, sudoración nocturna). El prurito NO es un síntoma B!!! Ahora ya podemos responder a la pregunta: - Lo primero que nos cuentan es que la paciente tiene síntomas B: ya podríamos descartar las opciones 1 y 3. - Tiene adenopatías a ambos lados del diafragma (cervicales, mediastínicas y retroperitoneales) así que sólo puede ser un estadio III o IV - No nos dice que tenga afectación extranodal (incluso nos cuentan que la médula ósea no está infiltrada) así que podemos descartar la opción 4 y nos quedamos con la 2.

129. En la enfermedad tromboembólica venosa en el paciente con trombofilia. Es FALSO que:

1. Suele manifestarse a edades más precoces.
2. Suele ser causa de enfermedad tromboembólica recidivante.
3. Debe sospecharse en caso de antecedentes familiares positivos.
4. Es indicación de heparina no fraccionada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se debe sospechar trombofilia en un paciente que tenga enf. tromboembólica (sin factores de riesgo asociados) que sea: - a edad inferior a la habitual (respuesta 1 verdadera) - en sitios raros (por ejemplo, trombosis arteriales) - de repetición (respuesta 2 verdadera) - resistentes a tratamientos habituales (suelen requerir más dosis y/o más tiempo de tratamiento) - con historia familiar de enf. tromboembólica (la mayoría de trombofilias son AD) (respuesta 3 verdadera). Tener trombofilia no implica tener que usar heparinas no fraccionadas (opción 4 falsa), se pueden usar también heparinas de bajo peso o anticoagulantes orales. Y aunque seas portador de trombofilia no implica que tengas que usar anticoagulación crónica, en la mayoría de los casos se utiliza de forma preventiva ante situaciones de riesgo.

130. Una paciente diabética de 65 años acude a urgencias por fiebre de 38,5°C y malestar general junto con síndrome miccional. Su tensión arterial es de 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca 105 lpm y frecuencia respiratoria de 22 rpm con saturación arterial de O₂ de 89%. En la exploración física destacaba puñopercusión izquierda positiva. En la analítica leucocitosis de 15700/mm³ (87%; neutrófilos), 90000 plaquetas y creatinina de 1,4 mg/dL. Señale aquella medida inicial cuyo retraso tenga una mayor influencia negativa en la evolución del cuadro:

1. Administrar precozmente corticoides y proteína C activada.
2. Administrar dobutamina para restablecer la fracción de eyección ventricular.
3. Ingreso en UCI para ventilación mecánica asistida.
4. Administración de antibióticos y estabilización hemodinámica.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Ante un paciente séptico debo tener claras las prioridades en la atención del mismo. Cuando nos hablan de “prioridad de actuación”, tenemos que recurrir a la regla ABC. A. Vía aérea. No hay ninguna respuesta al respecto. B. Respiración. Satura un 89 %, lo que equivale a $\text{PaO}_2 = 60 \text{ mmHg}$, esto es, rozando la insuficiencia respiratoria, así que sería prioritario poner oxígeno y ver si mejora (pero no haría falta ventilación mecánica, la pondríamos si hay refractariedad al oxígeno) (respuesta 3 incorrecta) C. Circulación. la paciente está hipotensa, así que tras pasar por la A y la B sin ver opciones que marcar, marcaremos la que diga “estabilización hemodinámica” (opción 4 correcta); además ponemos antibióticos para la infección que es la causa de los problemas de nuestra paciente (los antibióticos son una pista de que la 4 es la buena). La dobutamina es una droga simpaticomimética que se usa en el shock cardiogénico, pero esta paciente parece tener un shock séptico (que es distributivo, con vasodilatación) y la dobutamina es vasodilatador, así que empeoraría la situación de la paciente (opción 2 falsa). Lo de los corticoides es un opción de relleno.

131. La pauta más consensuada para administrar antibióticos de forma profiláctica en cirugía es:

1. Monodosis intraoperatoria.
2. Cada 12h el día antes y el día de la intervención.
3. Monodosis en el momento de la inducción anestésica.
4. Tres dosis postoperatorias.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta teórica. No merece la pena saber nada más que 2 conceptos: - La profilaxis antibiótica quirúrgica SOLO ha demostrado disminuir la incidencia de infecciones de la herida quirúrgica (no de ITUs, neumonías u otras infecciones). - La pauta más adecuada es monodosis durante la inducción anestésica (inmediatamente antes de comenzar la cirugía).

132. Paciente de 30 años procedente de Bangladesh que consulta por cuadro de fiebre continua de 38°C de 2 meses de evolución, hepatomegalia con gran esplenomegalia. Analítica: pancitopenia e hipergammaglobulinemia. Respecto a la entidad que sospecha, señale el efecto adverso no esperable con las diferentes opciones de tratamiento que se proponen a continuación:

1. Antimoniales pentavalentes-cardiotoxicidad.
2. Paramomicina-pancreatitis.
3. Anfotericina B liposomal-hipopotasemia y nefrotoxicidad.
4. Miltefosina- teratogenicidad.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos dan todos los datos necesarios para sospechar una leishmaniasis visceral y a continuación se repasan algunos

efectos adversos típicos: Antimoniales pentavalentes: cardiotoxicidad, hepatotoxicidad. Paramomicina: oto y nefrotoxicidad Anfotericina B liposomal: hipopotasemia y nefrotoxicidad Miltefosina: teratogenicidad (obliga a tres meses de contracepción), gastritis y hepatotoxicidad

133. Paciente que acude a Urgencias con fiebre intermitente, escalofríos, cefalea, debilidad y abundante sudoración nocturna de 3 días de evolución. Como antecedente epidemiológico destaca un viaje a la Península Arábiga hace 3 semanas donde consumieron leche de camella. El modo más rápido de diagnosticar la infección sospechada es:

1. Prueba de Mantoux.
2. Tinciones de micobacterias en esputo y/o orina.
3. Prueba de Rosa de Bengala.
4. Gram directo del líquido cefalorraquídeo.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

El dato clave para responder a esta pregunta es el dato epidemiológico de ingesta de leche de camella, suponemos no pasteurizada. Por que el cuadro clínico es inespecífico. La brucelosis es una zoonosis cuya forma más frecuente de adquisición es la ingesta de lácteos no pasteurizados. Se puede manifestar como una enfermedad febril, pero su clínica más frecuente y característica es la afectación músculoesquelética (espondilitis lumbar). su diagnóstico es por serología con el test rosa de bengala como técnica de screening rápido y técnicas de aglutinación en suero como medio de confirmación. Puede aislarse por cultivo en medio Ruiz-Castañeda.

134. Un paciente de 80 años ingresa en el hospital por dolor lumbar de un mes de evolución, continuo, progresivo, que aumenta con los movimientos del tronco y en los últimos días se irradia por la cara externa del muslo hasta la rodilla junto con febrícula de 37,5°C. Presenta antecedentes de hipertrofia prostática benigna y un ingreso hospitalario de sepsis de origen urinario dos meses antes. Sería urgente descartar:

1. Pielonefritis aguda.
2. Un nuevo episodio de sepsis.
3. Osteomielitis vertebral con absceso epidural.
4. Obstrucción de la vía urinaria con infección.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Nos hablan de una lumbociatalgia con afectación de raíces lumbares, por lo que tendré que pensar en un proceso raquímedular. De entre las opciones, la única que cuadra es la osteomielitis vertebral (OM) (que justifica la lumbalgia) junto al absceso epidural (que justifica la clínica de compresión radicular). Además, nos hablan de una sepsis previa que puede haber sido el origen de la osteomielitis. Respuesta 3 correcta. No obstante, recuerda que a nivel global la causa más frecuente y típica de OM es un origen hematógeno por *S. aureus*

135. Una mujer de 31 años ha sido diagnosticada recientemente de infección por VIH. Está asintomática. Acude a la consulta con una prueba de la tuberculina de 11 mm de diámetro, un recuento de 550 linfocitos CD4+/mm³ y una carga viral de 80.000 copias/mL. ¿Qué medidas deben recomendarse?:

1. Tratamiento de infección tuberculosa latente, profilaxis primaria de *Pneumocystis jirovecii* y tratamiento antirretroviral.
2. Tratamiento de infección tuberculosa latente y profilaxis primaria de *P. jirovecii*. No tiene criterios de inicio de tratamiento antirretroviral.
3. Tratamiento de infección tuberculosa latente y tratamiento antirretroviral. No tiene criterios de inicio de profilaxis de *P. jirovecii*.
4. Tratamiento de infección tuberculosa latente. No tiene criterios de inicio de profilaxis de *P. jirovecii* ni de tratamiento antirretroviral.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Partamos de 3 conceptos sobre el manejo del paciente VIH.
- Cualquier paciente VIH con Mantoux positivo es indicación de hacer quimioprofilaxis de la infección latente tuberculosa (siempre que hayamos descartado ya la TBC activa).
- Las indicaciones de profilaxis primaria (cotrimoxazol) del *P. jirovecii* son: CD4 < 200 o candidiasis oral. - Actualmente está recomendado iniciar tratamiento antirretroviral en todos los pacientes. (Recomendación con evidencia IA).

136. Un paciente de 27 años, con infección por VIH e inmunodepresión avanzada, refiere pérdida de visión bilateral, mayor en ojo izquierdo. El diagnóstico más probable a descartar es:

1. Desprendimiento de retina.
2. Coroiditis toxoplásmica.
3. Retinopatía por VIH.
4. Retinitis por CMV.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La causa más frecuente de ceguera en el paciente VIH es la retinitis por CMV (sobre todo si nos hablan de un paciente muy inmunodeprimido, pues el CMV afecta con CD4 < 50): opción 4 correcta. OJO!! La afectación retiniana más frecuente del paciente VIH es la retinopatía asociada a VIH, pero es una vasculitis autolimitada con buen pronóstico visual (no causa la pérdida de visión comentada).

137. ¿En cuál de estos pacientes indicaría una cirugía urgente?:

1. Colecistitis aguda en un paciente pluripatológico de 90 años.
2. Presencia de un cuerpo extraño en el estómago.
3. Paciente con ecografía informada como

colecistitis aguda y amilasa de 1200.

4. Diverticulitis aguda Hinchey IV.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad media. El paciente con colecistitis aguda y 90 años parece inoperable por lo que lo indicado sería hacer una colecistostomía. El paciente con un cuerpo extraño debe ser valorado por el endoscopista para tratar de extraer el mismo. El paciente con la ecografía de colecistitis también tiene 1200 de amilasa y la cirugía de la pancreatitis debe evitarse, sobre todo en los primeros días del cuadro. Por último un paciente con una diverticulitis Hinchey IV es un paciente con una peritonitis generalizada y que por lo tanto tiene indicación de cirugía urgente.

138. Si usted recibe un paciente con quemaduras por llama en una sala de urgencias, deberá seguir como regla primaria:

1. Olvidarse de las quemaduras hasta establecer un diagnóstico completo del estado del paciente.
2. Desbridar las ampollas provocadas por la lesión térmica mientras un asistente busca una vía de perfusión de líquidos para iniciar la reanimación hidroelectrolítica.
3. Canalizar una vía venosa para perfusión de líquidos al tiempo que toma una muestra para analítica general e iniciar la cura mientras llega el cirujano de guardia.
4. Administrar pronto la profilaxis antitetánica para evitar que se olvide.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta conflictiva y bastante impugnable, que el ministerio finalmente no modificó. - Ante todo paciente quemado, lo más importante es asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la oxigenación, y seguir el ABC de toda resucitación. Pero debemos tener muy en cuenta la lesión originante y los signos que podamos observar a primera vista (localización, profundidad, extensión y mecanismo). Eso nos ayuda a saber cómo puede estar el enfermo y predecir las complicaciones que puede desarrollar en las horas siguientes. Otro punto muy importante es la reposición hidroelectrolítica, para evitar el fracaso renal. Para emplear fórmulas de reposición líquida, debemos tener en cuenta el porcentaje de superficie quemada, por lo que, (aunque el ministerio dio por buena la respuesta 1), no es totalmente cierta, pues una parte vital del tratamiento del paciente necesita considerar la extensión y localización de las quemaduras. Sería más correcto que hubieran dicho "dejando en un segundo plano las quemaduras hasta realizar el ABC", pero lo de "olvidarse de las quemaduras" no parece muy correcto. La respuesta que es también dudosa es la 3, pues sí es necesario canalizar una vía de perfusión para líquidos, aunque la segunda parte de la pregunta, en que menciona al cirujano de guardia es bastante discutible. - Respecto al tratamiento de las quemaduras en sí, deben administrarse antimicrobianos tópicos y tul graso, y realizar

una cura oclusiva. Las ampollas o flictenas deben dejarse intactas, ya que ello permite la curación en un ambiente estéril y se protege la dermis subyacente (respuesta 2 falsa). Lo de administrar la profilaxis antitécnica lo antes posible “para que no se olvide” no parece tampoco muy científica (respuesta 4 falsa). Por tanto, en esta pregunta hay dos respuestas que son claramente falsas, y dos respuestas dudosas, de las que el ministerio dio por buena la respuesta 1.

139. El erlotinib es un fármaco activo en pacientes con cáncer de pulmón cuyo mecanismo de acción es:

1. Inhibe la topoisomerasa 2.
2. Inhibe el EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico).
3. Inhibe la polimerización de la tubulina.
4. Inhibe la despolimerización de la tubulina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El erlotinib es un inhibidor de la tirosin kinasa del EGFR, que está sobreexpresada en algunos tumores. Este fármaco se emplea en oncología como tratamiento del carcinoma no microcítico de pulmón en estadios avanzados, consiguiendo un aumento de la supervivencia de los enfermos.

140. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de fármacos analgésicos es INCORRECTA si aplicamos el tratamiento escalonado de la OMS?:

1. Paracetamol, tramadol y dexametasona.
2. Naproxeno, morfina de liberación retardada y gabapentina.
3. Ketorolaco, morfina y tramadol.
4. Ácido acetilsalicílico, ketorolaco y tramadol.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La escala analgésica de la OMS es útil para elegir el/los fármacos a emplear en función de la intensidad del dolor. En el primer escalón tenemos el dolor de intensidad leve, en que se emplean AINEs. En el segundo escalón, con dolor de intensidad moderada, se emplean AINEs más opiáceos menores (tramadol, codeína). En el tercer escalón, con dolor de intensidad severa, se emplean opiáceos mayores, manteniéndose los AINEs. En los tres escalones se pueden utilizar fármacos adyuvantes, como algunos antidepresivos (gabapentina) o corticoides. No deben combinarse dos opiáceos, por lo que la opción INCORRECTA en esta pregunta es la 3 (morfina y tramadol son dos opiáceos), si bien a veces esta combinación se puede ver en la práctica clínica. La opción 4 también es INCORRECTA por tratarse de 2 AINES, no mejora efecto antiinflamatorio y da lugar a más efectos adversos, sería correcta si en lugar de AAS pusiésemos paracetamol.

141. Un paciente de 73 años, hipertenso y con antecedentes de endarterectomía carotídea derecha hace 2 años, es diagnosticado de carcinoma de páncreas con metástasis peritoneales, hepáticas y pulmonares. El paciente rechaza el tratamiento con quimioterapia, aceptando únicamente manejo sintomático. Recibe tratamiento con morfina de liberación prolongada (llegando hasta 300 mg/día), lorazepam y metoclopramida, consiguiéndose un control adecuado de los síntomas. En la última semana reaparece dolor abdominal y náuseas y se añade dificultad para la deglución y periodos de agitación. El paciente está caquético, postrado, confuso, icterico y con sequedad de mucosas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, sobre el manejo del paciente, considera correcta?:

1. La dosis de morfina que recibe es la máxima aconsejada para evitar la depresión respiratoria, por lo que se debería asociar otro tipo de analgésico para controlar el dolor.
2. Haloperidol, clorpromacina y midazolam son fármacos útiles para controlar la agitación del paciente terminal.
3. La hidratación intravenosa alivia el sufrimiento causado por la deshidratación terminal sin prolongar la agonía.
4. Se debe forzar la ingesta por vía oral, enteral o parenteral, para mejorar los síntomas.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La respuesta 1 es falsa, pues en los opiáceos no existe dosis máxima, y es muy poco probable que en un paciente en fase terminal vaya a producir adicción o depresión respiratoria. Las respuestas 3 y 4 también son falsas, pues en las últimas horas de vida no se ha visto que la sueroterapia o la nutrición parenteral aporten ningún beneficio, y menos aún en forzar la ingesta oral. La respuesta CORRECTA es la 2, ya que en pacientes con confusión se recomienda administrar haloperidol, y ante agitación terminal, están indicadas BDZ como el midazolam, por su efecto ansiolítico y sedante.

142. Un paciente de 88 años ha sido dado de alta hospitalaria tras ser intervenido por una fractura de fémur. Acude a la consulta por presentar una úlcera de presión, aparecida en el hospital, de unos 5 cm en la zona sacra. Por la pérdida de piel en todo su espesor y presencia de tejido necrótico en su base la consideramos en estadio IV. Emite mal olor. La piel circundante está levemente eritematosa. El paciente está afebril y presenta un recuento y fórmula leucocitaria normales. ¿Cuáles de las siguientes aproximaciones sería la MENOS adecuada en este momento?:

1. Instaurar medidas locales antipresión.
2. Administrar antibióticos sistémicos tras recoger cultivos del exudado.

3. Asegurar un buen estado nutricional del paciente.
4. Proceder al desbridamiento quirúrgico del material necrótico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Lo primero que debemos tener claro es que una Úlcera por presión NUNCA está infectada hasta que se demuestre lo contrario. Puede existir contaminación (bacterias en la superficie de la úlcera), pero muy rara vez hay infección, ya que es una herida completamente abierta de por sí, y las bacterias suelen producir infección en heridas cerradas. Las úlceras se producen cuando existe una presión mantenida en el mismo punto durante más de 2 horas, produciendo isquemia. De esta manera el tejido se va “pudriendo”. Todo tejido que se pudre se contamina, y al estar contaminado podrido, huele mal (debido a los anaerobios), sin que exista infección. Lo más importante en el tratamiento de las UPP son las medidas locales antipresión y los cambios posturales, sin los cuales nunca mejorará (respuesta 1 correcta). Un buen estado nutricional, necesitando a veces suplementos proteicos, es también importante en el tto de las UPP (respuesta 3 correcta). Como nos describen una placa necrótica, es necesario el desbridamiento quirúrgico, pues en estos casos se podría crear una cavidad que sí podría infectarse (respuesta 4 correcta). Por último también es necesario emplear antisépticos locales en las UPP, aunque es rara la utilización de hipoclorito sódico. Por tanto, la respuesta FALSA es la 2, ya que al no existir infección no debemos administrar antibióticos sistémicos.

143. En un paciente con metástasis hepáticas de un tumor primario no conocido, ¿cuál de los siguientes tumores considera más improbable como origen?:

1. T. mamarios.
2. T. pulmonares.
3. T. gastrointestinales.
4. T. prostáticos.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta puramente teórica sobre las metástasis hepáticas. Debemos recordar que los tumores que con más frecuencia metastatizan a hígado son aquellos de procedencia gastrointestinal (sobre todo el cáncer colon, pero también de estómago y páncreas), junto con los tumores neuroendocrinos (carcinoide), linfoma, C.mama, C.pulmón y melanomas. Por el contrario, es raro que metastaticen en hígado los tumores de tiroides, próstata (Respuesta 4 CORRECTA) y el resto de tumores cutáneos. Esta pregunta no debe fallarse, pues ya ha sido preguntada con anterioridad en el MIR.

144. Un paciente consulta por pérdida de peso, dolor abdominal y trombosis venosa. En la exploración tiene esplenomegalia e ictericia. En las pruebas de imagen se confirma la sospecha clínica de tumor abdominal de:

1. Estómago.
2. Vesícula.
3. Hígado.
4. Páncreas.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El signo más frecuente que encontramos en este cáncer es la pérdida de peso, mientras que el síntoma más frecuente es el dolor abdominal a nivel de epigastrio que se irradia hacia ambos hipocondrios y llega a la espalda. Además, un síndrome paraneoplásico típico de estos pacientes es la tromboflebitis migratoria, o síndrome de Trousseau. La esplenomegalia y la ictericia son también frecuentes en estos pacientes. Por todo ello, la respuesta CORRECTA es la 4, cáncer de páncreas.

145. ¿Qué gen debería estudiarse en un paciente con cáncer colorrectal no acompañado de pólipos o con pocos pólipos en la mucosa adyacente, que tiene dos miembros adicionales de su familia en dos generaciones que han desarrollado un tumor similar?:

1. Ras.
2. APC.
3. MSH2.
4. p53.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

El enunciado de esta pregunta nos describe un Síndrome de Lynch, que es un tipo de cáncer colorrectal (CCR) hereditario no polipósico. Para diagnosticarlo se deben cumplir los siguientes criterios: - Uno o más casos en la familia de CCR antes de los 50 años. - Afectar al menos a dos generaciones consecutivas. - 3 o más familiares con CCR (siendo uno de primer grado). Una vez que tenemos identificado que se trata de este síndrome, lo que tenemos que recordar es que su herencia es Autosómica Dominante, y que está relacionado con mutaciones en los genes MSH2 (respuesta 3 CORRECTA) y MLH1. El APC es el gen de la Poliposis Adenomatosa Familiar, pero en ese caso el paciente tendría decenas-cientos de pólipos y no “pocos” como en el Lynch.

146. Al valorar el riesgo operatorio de un paciente con un infarto de miocardio previo, que se debe operar de una hernia inguinal sintomática, es cierto que:

1. Se debe posponer la operación hasta transcurridos 9 meses del infarto por el alto riesgo de reinfarto perioperatorio.
2. El periodo de máximo riesgo de reinfarto perioperatorio es el primer mes.
3. El periodo de máximo riesgo de reinfarto perioperatorio son los 6 primeros meses.
4. Es una patología benigna y solo se debe operar si la hernia se encarcera o estrangula.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Existe un riesgo del 27-37% de nuevo IAM si el procedimiento quirúrgico se realiza en los primeros 3 meses postinfarto. De aquí, el periodo de mayor riesgo es el del primer mes postinfarto (respuesta 2 VERDADERA). El riesgo descende al 11-15% si la cirugía se realiza entre los 3 y 6 meses postinfarto (respuesta 3 falsa, el riesgo es mayor en los tres primeros meses que en los 6 primeros meses), y llega a un 4-5% pasados 6 meses postinfarto. A partir del sexto mes postinfarto se considera que el riesgo es menor, y no debe esperarse hasta pasados 9 meses para realizar la cirugía (respuesta 1 falsa), ni abstenerse de operar hasta que se complique la hernia (respuesta 4 falsa).

147. La isotretinoína oral es el tratamiento de elección en pacientes con acné severo, que no responde o lo hace discretamente a los tratamientos tópicos y tetraciclinas por vía oral. ¿Qué recomendación y/o control NO es necesario en su administración?:

1. Si el paciente es mujer, solicitar un test de embarazo antes de iniciar el tratamiento y recomendarle la utilización de al menos un método anticonceptivo seguro, durante todo el tratamiento y hasta un mes después de terminarlo.
2. Si el paciente es hombre, recomendarle el uso de un método anticonceptivo durante todo el tratamiento y hasta tres meses después de terminarlo.
3. Controlar la función hepática y los niveles de triglicéridos y colesterol.
4. Recomendarle que evite el sol.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sobre las complicaciones relacionadas con el empleo de retinoides. Entre ellas encontramos sequedad de mucosas (que es lo más frecuente, por lo que está recomendado administrar emolientes en piel y mucosas), teratogenia (en el caso de la isotretinoína, las mujeres deben emplear contracepción eficaz hasta un mes después de finalizado el tratamiento (respuesta 1 correcta), hepatotoxicidad, hipercolesterolemia y hipertrigliceridemia (por lo que se recomienda controlar la función hepática y los niveles de lípidos, respuesta 3 correcta), hipertensión intracraneal benigna, riesgo de queloides... Además, durante su uso debe evitarse la exposición solar y emplear medidas protectoras (respuesta 4 correcta). La respuesta FALSA es la 2. La contracepción sólo debe recomendarse si la paciente es mujer, un mes en el caso de la isotretinoína, y hasta dos años en el caso de otros retinoides (etretinato, acitretino).

148. Paciente de 35 años de edad, que acude a Urgencias por salpicadura de un producto de limpieza en ambos ojos. Ha ocurrido hace unos minutos y le traen directamente a urgencias

pues apenas puede abrir los ojos. En el manejo de este tipo de urgencias oftalmológicas, señale la opción correcta:

1. Hacer una cuidadosa anamnesis para tratar de averiguar la naturaleza del agente cáustico y utilizar el neutralizante adecuado.
2. Enviar a un acompañante al domicilio para que nos traiga el envase del producto y lavar con el neutralizante correspondiente.
3. Pasar por alto la anamnesis y la exploración y proceder a lavar los ojos con suero fisiológico o agua durante 15 a 30 minutos.
4. Realizar una tinción con Fluoresceína Sódica para valorar adecuadamente las lesiones del segmento anterior.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta sencilla sobre el manejo en urgencias de pacientes con lesiones oculares por agentes químicos. Debemos recordar que LO MÁS IMPORTANTE Y LA PRIMERA ACCIÓN A REALIZAR ES EL LAVADO OCULAR con agua o suero salino abundante (respuesta 3 CORRECTA), incluso antes de la anamnesis del paciente. En el caso de que el agente fuera sosa cáustica, la solución debe acidificarse con ácido acético. El lavado debe ser prolongado, de hasta 30 minutos. Posteriormente se pueden evaluar las posibles lesiones, mediante inspección, tinción con fluoresceína, y en función de la gravedad, remitir al especialista para su tratamiento.

149. Paciente varón, de 59 años de edad, hipertenso, que refiere una pérdida de visión en su ojo derecho, indolora y repentina. En el fondo de ojo destaca una papila de aspecto hiperémico y bordes mal definidos, mientras que el izquierdo es completamente normal. En el estudio de campo visual aparece un defecto en el campo inferior. ¿Cuál sería entre los siguientes el diagnóstico más probable para este cuadro?:

1. Neuritis óptica anterior.
2. Edema de papila por hipertensión intracraneal.
3. Neuropatía óptica isquémica anterior.
4. Neuritis óptica desmielinizante.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Se trata de un caso clínico de un paciente con una pérdida de visión por un ojo con un edema de papila en el mismo. Esto lo más frecuente es que sea una NOIA isquémica o no arterítica (respuesta 3 CORRECTA). Además el defecto altitudinal es más típico de esta patología. La respuesta 1 nos dice neuritis óptica anterior, pero la opción 3 es más completa, por indicarnos además que es isquémica. En una neuritis desmielinizante, retrobulbar, la papila sería normal (ni el médico ni el paciente ven nada), por lo que la respuesta 4 no es correcta. El edema de papila por hipertensión intracraneal sería bilateral, por lo que descartamos la respuesta 2.

150. Paciente de 57 años de edad que acude a revisión anual rutinaria al Centro de Salud, pesa 84 kg y mide 1.75 m. Se encuentra, según sus propias manifestaciones, bien de salud, hace poco ejercicio y come normalmente. Su presión arterial es 155/90mmHg. Al explorar el fondo de ojo previa dilatación pupilar con Tropicamida, observamos en el polo posterior de ambos ojos, rodeando el área macular una serie de puntos rojos y blancos junto con pequeñas manchas blancas y rojas. Esto nos hace pensar que:

1. Es una retinopatía hipertensiva, controlaremos la presión arterial y/o recomendamos un Holter.
2. Se trata de una degeneración macular asociada a la edad, remitimos de urgencia al Oftalmólogo.
3. Podría ser una Retinitis por VIH, solicitaremos las pruebas correspondientes.
4. Es una Retinopatía diabética, indicaremos una curva de Glucemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Esta descripción de puntos rojos y blancos con pequeñas manchas blancas y rojas, es decir, hemorragias y exudados, es bastante inespecífica, y de hecho puede aparecer en cualquiera de las opciones que nos plantean. - La clave para responder a esta pregunta es que nos dicen "esto nos hace pensar en". En la práctica clínica habitual, es bastante frecuente diagnosticar una retinopatía diabética mediante un fondo de ojo, en un paciente previamente sano y que desconocía que era diabético (respuesta 4 CORRECTA). - La retinopatía hipertensiva suele aparecer con cifras de tensión arterial superiores a las de este paciente, y no es lo primero que "debemos pensar". - La DMAE tiene una clínica y una exploración diferentes, con síndrome macular (disminución de la agudeza visual, escotoma central, metamorfopsias y discromatopsias) y un fondo de ojo con drusas y neovasos. - Por último, la retinopatía por VIH sí podría ajustarse a la descripción de la pregunta, pues existen hemorragias y exudados, pero no es lo primero que debemos pensar.

151. Ante un varón con antecedentes de tabaquismo y alcoholismo que consulta porque desde hace meses nota una sensación de cuerpo extraño al tragar, parestesias faríngeas, pinchazos en los oídos y una adenopatía cervical. ¿Qué debemos sospechar?:

1. Cáncer de las cuerdas vocales.
2. Cáncer de supraglotis.
3. Cáncer de cavum.
4. Cáncer subglótico.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que no debemos fallar del Ca laríngeo. Entre los factores predisponentes al mismo se encuentran el consumo de alcohol y la fracción sólida del tabaco. Otros factores re-

lacionados son las radiaciones, el HPV, agentes químicos... Según su localización, la clínica con la que debutará será diferente. -El carcinoma supraglótico es el más frecuente en España, y cursa con parestesias, picor faríngeo y otalgia refleja. Además es el que más metástasis ganglionares da. -El carcinoma de cuerdas vocales cursa con disfonía, no da metástasis ganglionares y es el de mejor pronóstico. -El carcinoma subglótico cursa con disnea y estridor, y es el de peor pronóstico. Por todo esto, vemos que aquél que se ajusta a la perfección a la descripción del caso clínico es el Carcinoma de supraglotis (respuesta 2 CORRECTA, respuestas 1 y 4 incorrectas). -El cáncer de cavum cursa de manera diferente, con adenopatía cervical y clínica de otitis media serosa, epistaxis... Además no está relacionado etiológicamente con el alcohol y el tabaco, sino con el VEB y las conservas en salazón. (Respuesta 3 falsa). -La laringitis aguda puede producir disfonía, tos, odinofagia, pero como su nombre indica es aguda, y no de meses de evolución. Debemos recordar que ante una disfonía de más de 15 días de evolución es muy importante descartar Ca laríngeo.

152. Varón de 75 años que acude a la consulta por presentar una parálisis facial derecha de lenta instauración. A la exploración se aprecia una tumoración preauricular derecha de 4 cm, de consistencia dura, que según refiere el paciente la tiene desde hace aproximadamente un año. No se palpan adenopatías cervicales, ¿Cómo orientaría el cuadro clínico?:

1. Tumor maligno de glándula parótida.
2. Colesteatoma.
3. Parálisis facial a frigore.
4. Tumor maligno de glándula submaxilar.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Es importante recordar que los tumores benignos son el 70% del total. De ellos, el más frecuente es el adenoma pleomorfo, que afecta sobre todo a la parótida. Los tumores malignos son el 30% del total, y se dan con más frecuencia en la submaxilar y la sublingual. De los tumores malignos, el más frecuente a nivel parotídeo es el Ca mucoepidermoide, mientras que a nivel submaxilar el más frecuente es en Ca adenoide quístico o cilindroma. Para poder diferenciar un tumor benigno de uno maligno debemos tener en cuenta que los benignos rara vez producen parálisis facial. Por ello, una masa a nivel de la glándula parótida, de consistencia dura y parálisis facial progresiva debe considerarse como un tumor maligno de parótida (respuesta 1 CORRECTA). La respuesta 4 no es correcta, porque la masa nos la describirían a nivel submaxilar. La parálisis facial a frigore es de instauración rápida, en 1-2 días, y es idiopática, por lo que no deberían hablarnos de ninguna tumoración preauricular, (respuesta 3 falsa). Por último, el colesteatoma evolucionado puede producir parálisis facial, pero es una patología que cursa por lo demás de manera totalmente diferente, con otorrea, hipoausia... Y sin ninguna masa a nivel preauricular (respuesta 2 falsa).

153. Paciente de 28 años que durante una pelea recibe un puñetazo en el mentón y acude a urgencias presentando tumefacción preauricular derecha, otorragia, limitación de la abertura bucal y contacto prematuro de los molares del lado afecto. ¿Qué es FALSO en relación a esta patología?:

1. Es la fractura más frecuente del territorio maxilofacial.
2. Su tratamiento no siempre es quirúrgico.
3. Los niños que sufren este tipo de fractura pueden presentar secundariamente alteraciones del crecimiento mandibular.
4. A la apertura bucal, los pacientes que sufren este tipo de fractura, suelen presentar desviación del mentón hacia el lado lesionado.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos presentan un caso clínico sobre un tema poco preguntado en el MIR, el de la patología de la ATM. La fractura más frecuente del territorio maxilofacial es la fractura nasal, por lo que la respuesta 1 es la FALSA. En el resto de opciones nos aportan datos característicos de las fracturas de cóndilo mandibular. Es cierto que su tratamiento no siempre es quirúrgico, ya que en la mayoría de los casos basta con una reducción cerrada. Debido a una lesión a nivel condilar, se debe vigilar el crecimiento de la mandíbula en niños pequeños, para evitar alteraciones de su crecimiento. A la exploración, la mandíbula se desvía lateralmente hacia el lado lesionado al abrir la boca.

154. Paciente de 55 años que refiere hipoacusia progresiva del oído derecho desde hace 1,5 años junto con sensación leve de inestabilidad y acúfeno en dicho oído. La exploración muestra tímpanos normales y la audiometría tonal indica una hipoacusia derecha moderada-severa. ¿Qué actitud tomaría?:

1. Administraría sedantes vestibulares.
2. Control evolutivo.
3. Realizaría una resonancia magnética para descartar un neurinoma.
4. Le indicaría la adaptación de prótesis auditiva.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un tema muy preguntado en el MIR en el apartado de ORL es neurinoma del acústico, que nos suelen presentar en forma de caso clínico. Se trata del tumor más frecuente del ángulo pontocerebeloso, (78%). Pese a su nombre, deriva de la vaina del nervio vestibular. La hipoacusia neurosensorial asimétrica y los acúfenos son los síntomas más habituales de presentación con desequilibrio e hiperestesias faciales. El 5% tienen audición normal. La clínica depende de la fase: * Fase otológica: hipoacusia de percepción unilateral como signo más precoz, acúfenos, alteraciones equilibrio, desapa-

rición reflejo estapedial. *Fase neurológica: afectación del nervio trigémino (anestesia facial y alteración reflejo corneal), facial (signo de Hitselberger: hiperestesia/hipoestesia zona Ramsay-Hunt) y otros pares craneales bajos. *Fase de hipertensión craneal: cefalea, ataxia, edema de papila... El diagnóstico se realiza con RM con gadolinio (ver imagen: neurinoma del acústico derecho), y los potenciales evocados de tronco también son muy útiles en su detección. Con respecto al tratamiento, la actitud expectante es una opción especialmente en pacientes ancianos con tumores pequeños. Dada la posibilidad de complicaciones por el crecimiento del tumor, en pacientes jóvenes el tratamiento es obligado, siendo las modalidades más eficaces la radioterapia y la extirpación quirúrgica. Por todo lo dicho, la respuesta CORRECTA es la 3, ya que ANTE TODA HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL DEBEMOS DESCARTAR LA PRESENCIA DE UN NEURINOMA.

155. Respecto a los trastornos de ansiedad, señale la respuesta FALSA:

1. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por la presencia de crisis de angustia, recurrentes e inesperadas y puede cursar con o sin agorafobia.
2. Son los trastornos más comunes en la población general. Son más frecuentes en mujeres y su incidencia disminuye con la edad.
3. El abuso de alcohol es una complicación grave y frecuente.
4. El trastorno por estrés postraumático suele aparecer en los seis primeros meses tras el suceso traumático.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Opción 1 INCORRECTA: Esta opción nos está describiendo el trastorno de angustia o trastorno de pánico, caracterizado por crisis de angustia recurrentes, que aparecen con o sin desencadenante aparente, y que puede asociarse en algunos casos con agorafobia. El trastorno de ansiedad generalizada cursa de modo diferente, con preocupación excesiva ante una amplia gama de situaciones, que producen síntomas físicos y psíquicos (alteraciones del sueño, fatiga, falta de concentración...).- Opción 2 correcta: los trastornos de angustia son los problemas psiquiátricos más frecuentes en la población general, con una prevalencia del 17%. Son más frecuentes en mujeres (excepto TOC y fobia social, que es igual de frecuente en hombres que en mujeres) y su incidencia disminuye con la edad. Este mismo concepto se ha repetido ya en examen MIR anteriores (MIR 97, MIR 06). - Opción 3 correcta: en los trastornos de ansiedad es frecuente la comorbilidad con abuso de alcohol, en ocasiones empleado como ansiolítico. - Opción 4 correcta: el trastorno de estrés postraumático (TEPT) aparece tras una situación muy traumática que ha puesto en peligro la vida o integridad física del paciente, y consiste en la reexperimentación del suceso, en forma de recuerdos, sueños relacionados, flashbacks, evitación de situaciones que le recuerden

a la situación traumática vivida y embotamiento emocional (desinterés por el entorno). Lo más frecuente es que aparezca en los primeros 6 meses tras el suceso. Si aparece en el mes siguiente y dura menos de 4 semanas es considerado un trastorno por estrés agudo.

156. Alberto acompaña a su padre, de 55 años, a la consulta del psiquiatra. El padre no veía necesaria la consulta porque dice sentirse estupendamente. Sin embargo el hijo cuenta que le ve cambiado desde hace algún tiempo. Todas las tardes se va a un bingo, algo que antes rechazaba, gasta en él más de la cuenta y cuando llega a casa, ya bastante tarde, da vueltas por la casa sin centrarse en nada y no hay manera de que se vaya a dormir. Habla de las personas que ha conocido en el bingo e incluso cuenta que hay una mujer con la que está pensando casarse. Ha hecho un amigo con el que piensa emprender un negocio seguro y no tolera que le contradigan. Al psiquiatra le cuenta que en su vida se ha encontrado mejor y que en todo caso será su hijo, que siempre está preocupado, quien necesite tratamiento. El hijo dice que nunca antes había visto a su padre de esta manera. ¿Cuál es su diagnóstico?:

1. Trastorno esquizotípico.
2. Episodio hipomaniaco.
3. Distimia.
4. Trastorno límite de la personalidad.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La manía se caracteriza por un humor eufórico, con aumento de la actividad (física y psíquica), que se manifiesta por una disminución de las necesidades de sueño y de ingesta, distraibilidad, autoestima exagerada o grandiosidad, implicación excesiva en actividades placenteras y de riesgo, junto con ausencia de conciencia de enfermedad. El paciente que nos describen se ajusta a dicha definición, sin embargo no nos hablan de que tenga ideación delirante (que generalmente es congruente con el estado de ánimo: megalomaniaca, erotomaniaca...) que se presenta en la manía. Por lo tanto se trata de un episodio hipomaniaco, no de un episodio maniaco. (respuesta 2 CORRECTA).

157. En los pacientes con trastorno bipolar, tratados con sales de litio, es necesario el control de:

1. La presión arterial.
2. La función tiroidea.
3. El título de anticuerpos.
4. El segmento ST.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

En el MIR son muy frecuentes las preguntas sobre el tratamiento del trastorno bipolar con sales de litio, en particular

sobre los efectos adversos del mismo y los controles del tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento con litio debemos descartar la presencia de embarazo, analizar la función renal y tiroidea, realizar un hemograma y una bioquímica básica y un ECG. Periódicamente debemos valorar la función renal y las hormonas tiroideas (respuesta 2 correcta), pues entre los efectos adversos del litio se encuentran la diabetes insípida nefrogénica, la nefritis intersticial, y el hipotiroidismo. Otras alteraciones endocrinas asociadas al tratamiento con litio son un aumento de las hormonas paratiroides, una disminución del cortisol y un aumento de la glucemia. A pesar de que sabemos que la aparición de alteraciones del ritmo cardíaco son un motivo de retirada del litio, no se encuentra protocolizado el control electrocardiográfico en el tratamiento con Litio. La opción 4 podría hacernos dudar, pero estando tan clara la opción 2, no hay dudas!!

158. El test de supresión con dexametasona se emplea como test biológico complementario para el diagnóstico de:

1. Esquizofrenia.
2. Trastorno bipolar.
3. Alcoholismo
4. Depresión endógena.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica sobre el diagnóstico de la depresión endógena. Debemos quedarnos con la idea de que existe en esta enfermedad un aumento de la secreción de cortisol, y una ausencia de respuesta al test de supresión con dexametasona, similar a la que se observa en el síndrome de Cushing. El test de supresión de dexametasona tiene valor pronóstico, porque una ausencia de supresión en el test traduce alta probabilidad de depresión endógena, y en consecuencia mejor respuesta al tratamiento farmacológico.

159. Un hombre de 23 años de edad es encontrado por la policía en estado comatoso y llevado al servicio de urgencias hospitalario. El paciente está hipoventilando a 4 respiraciones/min, cianótico y con pupilas mióticas. Existen múltiples señales de venopunción. Tras control de la vía aérea, ventilación y circulación, se administran 2,0 mg de naloxona intravenosa. El paciente despierta del coma, la frecuencia respiratoria aumenta a 24/min, está inquieto con diaforesis y midriasis. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento?:

1. Sujeción mecánica en prevención de cuadro de agitación y agresión.
2. Observación en urgencias con exámenes frecuentes del estado mental durante un mínimo de 4 a 6 horas.
3. Iniciar infusión de naloxona intravenosa con 2/3 de la dosis inicial por hora.
4. Administrar 10 mg de metadona intramuscular.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta complicada sobre un caso de intoxicación por opiáceos, que revierte tras administración de naloxona. En el MIR y más en urgencias, siempre que podamos debemos de marcar opciones conservadoras como la numero 2, Observación al menos 3-4 horas (Respuesta 2 CORRECTA). Ante toda intoxicación, lo prioritario es la comprobación y/o restauración de las funciones vitales mediante soporte cardiorrespiratorio. Posteriormente debemos evitar que se siga absorbiendo el tóxico, favorecer su excreción y administrar el antídoto en caso de que exista. En este caso clínico nos plantean una típica intoxicación por opiáceos, que cursa con miosis, bradipnea y alteración del nivel de conciencia. Lo prioritario es proteger la vía respiratoria, colocar una vía intravenosa, y después administrar naloxona intravenosa. Tras la respuesta a la naloxona, el paciente debe permanecer en observación al menos 3-4 horas (Respuesta 2 CORRECTA). Como en el caso del paciente que nos presentan, al administrar naloxona corremos el riesgo de precipitar un síndrome de abstinencia agudo (midriasis, diaforesis, rinorrea...). Este síndrome de abstinencia deberá valorarse antes de proceder al alta. Acordaros que en urgencias nunca se administra metadona. (opción 4 incorrecta).

160. Un hombre mayor es llevado a urgencias por la policía municipal. Cuentan los policías que deambulaba por la calle sin poder explicar donde vivía. Está correctamente vestido aunque con zapatillas de casa y no es capaz de decir cuál es su domicilio. Se muestra algo inquieto y dice que su hija irá a buscarle aunque no recuerda su teléfono. Es incapaz de responder a preguntas sencillas como su edad, el nombre de su hija o un teléfono. No existen alteraciones de otro tipo. El diagnóstico sería:

1. Trastorno psicótico.
2. Trastorno depresivo.
3. Trastorno por abuso de alcohol.
4. Demencia.

Respuesta correcta: 4**Comentario:**

Nos presentan un caso clínico de un paciente mayor, desorientado, incapaz de responder preguntas sencillas, que se encuentra perdido en la calle y no consigue encontrar su domicilio. En el MIR paciente anciano, que presenta desorientación, y cuyo nivel de conciencia es óptimo (descartamos cuadro confusional), siempre hay que pensar en una demencia como principal causa de dicha desorientación. De las opciones que nos dan, la única que parece más probable es la de demencia (respuesta 4 CORRECTA).

161. Paciente gestante de 38 semanas en periodo de dilatación (4 cm, primer plano); disfruta de anestesia epidural. Hace un año se le realizó cesárea por situación transversa. Estando previamente bien y de forma súbita presenta un sangrado que coincide en el registro

cardiotocográfico fetal con 4 desaceleraciones tipo DIP 2 seguidos de una bradicardia fetal a 70 latidos por minuto. La presentación fetal se palpa sobre el estrecho superior de la pelvis y la dinámica uterina prácticamente ha cesado. Su actitud es:

1. Sospecha de abrupcio placentae; realiza cesárea.
2. Sospecha de placenta de inserción baja; esperará a la normalización de la frecuencia cardíaca fetal y permitirá seguir el curso del parto.
3. Sospecha de rotura uterina; laparotomía urgente.
4. Sospecha de rotura de vasa previa; realiza cesárea.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Nos encontramos ante una típica pregunta del diagnóstico diferencial de las hemorragias del tercer trimestre. Analicemos cada respuesta: - No se trata de un abrupcio, pues típicamente éste cursa con aumento del tono uterino. - No se trata de una placenta de inserción baja, pues en este caso nos contarían la aparición de una hemorragia roja, abundantemente, indolora, con escasa afectación fetal. - No se trata de una rotura de vasa previa, pues si así fuera nos hablarían de una hemorragia que aparece al romperse la bolsa, produciendo sufrimiento fetal agudo. -Por tanto, la respuesta CORRECTA es la 3. El antecedente de cesárea previa es un factor de riesgo para la rotura uterina, que cursa con sangrado, sufrimiento fetal en forma de bradicardia mantenida y palpación de partes fetales por debajo del tejido celular subcutáneo, con cese de la dinámica uterina. El tratamiento es la laparotomía urgente.

162. Paciente en periodo expulsivo de 34 semanas de gestación, presentación en tercer plano de Hodge, posición OHT y aparición de una bradicardia fetal de 60-70 lat/min, constatándose la existencia de una acidosis respiratoria (PH = 7,18, PCO2 = 68 mg Hg, EB = -2 mEq/l). ¿Cuál sería la actitud correcta?:

1. Realización de una cesárea.
2. Realización de un vacuum.
3. Realización de un fórceps.
4. Colocación de un pulsioxímetro para conocer la saturación de O2.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Ante la presencia de sufrimiento fetal intraparto, con pH inferior a 7,2, se debe proceder a la extracción fetal inmediata (respuesta 4 falsa). Nos encontramos con un feto en III plano de Hodge, por lo que se debe realizar parto instrumental, y no cesárea (respuesta 1 falsa). Respecto al instrumento a emplear en el caso que nos presentan, nos podemos plantear ¿por qué fórceps, y no ventosa o espátulas? Si analizamos el

enunciado vemos que el feto está en posición TRANSVERSA (OIIT=Occipito iliaca izquierda transversa. Y en ese caso, el único instrumento ROTADOR es el fórceps (respuesta 3 CORRECTA, respuesta 2 falsa).

163. Entre los efectos de la adicción a la cocaína en una mujer gestante, es FALSO que exista:

1. Mayor riesgo de desprendimiento de placenta.
2. Riesgo de teratogénesis por la cocaína.
3. Mayor incidencia de parto post-término.
4. Mayor incidencia de hipertensión materna.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

La cocaína produce en el feto malformaciones congénitas (relacionadas con vasoconstricción), bajo peso y prematuridad, hemorragias intracraneales, alteraciones neurológicas y conductuales... En la madre, por efecto vasoconstrictor, se relaciona con HTA, aborto y parto pretérmino, (no posttérmino: respuesta 3 FALSA).

164. Todas las siguientes pueden ser complicaciones de la fecundación in Vitro, EXCEPTO:

1. Embarazo múltiple.
2. Hiperestimulación ovárica.
3. Infección pélvica.
4. Hiperprolactinemia.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta que puede acertarse por descarte. Las principales complicaciones de la FIV son: - Hiperestimulación ovárica: es la complicación más grave y cursa con ascitis, aumento del perímetro abdominal, dolor, y en ocasiones oliguria, distrés respiratorio y tromboembolismo. (Respuesta 2 correcta) - Embarazo Múltiple: es la complicación más frecuente. (Respuesta 1 correcta). - Abortos. - Trastornos psicológicos y estrés. - Complicaciones derivadas de la cirugía (punción folicular): infecciones, hemorragia... (Respuesta 3 correcta). Por tanto, descartando, la respuesta FALSA es la 4. Los trastornos de la prolactina pueden causar infertilidad, pero no son consecuencia de la medicación que se da en una FIV.

165. Mujer de 44 años de edad, con antecedentes de dos embarazos normales y ningún dato patológico destacable en su historia ginecológica. Acude a la consulta para revisión refiriendo que ha sido controlada en medicina interna para descartar un cáncer de colon no poliposo hereditario (síndrome de Lynch tipo II). Esta paciente tiene un elevado riesgo de padecer un cáncer de colon a lo largo de su vida, pero también tiene un mayor riesgo de padecer otros tipos de neoplasias. Señale cuál de los siguientes cánceres ginecológicos es el que implica un mayor riesgo de presentación en esta paciente:

1. Cáncer de mama.
2. Cáncer de cuello uterino.
3. Cáncer de ovario.
4. Cáncer de endometrio.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta teórica sobre el síndrome de Lynch y su asociación con cánceres ginecológicos. El síndrome de Lynch es un tipo de cáncer colorrectal hereditario no polipósico, que se asocia con un aumento de riesgo de otros tipos de cáncer (endometrio, ovario, estómago, intestino delgado, tracto hepatobiliar, tracto urinario, cerebro, piel...). Respecto a los cánceres ginecológicos, está asociado con cáncer de mama, endometrio y ovario, pero al que más se asocia (60-80%) es al cáncer de endometrio (respuesta 4 CORRECTA), siendo mucha menos frecuente su asociación con cáncer de ovario (9-12%).

166. Mujer de 27 años, que acude a consulta de ginecología remitida desde su médico de cabecera con el diagnóstico citológico cervical de lesión intraepitelial de alto grado (HSIL). Fumadora, sin hijos, sin pareja estable y con deseos reproductivos. Se realiza una colposcopia con biopsia y el estudio histológico informa de lesión intraepitelial de alto grado (CIN III). ¿Cuál es la conducta indicada en esta paciente?:

1. Histerectomía.
2. Vacunación para el virus del papiloma humano (HPV).
3. Conización cervical.
4. Seguimiento citológico.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla sobre el manejo de las lesiones cervicales. Ante una lesión de bajo riesgo (LSIL), el tratamiento es la escisión simple de la misma. Ante una lesión de alto riesgo (HSIL), el tratamiento de elección es la conización con márgenes libres (respuesta 3 CORRECTA). La histerectomía está indicada en carcinoma invasor de cuello uterino, no en lesiones de este tipo (respuesta 1 incorrecta).

167. Gestante de 12 semanas que acude a su consulta para realizar una ecografía en la que usted observa una gestación intrauterina con un embrión único con LCC de 16 mm (acorde con 8 semanas) sin latido cardíaco. Señale lo correcto:

1. Gestación mal datada. La LCC nos indica el tiempo de gestación en el primer trimestre. Corrigiremos la fecha probable del parto.
2. Diagnóstico de aborto diferido: legado.
3. Determinación de beta-HCG plasmática cada 48 horas.
4. Diagnóstico de feto acardio.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Pregunta sencilla de diagnóstico diferencial entre las hemorragias del primer trimestre. La presencia de un embrión acorde con 8 semanas, (con gestación de 12 semanas), sin latido cardíaco, indica que nos encontramos ante un aborto diferido. Su tratamiento es el legrado, previa administración de prostaglandinas si la gestación es mayor de 12 semanas. (Respuesta 2 CORRECTA). La clínica que nos cuentan no parece que se trate de un feto acardio ni de una gestación mal datada (sí que es cierto que la LCC se emplea para determinar la edad gestacional en el primer trimestre, pero en este caso, la ausencia de latido cardíaco descarta que la gestación esté mal datada). Por último, la clínica no es compatible con gestación ectópica ni enfermedad trofoblástica gestacional, por lo que no parece útil determinar los niveles de Beta-HCG.

168. Una de las siguientes aseveraciones sobre el ganglio centinela en el cáncer de mama es cierta:

1. El ganglio centinela es el primer ganglio que recibe el drenaje linfático del tumor primario.
2. El ganglio centinela es el primer ganglio metastatizado.
3. Para su correcta localización es imprescindible la inyección de un colorante en la zona peritumoral (azul de isosulfan).
4. La existencia de una adenopatía axilar palpable en una paciente con un tumor de 3 cm de diámetro se considera una contraindicación a la técnica de detección.

Respuesta correcta: 1**Comentario:**

Pregunta que no podemos fallar porque es un concepto que ya ha sido preguntado con anterioridad en el mir. El ganglio centinela es el primero que recibe el drenaje linfático de toda la mama y por tanto del tumor primario (Respuesta 1 correcta, respuesta 2 incorrecta). Para localizarlo se puede emplear un colorante, pero también se usa un radiofármaco (99mTC), que se detecta por gammacámara (respuesta 3 incorrecta). Las adenopatías palpables no contraindican de forma absoluta la realización de biopsia de ganglio centinela pues pueden tratarse de adenopatías reactivas y no afectas por el tumor (respuesta 4 incorrecta).

169. Neonato de 17 horas de vida, trasladado desde un hospital comarcal sin cuidados intensivos. Embarazo con diabetes gestacional. Parto espontáneo, cefálico, amniorrexia 11 horas antes, con líquido claro. La edad gestacional es de 36 semanas. En la exploración física se observa mal estado general, color terroso de piel, cianosis acra, taquipnea, aleteo nasal, retracciones intercostales y quejido. FC: 150 l.p.m. FR: 80 r.p.m. Buena ventilación bilateral. Se palpa hígado a 1 cm., llanto agudo, hipotonía generalizada. T.A.: 47/31 mm Hg. ¿Cuál sería la sospecha clínica?:

1. Hemorragia cerebral.
2. Sepsis.
3. Fenilcetonuria.
4. Enfermedad de las membranas hialinas.

Respuesta correcta: 2**Comentario:**

Nos encontramos ante un neonato con mal estado general y una serie de signos que indican patología en los recién nacidos, como son cianosis, piel terrosa, hipotonía, hipotensión arterial, taquipnea y taquicardia. Este conjunto de signos, pese a ser inespecíficos, nos orientan hacia sepsis como principal sospecha diagnóstica (respuesta 2 CORRECTA).

170. La valoración del desarrollo psicomotor constituye una exploración importante para detectar trastornos del desarrollo durante la primera infancia. ¿A qué edad el 50% de los lactantes deben mantenerse sentados sin ayuda?:

1. A los 4 - 5 meses.
2. A los 5 - 6 meses.
3. A los 6 - 7 meses.
4. A los 7 - 8 meses.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Pregunta puramente teórica sobre los hitos del desarrollo de los lactantes. Sólo debemos recordar que a los 5-6 meses, el 50% de los niños se sientan CON ayuda, mientras que de 6-7 meses, el 50% de los niños se sientan SIN ayuda (respuesta 3 CORRECTA).

171. Niño de 2 meses que acude a urgencias por tos intensa. Dos semanas antes había comenzado con congestión respiratoria superior y tos leve, etiquetándose el cuadro por un pediatra como un cuadro catarral. La tos empeoró hasta causar vómitos y episodios de apnea con cianosis. Su madre también ha presentado tos durante varias semanas. Durante el examen físico el niño comenzó a toser, persistiendo ésta durante más de 30 segundos, con jadeo inspiratorio, y cierto grado de cianosis. Después de dejar de toser el niño estaba agotado, con llanto débil. Analíticamente se observó una leucocitosis de 34.000 con un 85% de linfocitos. ¿Cuál es el agente etiológico más probable de este cuadro?:

1. Chlamydia trachomatis.
2. Adenovirus.
3. Bordetella pertussis.
4. Bordetella parapertussis.

Respuesta correcta: 3**Comentario:**

Nos presentan un niño con un cuadro inicial de rinorrea, que evoluciona a una fase con tos paroxística con un jadeo inspiratorio (o "gallo"), que llega a producir cianosis. Esta es la clínica típica de las Tos ferina, enfermedad bacteriana

causada por Bordetella pertussis (respuesta 3 CORRECTA). Como nos presenta la pregunta, suele cursar con leucocitosis con linfocitosis absoluta. El tratamiento de elección son los macrólidos, y la complicación más frecuente es la neumonía. La profilaxis se realiza mediante vacunación universal.

172. Niño de 2 meses de edad que acude a Urgencias por presentar rinorrea clara y fiebre de 38°C en los tres últimos días. Desde hace 24 horas, tiene tos en accesos y dificultad respiratoria progresiva. En las últimas 12 horas rechaza todas las tomas. En los antecedentes personales destaca un embarazo y parto normal, es alimentado con lactancia materna. Ha recibido la primera dosis de DTP acelular, haemophilus influenzae tipo B, Meningococo C, Polio oral y 2 dosis de Hepatitis B. En la exploración destaca una frecuencia cardíaca de 135 lpm, una frecuencia respiratoria de 55 rpm y una saturación de O₂ con aire ambiental de 90%. Polipnea con tiraje intercostal y subcostal leve-moderado y en la auscultación destaca la presencia de subcrepitanes y sibilancias generalizadas. Ante este paciente, ¿qué diagnóstico de presunción realizaría?:

1. Crisis asmática.
2. Bronquiolitis.
3. Neumonía.
4. Tos ferina.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Caso típico de bronquiolitis aguda, cuadro que hay que conocer bien (respuesta 2 CORRECTA). Se describe como el primer episodio de sibilancias en menores de dos años. El agente que más se relaciona es el VRS. La clínica típica es la que nos describen en el caso clínico, es decir, lactante de pocos meses de edad que comienza con infección respiratoria de vías altas, con rinorrea y fiebre, que va progresando a dificultad respiratoria, tos paroxística y sibilancias. En la exploración es frecuente apreciar tiraje, aleteo nasal y taquipnea. El diagnóstico es clínico fundamentalmente, y el tratamiento de soporte. El pronóstico en general es bueno una vez pasada la fase crítica, que son las primeras 48 horas.

173. En la evaluación de un niño con faringoamigdalitis aguda, señale cuál de los siguientes datos clínicos NO sugiere una etiología estreptocócica:

1. Petequias en el paladar blando.
2. Fiebre y odinofagia de comienzo brusco.
3. Exantema de tipo escarlatiniforme.
4. Vesículas o úlceras en la mucosa orofaríngea.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La exploración típica de una amigdalitis bacteriana estreptocócica encontramos adenopatías cervicales, sobre todo a nivel yugulodigástrico, fiebre, odinofagia (respuesta 2 co-

rrecta), faringe enrojecida con petequias en paladar blando (respuesta 1 correcta), exantema escarlatiniforme (respuesta 3 correcta), otalgia refleja... En cambio, la presencia de vesículas en mucosa orofaríngea es típico de una etiología vírica (respuesta 4 INCORRECTA) al igual que cuadro catarral asociado.

174. Un lactante de 35 días de vida acude a urgencias por presentar vómitos proyectivos, de contenido no bilioso, en cantidad y frecuencia progresivos desde hace 3 días, con presencia de pequeñas estrías de sangre en los últimos vómitos. A la exploración presenta aceptable estado de hidratación, ligera ictericia y abdomen sin hallazgos destacables a la palpación. ¿Qué exploración complementaria solicitaría para confirmar el diagnóstico?:

1. Esofagoscopia.
2. Tránsito digestivo baritado.
3. Analítica bioquímica hepática.
4. Ecografía abdominal.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Caso clínico típico de una estenosis hipertrófica de píloro en el que nos describen los hallazgos más frecuentes de la anamnesis y la exploración de esta enfermedad. Es típico de lactantes, después de los 21 días de edad, más frecuente en varones primogénitos. Cursa con vómitos no biliosos en escopetazo, que llegan a producir alcalosis metabólica hipoclorémica. Puede existir ictericia en el 5% de los casos. A veces, se puede palpar la oliva pilórica en forma de pasa dura y móvil. La técnica de elección para el diagnóstico es la ecografía abdominal (respuesta 4 CORRECTA). El tratamiento de elección es la pilorotomía extramucosa de Ramstedt.

175. Con relación al tratamiento del hipotiroidismo congénito, indique la respuesta correcta:

1. Es necesario tener un diagnóstico etiológico antes de iniciar el tratamiento.
2. Han de normalizarse los niveles de tiroxina de manera progresiva para evitar efectos secundarios.
3. El retraso en su inicio puede condicionar una lesión cerebral definitiva.
4. Ha de retirarse a los 3 años a todos los pacientes para descartar que sea transitorio.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

De esta pregunta la idea más importante que nos debe quedar es que el tratamiento del hipotiroidismo congénito debe realizarse lo antes posible, pues si lo iniciamos después de la semana de vida existe riesgo de retraso mental (opción CORRECTA 3). El cribado se realiza entre las 48 horas y los 5 días de vida, mediante la determinación de TSH. Niveles inferiores a 10 mcu/ml descartan hipoti-

roidismo congénito, mientras que niveles superiores a 50 diagnostican esta patología. El tratamiento en todos los casos es con levotiroxina sódica.

176. Paciente de 7 años de edad que consulta por aumento de tamaño de la bolsa escrotal derecha, siendo derivado a la consulta de Cirugía para descartar hidrocele o hernia inguinal. Es visto en la consulta de Cirugía tres semanas más tarde donde aprecian edema escrotal y de pene, edema palpebral y edema de miembros inferiores siendo remitido a Urgencias. No refiere oliguria. Exploración: FC: 90 l.p.m. T.A.: 105/65 mmHg. Ta: 36,5°C. Sat O2: 98%. Buen estado general, color pálido de piel. Edemas palpebrales bilaterales. Edema con fovea hasta raíz de miembros inferiores. Edema escrotal y peneano. Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen distendido, no doloroso, con aparente ascitis sin visceromegalias, ni masas anormales. ORL: normal. Antecedentes personales sin relevancia. Antecedentes familiares: Padre con diabetes insulino dependiente. ¿Cuál sería su primera sospecha diagnóstica?:

1. Insuficiencia cardíaca.
2. Síndrome nefrótico.
3. Glomerulonefritis proliferativa.
4. Insuficiencia hepática.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Nos encontramos ante un caso clínico en el que describen a la perfección las características de un síndrome nefrótico (respuesta 2 CORRECTA). Hablamos de síndrome nefrótico clínico ante la presencia de proteinuria, Edemas e Hipoalbuminemia. Hablamos de síndrome nefrótico bioquímico cuando tenemos una proteinuria superior a 3 g/24h en adultos, o bien superior a 30mg/metro cuadrado/hora en niños. En la pregunta no nos indican nada acerca de la bioquímica urinaria, pero la presencia de edemas blandos, con fovea, que aparecen a nivel escrotal, palpebral y de miembros inferiores, junto con ascitis en un niño sin otros antecedentes y por lo demás con buen estado general, nos orienta claramente hacia el síndrome nefrótico como respuesta a marcar.

177. ¿Cuál de estos datos de la Historia Clínica, NO constituye un factor de riesgo de hipoacusia en la infancia?:

1. Infección en el embarazo por toxoplasmosis.
2. Administración de corticoides durante el embarazo.
3. Bajo peso al nacer (menos de 1500g).
4. Hiperbilirrubinemia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Pregunta que podemos acertar por descarte. Vamos a ir repasando las distintas opciones. -La infección por toxoplas-

ma puede producir en el feto distintos tipos de afectaciones neurológicas, entre las que está incluida la hipoacusia neurossensorial, además de coriorretinitis, convulsiones, calcificaciones e hidrocefalia, que constituirían la tetrada de Sabin (respuesta 1 correcta). -El bajo peso al nacer es un factor de riesgo para multitud de patologías, y un peso al nacer por debajo de los 1500 gramos está asociado a un 50% de morbilidad. En la mayoría de los casos se asocia con prematuridad, y el abanico de complicaciones relacionadas en inmenso (ictericia, hemorragias, distrés respiratorio, ductus persistente, alteraciones electrolíticas, enfermedad hipóxico-isquémica, sordera... (respuesta 3 correcta). -La hiperbilirrubinemia por exceso de bilirrubina Indirecta puede producir afectación de los gánglios de la base, la llamada ictericia nuclear. Cursa de manera progresiva, inicialmente con convulsiones, opistótonos, letargia..., seguido después de una creciente hipotonía y movimientos irregulares, para conducir después a coreoatetosis, espasmos, retraso mental y sordera para los sonidos de alta frecuencia (respuesta 4 correcta). - No se ha relacionado la administración de corticoides en el embarazo con el posterior riesgo de hipoacusia en el niño (respuesta 2 INCORRECTA). De hecho, la administración de corticoides en el embarazo reduce la incidencia de distintas patologías, como son neumotórax, ductus persistente, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante y enfermedad de membrana hialina.

178. Ante un paciente de 6 años que acude a urgencias tras haber sufrido una caída fortuita desde un columpio, presentando intenso dolor, deformidad e impotencia funcional en el codo izquierdo, deberemos sospechar en primer lugar:

1. Fractura de cúbito y radio con luxación de cabeza radial.
2. Fractura-luxación de la cabeza radial.
3. Fractura del olécranon y luxación de cabeza radial.
4. Fractura supracondílea del codo.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Estamos ante un caso clínico típico y habitual en la práctica clínica diaria. Ante un niño que se cae del columpio y presenta dolor y deformidad en el codo, lo primero que debemos pensar es que se trata de una fractura supracondílea de codo (respuesta 4 CORRECTA). Esta fractura se produce típicamente al caer con el brazo extendido, y es una de las más frecuentes en los niños. El tratamiento puede ser conservador, con inmovilización del brazo en flexión, o bien quirúrgico, con agujas, en caso de que sea una fractura desplazada (es la fractura más intervenida en la población pediátrica). Las complicaciones más importantes de esta fractura son la posibilidad de aparición de un síndrome compartimental, las deformidades residuales (cubito valgo, que puede terminar provocando una lesión tardía en el nervio cubital), o bien la lesión inicial de los nervios radial, interóseo anterior o arteria braquial.

179. Un niño varón de seis años es traído a la consulta tras apreciar en la revisión escolar que presenta un arco plantar excesivo. A la exploración efectivamente se aprecia un arco plantar marcado, así como un retropié con deformidad en varo. ¿Cuál debe ser la siguiente actuación médica?:

1. Revisión en un año.
2. Plantillas correctoras del arco plantar.
3. Plantillas de cuña pronadora de retropié.
4. Exploración neurológica y raquídea detallada.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Nos están describiendo un pie cavo, que se caracteriza por un arco plantar excesivo y una desviación en varo del talón, todo lo contrario que el pie Plano que suele tener el retropié en valgo. El pie cavo puede ser idiopático, pero también puede asociarse a patología neuromuscular, por lo que siempre está indicado inicialmente realizar una cuidadosa exploración neurológica a aquel niño en que detectemos un pie cavo, para descartar la presencia de una posible parálisis cerebral, Charcot Marie Tooth o mielomeningocele entre otras patologías (respuesta 4 CORRECTA). El tratamiento es conservador al inicio, con ortesis, estando indicada la cirugía en caso de que fracasara el tratamiento conservador.

180. Está atendiendo actualmente a su último paciente citado de la jornada. Escucha que le dan golpes en la puerta de su despacho de manera enérgica. Es su primer paciente de la mañana que entra elevando la voz: “ es usted un incompetente, después de tardar una hora en transporte público de vuelta a mi casa, y hacer cola en la farmacia, la farmacéutica que es muy amiga mía, me dice que esta receta es de estupefacientes y necesita un sello especial que usted no me ha puesto! Por su culpa no me ha dado el medicamento ese!” “ No tiene ni idea de medicina y voy a poner una reclamación para que le despidan!” ¿cuál sería la opción más adecuada?

1. Usted llama a seguridad inmediatamente, no pueden despedirle por un descuido.
2. Le cierra la puerta y pone el pestillo para que no pueda volver a entrar.
3. Le pide que salga y que solicita una nueva cita en el mostrador de administración para poder atenderle debidamente. Es una falta de respeto esta situación para el paciente que se encontraba ya dentro de su consulta siendo atendido por usted.
4. Le pide disculpas en primer lugar, sintiendo mucho el error y las molestias causadas. A continuación coge usted el sello que precisa y le pide por favor, que salga junto a usted de la consulta donde se encuentra el otro paciente, para poder rellenarle correctamente la receta sin molestarle.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja. En este tipo de preguntas, que ya han caído en el MIR, debemos pensar con lógica y aplicar la ética y moral de la sociedad: pedir disculpas por nuestro error, intentar solventarlo lo mejor posible, sin ofender ni gritar ni perder los modales.

181. Usted es residente en un Hospital, donde se entera de que está ingresado un conocido de su pueblo. Se mete en la historia clínica electrónica y descubre que se encuentra ingresado por una ETS (enfermedad de transmisión sexual). Usted se lo cuenta a una persona de confianza que conoce también a dicho paciente. A su vez, esta persona, se lo cuenta a otra y a otra... El propio paciente se entera y le denuncia por delito de descubrimiento y revelación de secreto profesional. ¿Qué cree que puede pasarle a usted, como médico?:

1. Le condenarán a pagar una indemnización al paciente.
2. Le condenarán a pedir disculpas al paciente.
3. Le recordarán los principios éticos que todo personal sanitario debe conocer y cumplir, siendo uno de ellos la confidencialidad y el secreto profesional, pero no pueden condenarle a nada más.
4. Le condenarán a pagar una multa, a pagar una indemnización al paciente, le inhabilitarán por el tiempo que consideren oportuno y pueden, incluso, condenarle a un año de prisión.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Pregunta de dificultad baja, si usamos el sentido común. Infringir el secreto profesional es un delito, que se castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años, multas, indemnización al perjudicado e inhabilitación especial para la profesión por un tiempo de dos a seis años.

182. Paciente de 65 años, a la cual usted recomienda intervenir para colocar una prótesis en su rodilla derecha debido a su avanzada artrosis. La paciente le cuenta que a su vecina le operaron hace unos años y “quedó muy mal”. Por lo que ella decide que no quiere operarse, a pesar de sus explicaciones y recomendaciones. ¿Qué debe hacer usted?:

1. Dejar reflejado en su historia clínica que a pesar de explicarle el procedimiento, beneficios y riesgos, la paciente no desea operarse en estos momentos. Revisión en 6 meses para reevaluar.
2. Darle de alta y dejar reflejado en su historia clínica que se vuelva a citar con usted porque no sigue sus consejos, a pesar de ser un traumatólogo con amplia experiencia.

3. Poner en lista de espera para implantación de prótesis total de rodilla sin que la paciente se entere. Cuando la llamen para ingresar y operarse seguro que recapacita y hace caso a su médico que es usted.
4. Solicitar evaluación por psiquiatría para valorar si está capacitada legalmente para decidir o no, y solicitar que firme el Consentimiento Informado un familiar que si crea que lo correcto es intervenirla.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Pregunta de dificultad baja debido a que es un tema ya preguntado previamente en el MIR. Paciente mayor de edad que decide no operarse y por tanto no dar su consentimiento para la cirugía. Es una paciente capaz para tomar decisiones, salvo que nos especificasen lo contrario, por tanto hay que respetar su voluntad. La citamos para revisión en unos meses y reevaluar. Puede ser que más adelante acepte la cirugía, pero por ahora no. No hay que contactar con el psiquiatra salvo que sospechemos que no es capaz de tomar decisiones sobre su salud, ni solicitar que nos firme el Consentimiento una familiar.

183. Paciente de 12 años, que va a someterse a una intervención quirúrgica por una fractura en el miembro superior derecho, tras caerse jugando al fútbol. Respecto al consentimiento informado, ¿cómo debe actuar usted como médico?:

1. Le explica el procedimiento a su paciente de 12 años, y si lo considera maduro y capaz de decidir, puede firmar él el consentimiento y no es necesario explicar nada a los padres.
2. Les explica a los padres del menor el procedimiento para que firmen el consentimiento informado. No es necesario explicarle nada al menor, puesto que no va a firmar el consentimiento.
3. Debemos explicar el procedimiento tanto al menor como a sus padres. Escuchar la opinión y dudas del menor y finalmente solicitar a los padres que firmen el consentimiento informado.
4. No se precisa consentimiento al tratarse de un menor, ya que prevalece el principio de "protección y beneficio del menor".

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media. Consentimiento informado en el menor: debemos explicar el procedimiento tanto al menor como a sus padres. Resolver las dudas de ambos y considerar la opinión del menor, si éste se considera un menor maduro (no hay edad escrita para considerar un menor maduro o no, generalmente a partir de los 12 años pueden considerarse menor maduro si es capaz de comprender la situación). Pero finalmente al ser un menor de edad legal, el consentimiento lo firman sus padres o representantes legales. Conclusión: se explica y se habla tanto con el menor

maduro como con los padres/representantes legales, se escucha la opinión del menor, y los padres firman tras ello, el consentimiento informado.

184. Sobre el error de tipo I cuando se estudian las diferencias entre dos tratamientos:

1. Se llama también riesgo Beta.
2. Su opuesto representa la potencia de la prueba.
3. Lleva a concluir que hay una diferencia, cuando en realidad no la hay.
4. Implica que la hipótesis nula estaba mal planteada.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Existen dos errores en epidemiología: los errores aleatorios (producto del azar) y los errores sistemáticos o sesgos (por errores en la metodología). Dentro de los primeros hay dos tipos: el error tipo I o alfa, que es la probabilidad de detectar diferencias cuando realmente no existen, es decir, aceptar la hipótesis alternativa siendo falsa (es un FP) y el error tipo II o beta, que es la probabilidad de no detectar diferencias cuando realmente existen, es decir, de rechazar la hipótesis alternativa siendo verdadera (es un FN). La potencia, es el complementario del error beta (1-beta) y es la máxima capacidad de un test de detectar diferencias cuando realmente existen (aceptar la hipótesis alternativa siendo cierta). Los errores aleatorios se corrigen o disminuyen aumentando el tamaño muestral.

185. En investigación clínica el diseño que mejor evalúa el efecto de los fármacos en el ser humano es:

1. Estudio observacional prospectivo.
2. Estudio observacional retrospectivo.
3. Ensayo clínico aleatorizado controlado prospectivo.
4. Ensayo clínico aleatorizado controlado retrospectivo.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Pregunta repetida constantemente en el examen MIR: El ensayo clínico aleatorio es la evidencia más sólida para estudiar relaciones causa-efecto, porque existe asignación aleatoria de los individuos a los diferentes grupos de tratamiento. El ensayo clínico debe ser concurrente, es decir, que los dos grupos se seleccionan, tratan y siguen durante el mismo periodo de tiempo, simultáneamente. Si no es concurrente el grupo control puede ser histórico, pero la validez de las conclusiones exigiría presumir que las características de la población y todas las circunstancias implicadas fueron similares en el pasado, y esto es muy difícil de probar. Del mismo modo debe ser prospectivo y no retrospectivo. La única situación en la cual el mejor estudio para encontrar una relación causa-efecto no es un experimental es cuando no es ético realizarlos. Por ejemplo, para ver la relación entre tabaco y cáncer de vejiga, habrá que realizar un diseño ob-

servacional, un cohortes (el observacional que mayor grado de evidencia aporta) ya que un experimental sería inmoral.

186. ¿Cuál de las siguientes características es propia de los ensayos clínicos pragmáticos o naturalísticos?:

1. Evalúa la efectividad de las intervenciones más que su eficacia.
2. Necesita un número menor de pacientes que los ensayos clínicos explicativos.
3. Incluye una población muy homogénea.
4. Tiene unos criterios de inclusión muy estrictos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Dentro de los ensayos clínicos hay dos tipos en función de cómo sean los criterios de inclusión (o exclusión) usados para seleccionar a los pacientes. Si estos criterios son muy laxos, es decir, muy amplios, seleccionaremos una muestra muy heterogénea y por tanto más parecida a lo que se ve en la práctica clínica diaria. Este tipo de ensayos se usan en la fase III y IV de los ensayos clínicos donde se requiere un mayor tamaño muestral que en fases anteriores y tiene gran validez externa y escasa validez interna. Por el contrario, si los criterios son estrictos, nos encontraremos ante un ensayo clínico explicativo, con una muestra muy homogénea, con gran validez interna y escasa externa, que se usa en las fases II y III. Los ensayos clínicos pragmáticos por tanto evalúan una eficacia que se parece mucho ya a la efectividad de las intervenciones. Recordemos que EFECTIVO= “in vivo”, EFICAZ= “en el matraz” y EFICIENTE= “para el gerente”.

187. ¿Cuál de las siguientes características es propia de las fases precoces de la investigación con un nuevo fármaco?:

1. Se prioriza la validez externa de los estudios.
2. Se incluyen pacientes parecidos a la población susceptible de recibir el fármaco.
3. Se miden parámetros farmacodinámicos o variables intermedias.
4. La duración de los estudios es más larga que en fases avanzadas.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Un ensayo clínico cuenta con cuatro fases sucesivas pero que pueden superponerse. En la fase I se estudia el comportamiento de un fármaco (farmacocinética y farmacodinamia) y se verifica la seguridad del nuevo principio activo en voluntarios sanos salvo en el caso de la quimioterapia u otros tratamientos tóxicos donde se utilizarán voluntarios enfermos (DOSIS MÁXIMA NO TÓXICA y efectos secundarios graves). La fase II verifica la eficacia del nuevo fármaco (DOSIS EFICAZ) y delimita el intervalo de dosis terapéuticas ya en sujetos con la enfermedad. La fase III es el ensayo clínico controlado y aleatorizado propiamente dicho y pretende verificar la eficacia y la seguridad a corto y largo plazo (EFICACIA COMPARADA y efectos secundarios

frecuentes e inmediatos). La fase IV o de postcomercialización evalúa la seguridad y efectividad de un fármaco en la práctica clínica habitual (efectos secundarios poco frecuentes y tardíos). En la fase II y III se realizan ensayos clínicos explicativos y en la III-IV pragmáticos.

188. Cuando leemos un ensayo clínico publicado en una revista científica, debemos comprobar si se cumplen una serie de características importantes para juzgar la validez de sus resultados. De las siguientes características, indique cuál es la MENOS relevante:

1. Asignación aleatoria del tratamiento.
2. Enmascaramiento de la intervención.
3. Características similares de los dos grupos de comparación al inicio del estudio.
4. Inclusión del mismo número de sujetos en todos los centros participantes.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

En ensayo clínico ideal es aquel que tiene como características: 1) criterios de inclusión (según protocolo), 2) consentimiento informado, 3) experimental, 4) aleatorizado, 5) enmascaramiento, 6) concurrente, 7) dos o más grupos comparables, 8) análisis por intención de tratar. Pero no necesariamente debe haber el mismo número de sujetos de todos los centros si estos presentan características pronósticas comparables.

189. Suponga que en el grupo experimental de un ensayo clínico con antiarrítmicos, la incidencia de eventos de interés (arritmias y muertes por causas cardíacas) se reduce de forma estadísticamente significativa con respecto al grupo control. Sin embargo, la mortalidad por todas las causas es superior en el grupo experimental. ¿Es correcto concluir a favor del fármaco experimental?:

1. No, ya que la mayor mortalidad global en uno de los grupos puede haber reducido las oportunidades de sufrir eventos de interés entre los pacientes a él asignados.
2. Sí, ya que la mortalidad por causas no cardiovasculares no tiene nada que ver con el problema que estudia ese ensayo clínico.
3. Sí, si los dos grupos son homogéneos en cuanto al pronóstico antes de iniciar el tratamiento; no en caso contrario.
4. Sí, si el ensayo se diseñó para valorar diferencias en arritmias y muertes cardíacas.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta se repitió casi literalmente en el MIR 2003 (salvo que en aquel momento era por infarto de miocardio en vez de arritmias). En el grupo experimental se pueden producir menores episodios de arritmias y muertes cardíacas

por no tener tiempo al haber fallecido por otras causas. Es decir, las diferencias entre grupos pueden alterar los resultados a favor de uno de ellos. Por eso es importante disponer de grupos comparables, es decir, grupos en los que las características basales sean homogéneas fundamentalmente en las características pronósticas (edad por ejemplo). En caso de existir diferencias importantes entre ellos se hace necesario realizar una técnica estadística adecuada para controlarse.

190. Se han realizado dos ensayos clínicos controlados con placebo para comprobar el beneficio del metoprolol en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio. En el primero se incluyeron pacientes de alto riesgo y la mortalidad se redujo de un 40% con placebo a un 20% con metoprolol. En el segundo se incluyeron pacientes de bajo riesgo y la mortalidad se redujo de un 10% con placebo a un 5% con metoprolol. A la hora de interpretar estos resultados ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta?:

1. Si los recursos son limitados es más rentable tratar a los pacientes de mayor riesgo porque se obtiene un beneficio absoluto mayor.
2. El metoprolol es más eficaz en los pacientes de alto riesgo porque reduce el riesgo relativo de mortalidad un 20% en los pacientes de alto riesgo y solo un 5% en los de bajo riesgo.
3. El riesgo relativo es igual en los dos grupos de pacientes (0,5).
4. El beneficio absoluto es mayor en los de alto riesgo porque evita 20 muertes por cada 100 pacientes tratados frente a solo 5 muertes por cada 100 pacientes tratados de bajo riesgo.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La reducción absoluta del riesgo (RAR) es una medida de impacto absoluta que expresa la diferencia entre la incidencia en no expuestos al factor (metoprolol) y en expuestos: $40\%-20\%=20\%$ en el grupo del alto riesgo y $10\%-5\%=5\%$ en el de bajo riesgo. Por tanto, como dice la respuesta 1 si los recursos son limitados es más rentable tratar a los pacientes de alto riesgo. La RRR, que es lo que nos expresa la opción 2 (reducción relativa del riesgo) es el cociente entre la diferencia de incidencia en no expuestos y si expuestos dividida entre la incidencia en no expuestos: $40-20/40=0,5$ en los de alto riesgo y $10-5/10=0,5$ en los de bajo riesgo. Por tanto la falsa es la dos.

191. ¿Cuál de las siguientes es una ventaja de los estudios de cohortes?:

1. Son adecuados para estudiar enfermedades con largo periodo de inducción.
2. Son generalmente menos costosos en tiempo y dinero que los estudios de caso y controles.
3. Son útiles para medir los efectos de exposiciones infrecuentes en la población.

4. Son muy adecuados para estudiar las causas de enfermedades infrecuentes.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Estilo de pregunta frecuente en el MIR. Las respuestas 1, 2 y 4 son características propias de los estudios casos y control. La única que es característica de los estudios de cohortes es la 3. Ante una exposición infrecuente, es mejor seguir a pacientes con la misma hasta que desarrollen las complicaciones de la misma, y no ir de la complicación o efecto a la causa, ya que al ser ésta muy infrecuente puede que no encontremos ningún caso. Por ejemplo, para ver la relación entre fibrosis quística y broncoespasmo, es mejor seguir a pacientes con fibrosis quística y ver si desarrollan broncoespasmo, y no partir de pacientes con broncoespasmo (una entidad muy frecuente en pacientes con otras patologías como el asma) y ver si previamente tenían fibrosis quística.

192. Los ensayos clínicos de diseño cruzado:

1. Reclutan un número de pacientes superior al de un diseño paralelo con objetivo similar.
2. Todos los pacientes reciben todos los tratamientos estudiados.
3. No emplean placebo.
4. No requieren consentimiento informado del sujeto.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Un ensayo clínico paralelo es aquel en el que cada individuo recibe un único tratamiento independiente del otro y los resultados obtenidos en los grupos que se comparan entre sí. En el ensayo clínico cruzado cada individuo recibe todos los tratamientos secuencialmente. A diferencia del estudio paralelo, en el análisis estadístico de un diseño de grupos cruzados deben tenerse en cuenta los factores tiempo, tratamiento y secuencia. Como ventajas un ensayo clínico cruzado en comparación con el paralelo tiene que necesita menos tamaño muestral, pues cada sujeto está en los dos grupos (más eficiente), y hay menos variabilidad intraindividual o intragrupal pues cada sujeto actúa como su propio control. Pero la variabilidad interindividual no se modifica. Como inconvenientes tenemos que las pérdidas son más relevantes, que requiere más tiempo por el periodo de lavado de los fármacos, la posible existencia de efecto secuencia o residual (influencia de fármaco A en B o en placebo) y de efecto periodo (la enfermedad puede variar en su comportamiento y coincidir con el cruce de fármacos, interpretándose erróneamente como efecto de los fármacos) y que este tipo de estudios no puede usarse en medidas preventivas, en enfermedades con tratamiento curativo, enfermedades que cursan en brotes impredecibles y en enfermedades infecciosas.

193. La probabilidad de que un individuo tomado aleatoriamente en una serie de sujetos de estudio tenga un resultado negativo en las pruebas diagnósticas si realmente no tiene la enfermedad se denomina:

1. Sensibilidad.
2. Especificidad.
3. Proporción de falsos negativos.
4. Proporción de falsos positivos.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La sensibilidad es la probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba estando enfermo, es decir, la proporción de enfermos que obtienen un resultado positivo en la prueba $VP/(VP+FN)$. La especificidad es la probabilidad de obtener un resultado negativo en la prueba estando sano, es decir, la proporción de sanos que obtienen un resultado negativo en la prueba $VN/(FP+VN)$. La tasa de falsos negativos es la probabilidad de obtener un resultado negativo en la prueba estando enfermo, es decir, la proporción de enfermos que obtienen un resultado negativo en la prueba $FN/(VP+FN)$. La tasa de falsos positivos es la probabilidad de un resultado positivo en la prueba estando sano, es decir, la proporción de sanos que obtienen un resultado positivo (falso positivo) en la prueba $FP/(FP+VN)$. El valor predictivo positivo es la probabilidad de estar enfermo si se ha obtenido un resultado positivo en la prueba, es decir, la proporción de verdaderos positivos de entre el total de resultados positivos $VP/(VP+FP)$.

194. El sesgo amnésico que puede producirse en los estudios de casos y controles:

1. Es un sesgo de selección.
2. Es un sesgo de clasificación diferencial.
3. Es un sesgo de clasificación no diferencial.
4. Es un sesgo de confusión.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Los sesgos o errores sistemáticos son errores en la recolección, análisis, interpretación, publicación o revisión de los datos. Se clasifican en sesgos de selección, sesgos de clasificación, información o medida, sesgo por factor de confusión y sesgo de atrición. El sesgo de selección se produce al elegir incorrectamente la muestra y se soluciona utilizando técnicas de aleatorización. Dentro de éste se incluyen el sesgo del voluntario, el sesgo de diagnóstico o de Berkson, la falacia de Neyman y el sesgo del obrero sano. El sesgo de información se produce al clasificar erróneamente a los participantes del estudio y se soluciona empleando técnicas de enmascaramiento o "masking". Hay dos tipos de este último sesgo: los diferenciales (el sesgo se produce solo en uno de los grupos) y los no diferenciales (en ambos grupos). En el sesgo de información diferencial se incluyen el sesgo de memoria o amnésico y el de atención o de Hawthorne, y en ellos se puede tanto sobre- como infraestimar el factor de riesgo. En los no diferenciales se infraestima siempre el factor de riesgo. El sesgo de confusión se produce porque una variable ajena al estudio modifica los resultados obtenidos. Esta variable ajena es factor de riesgo para la enfermedad, factor de riesgo para el factor de riesgo y no ha de ser factor intermedio entre el factor de riesgo y la enfermedad. Por

último el sesgo de atrición se produce por diferencias sistemáticas en abandonos, pérdidas o cumplimiento terapéutico entre los grupos de comparación y se evita por el análisis de intención de tratar. El sesgo de memoria o amnésico, típico de los estudios caso-control, producen una sobredimensión del factor de riesgo, al recordar los casos habitualmente mejor las exposiciones implicadas en el pasado.

195. ¿Cuál de entre las siguientes es una de las principales ventajas de los estudios casos-control?:

1. Son especialmente útiles para medir los efectos de exposiciones infrecuentes en la población.
2. Miden la relación entre la exposición y varias enfermedades.
3. Evitan el sesgo de supervivencia.
4. Permiten valorar, en el contexto de una determinada enfermedad, diferentes factores etiológicos simultáneamente.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Las ventajas de un estudio casos y controles son 1) necesitan pequeño tamaño muestral, 2) no necesitan seguimiento, 3) son de corta duración y bajo coste, 4) fácil reproducibilidad, 4) útiles para enfermedades raras, de largo periodo de latencia y/o enfermedades crónicas, 5) permiten evaluar la multicausalidad (diferentes factores etiológicos para una misma enfermedad) (opción 4). Como inconvenientes, generan gran cantidad de sesgos especialmente de selección e información y por tanto son poco útiles para comprobar hipótesis; además es difícil establecer una secuencia temporal y con ellos no se pueden calcular medidas de frecuencia (incidencia principalmente) y es complicado conseguir un grupo de control adecuado. Las opciones 1 y 2 son propias del estudio de cohortes y como hemos comentado anteriormente es un estudio que recae en gran cantidad de sesgos (opción 3 falsa).

196. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los estudios de casos y controles apareados?:

1. Es posible seleccionar más de un control por cada caso.
2. Son estudios de diseño cruzado.
3. Cada sujeto actúa como su propio control.
4. Se realiza un seguimiento prospectivo de los sujetos seleccionados, que es concurrente para los casos y para los controles.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

La forma más simple de estudio casos y control es aparear cada caso con un control (1:1) según un factor/es que se considera/n susceptibles de ser factores de confusión. De esta forma el control tiene el mismo valor de la variable confundente que el caso. Las principales variables de apareamiento son género y edad, aunque puede haber muchas otras

(raza, estado civil...). En este diseño los casos y controles están balanceados y por lo tanto cualquier diferencia entre ellos no puede deberse al factor confundente. Sin embargo, el apareamiento no garantiza la eliminación de los factores de confusión, ya que la recolección de datos es muy compleja, principalmente en el grupo control y no se puede estimar el efecto de la variable de apareamiento. Como generalmente existen muchos controles disponibles, en muchas situaciones puede ser posible aparear cada caso con varios controles (1:x). Las opciones 2 y 3 describen características de un ensayo clínico cruzado. Y por definición un estudio casos y control es retrospectivo y a veces se utilizan controles históricos y no concurrentes por tanto (opción 4 falsa).

197. Para tratar de establecer una relación causal entre el asma y el riesgo de enfermedad neumocócica invasiva (ENI) se seleccionaron pacientes con ENI y se compararon con otro grupo de pacientes sin ENI, en cuanto a sus antecedentes de asma. ¿Cuál es el tipo de diseño de estudio empleado?:

1. Estudio de cohortes.
2. Ensayo clínico aleatorizado.
3. Estudio ecológico.
4. Casos y controles.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

El estudio casos y controles es un tipo de estudio observacional analítico. A diferencia de los estudios de cohortes (otro de este grupo) donde se parte de la exposición y se realiza un seguimiento en el tiempo, en los estudios casos y controles se selecciona un grupo de individuos que tienen una enfermedad determinada (casos, en este ejemplo con ENI) y otro grupo de sujetos libres de enfermedad (controles, aquí sujetos sin ENI) y se investiga la previa exposición al factor estudiado (asma). No es un ensayo clínico porque no hay control del investigador sobre el factor de estudio ni tampoco asignación aleatoria. Un estudio ecológico es un estudio observacional descriptivo en el que la unidad a estudio no es el individuo, sino comunidades determinadas por criterios geográficos, y por tanto utilizan datos promedios aproximados o datos secundarios.

198. Deseamos investigar la hipótesis de que los fármacos antirretrovirales que se administran durante el embarazo para prevenir la transmisión vertical del HIV pueden afectar negativamente el aprendizaje en los niños expuestos intraútero a estos fármacos, independientemente de que estos niños resulten o no infectados por el HIV. De entre los siguientes diseños de estudios, ¿cuál es el más adecuado?:

1. Un ensayo clínico, que compare la prevalencia de retraso psicomotor en recién nacidos cuyas madres recibieron tratamiento antirretroviral en el embarazo, y en recién nacidos cuyas madres recibieron placebo.

2. Un estudio de cohortes, que compare la incidencia de retraso psicomotor en dos grupos de niños: uno de ellos infectado por el HIV y el otro grupo no infectado.
3. Un estudio de cohortes, que compare la prevalencia de retraso psicomotor en niños infectados por el VIH entre aquellos que fueron expuestos intraútero a antirretrovirales y los que no lo fueron.
4. Un estudio de cohortes, que mida la incidencia de retraso psicomotor en niños no infectados por el VIH, hijos de madres seropositivas, y estudie su asociación con la exposición intraútero a antirretrovirales.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La opción 1 no es correcta porque no es un estudio éticamente correcto, ya que ante una paciente VIH no se puede determinar al azar si toma tratamiento antirretroviral o no (debemos guiarnos por criterios clínico-serológicos). La opción 2 tampoco es correcta porque no hace referencia al efecto de los fármacos sobre el retraso psicomotor, sino únicamente si la propia infección por VIH tiene repercusión sobre el mismo. La opción 3 tampoco es correcta porque nos dice que compara la prevalencia y no la incidencia y además no elimina el factor de confusión que puede ser la propia infección del VIH que también puede relacionarse con el deterioro psicomotor (encefalopatía por VIH). La correcta es la opción 4, un estudio en el que se parte de niños no infectados por VIH (así se elimina el factor confusión de la infección por VIH) de madres seropositivas, unos expuestos a antirretrovirales y otros no expuestos y se compara la incidencia de retraso psicomotor.

199. Los denominados Grupos Relacionados por el Diagnóstico (o “GRD”) constituyen una herramienta de gestión que clasifica los episodios de hospitalización:

1. En función del proceso clínico y el consumo de recursos.
2. En función del proceso clínico sin tener en cuenta el consumo de recursos.
3. Sin tener en cuenta el proceso clínico solo en función del consumo de recursos.
4. Sin tener en cuenta el proceso clínico ni el consumo de recursos.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Los grupos relacionados con el diagnóstico (GDR) es un término que define grupos de pacientes con el mismo diagnóstico clínico y con iso-consumo (el mismo consumo) de recursos y servicios hospitalarios. Permite analizar los costes identificando los tipos de procedimientos cuya atención genera más gasto al sistema.

200. En un análisis coste-utilidad, la utilidad siempre la vamos a medir en:

1. Unidades monetarias.
2. Grado de efectividad.
3. Consecuencias clínicas obtenidas.
4. Años de vida ajustados por calidad.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La evaluación económica de un programa de salud es el estudio de los resultados obtenidos en base al coste de los recursos empleados. Consiste en realizar un análisis que compare los costes y las consecuencias de tales intervenciones. Se usan diversos análisis cuya unidad de coste es común: la unidad monetaria (euros) y difieren en la unidad que utilizan para evaluar el resultado. El análisis minimización de costes cuantifica los costes de dos o más procedimientos cuyas consecuencias son equivalentes. El análisis coste-efectividad compara el coste que supone en condiciones reales obtener un año de vida ganado, una curación, una muerte evitada... es decir, sus unidades de resultado son físicas. El análisis coste-utilidad analiza la cantidad y calidad de vida (AVAC o QALY, años de vida ajustado por calidad. El análisis coste-beneficio mide los costes y los efectos en términos económicos (euros).

201. Durante un ciclo cardiaco en un sujeto normal es cierto que:

1. La presión en el ventrículo es máxima durante la fase de contracción isovolumétrica o isovolumétrica.
2. La sístole auricular coincide exactamente con la onda P del electrocardiograma.
3. El complejo QRS sucede durante la fase de eyección o expulsión ventricular.
4. La presión arterial es máxima durante la fase de eyección o expulsión ventricular.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una pregunta totalmente teórica sobre el ciclo cardiaco. El ciclo cardiaco consta de varias fases. La sístole ventricular se inicia con el cierre de las válvulas AV (primer ruido cardiaco), que se sigue de una fase de contracción isovolumétrica y consiguiente apertura de las válvulas semilunares. A continuación una fase de contracción isotónica con la eyección ventricular y finaliza con el segundo ruido cardiaco (cierre de las válvulas semilunares). La diástole ventricular inicia con la relajación isovolumétrica y posterior apertura de las válvulas AV. Le sigue un llenado diastólico rápido, la fase de diástasis y finalmente la contracción auricular. La presión en el ventrículo es máxima en la fase de contracción isotónica. El complejo QRS corresponde a toda la sístole ventricular y no solo a la fase eyectiva. La sístole auricular coincide parcialmente con la onda P del EKG porque incluye toda la despolarización auricular. Por tanto la verdadera es que la presión arterial es máxima durante

la fase de eyección o expulsión ventricular. Debes conocer perfectamente el esquema de ciclo cardiaco, se adjunta en la imagen.

202. Triada de síntomas típicos del cáncer de páncreas:

1. Diabetes, pérdida de peso y diarrea.
2. Dolor epigástrico, ictericia y pérdida de peso.
3. Dolor en hipocondrio derecho, ictericia y fiebre.
4. Anorexia, diarrea y pérdida de peso.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

La combinación de síntomas más CORRECTA es la opción 2. El dolor epigástrico irradiado hacia ambos hipocondrios y espalda es el síntoma más frecuente. El signo más frecuente es la pérdida de peso. La ictericia aparece precozmente en los tumores de cabeza de páncreas. Es progresiva excepto en los ampulomas que es típicamente fluctuante. opción 1 FALSA: sería una pancreatitis crónica avanzada. opción 3 FALSA: sería a clínica de una colangitis. opción 4: con el sdr tóxico si que podría sospechar de ca páncreas, pero la combinación de estos síntomas no es tan específica como la opción 2.

203. Paciente de 65 años de edad, con antecedentes de diabetes, artrosis, claudicación intermitente gemelar bilateral y ausencia de cardiopatía. Acude a urgencias refiriendo dolor en reposo y frialdad de pie y pierna izquierda de 4 horas de evolución. La exploración muestra en miembro inferior izquierdo, pie pálido y frío y ausencia de pulsos a todos los niveles; en miembro inferior derecho, el pie está caliente con ausencia de pulso poplíteo y distales. El diagnóstico clínico más probable es:

1. Isquemia aguda de miembro inferior izquierdo por trombosis arterial.
2. Artrosis vertebral con estenosis del canal lumbar.
3. Isquemia aguda de miembro inferior izquierdo por embolia iliaca.
4. Neuropatía diabética de miembros inferiores.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos encontramos ante una oclusión arterial aguda. La causa más frecuente es la embolia arterial a partir de la existencia de una cardiopatía potencialmente embolígena, que en este paciente se ha descartado (así nos lo hace saber el enunciado, con lo que anulamos la opción tres). La segunda también es falsa porque en ningún caso nos hablan de una claudicación neurógena de la marcha. Una neuropatía diabética cursaría con parestesias y debilidad sin afectación macrovascular (presencia de pulsos). Por tanto la verdadera es la opción 1. Para detallar decir que se trata de un síndrome

de Leriche u obstrucción iliaca bilateral o aortoiliaca, que es la causa más frecuente de claudicación intermitente en varones jóvenes (40-45 años). Presenta clínica de claudicación intermitente distal a la obstrucción (glúteos, muslos y pantorrillas) con ausencia de pulsos distales bilateralmente. En este caso además una placa de ateroma del miembro izquierdo ha sufrido una trombosis con oclusión aguda, de ahí la sintomatología tan florida.

204. Un paciente varón de unos 40 años es traído a urgencias por haber sido hallado caído en la vía pública en una zona de ocio nocturno. El paciente está poco reactivo, presenta una frecuencia respiratoria de 7 por minuto, una presión arterial de 90/60mmHg y frecuencia cardiaca de 58 por minuto. Pupilas mióticas. Después de asegurar la permeabilidad de la vía aérea, ¿cuál sería el paso inmediato más apropiado a seguir?:

1. Administrar 0,4 mg de naloxona im o iv.
2. Obtener un hemograma y una bioquímica básica.
3. Solicitar un examen toxicológico de orina.
4. Solicitar una TC craneal.

Respuesta correcta: 1

Comentario:

Nos encontramos ante una intoxicación por opiáceos (probablemente heroína) debido a las pupilas mióticas, la depresión respiratoria, la alteración del estado de conciencia y la hipotensión arterial. El antídoto para revertir el nivel de conciencia es la naloxona que debe ser prioritaria tras asegurar la vía aérea a cualquier procedimiento diagnóstico.

205. Ante el diagnóstico citológico de carcinoma medular de tiroides en una punción-aspiración con aguja fina (PAAF) realizada en el estudio de un nódulo tiroideo asintomático, el siguiente paso debería ser:

1. Tiroidectomía total más linfadenectomía regional.
2. Determinación de calcio en sangre y orina.
3. Determinar los niveles de calcitonina en sangre y catecolaminas en orina.
4. Tiroidectomía total lo antes posible y dosis ablativa de I-131.

Respuesta correcta: 3

Comentario:

Bastante preguntado en el MIR! Ante un paciente con Ca medular de tiroides, antes de operarlo o hacer más pruebas se debe DESCARTAR FEOCROMOCITOMA asociado (si a un paciente con feocromocitoma le operas o das contrastes -TAC, etc- corre peligro de muerte). Recordad que el Ca medular de tiroides y el feocromocitoma se asocian en el MEN2a y en el MEN2b.

206. Mujer de 35 años sin factores de riesgo cardiovascular, con historia de dos muertes fetales a las 20 semanas de gestación, que presenta un infarto de la cerebral media derecha. En la exploración física llama la atención la presencia de livedo reticularis. En el estudio de coagulación se observa un alargamiento del TTPA. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Poliarteritis nodosa.
2. Síndrome antifosfolípido.
3. Micropoliangeitis.
4. Hemofilia.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

El síndrome antifosfolípido se diagnostica con la presencia de un criterio clínico y uno serológico. Entre los clínicos está la presencia de un episodio de trombosis arterial o venosa, o abortos (tres o más en el primer trimestre o uno o más a partir de la 10ª semana; también un nacimiento prematuro < semana 34 por pre-eclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria). Los criterios serológicos incluyen los Ac anticardiolipina, el anticoagulante lúpico, o los Ac beta2 glicoproteína. Los Ac antifosfolípidos alargan el tiempo de tromboplastina o TTPA. Recuerda que la livedo reticularis es una manifestación cutánea que sugiere con fuerza el síndrome antifosfolípido en presencia de datos clínicos y serológicos compatibles.

207. En la tricoleucemia, o leucemia de células peludas, son habituales al diagnóstico los siguientes datos EXCEPTO uno:

1. Esplenomegalia.
2. Anemia.
3. Fibrosis medular.
4. Ensanchamiento mediastínico.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La tricoleucemia es un SLPC que afecta a varones de edad media y que se caracteriza por fibrosis de MO. Cursa con pancitopenia, característicamente hay monocitopenia y esplenomegalia. Existe linfocitos que son tricoleucocitos (linfocitos con prolongaciones citoplasmáticas) con positividad para CD25 y CD103 así como ser fosfatasa ácida tartrato resistentes. Infiltran de forma importante la médula, tanto que la "empaquetan" y el aspirado de médula ósea es SECO. De forma típica hay infecciones por legionella y por micobacterias atípicas así como fenómenos autoinmunes del tipo PAN. Se trata con 2-CdA. Es muy raro la existencia de adenopatías y por tanto de ensanchamiento mediastínico.

208. Una paciente de 52 años afecta de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II y síndrome ansioso-depresivo va a ser sometida a una histerectomía programada vía suprapúbica por un mioma uterino. Sigue regularmente tratamiento con gliclazida 80 mg/día, enalapril

20 mg/día, hidroclorotiazida 25 mg/día y sertralina 100 mg/día. ¿Cuáles deberían ser nuestras instrucciones respecto a la medicación a tomar en el perioperatorio?:

1. Parar toda la medicación una semana antes de la intervención quirúrgica.
2. Parar toda la medicación dos días antes de la intervención quirúrgica.
3. Seguir con la medicación habitual, incluido el día de la intervención.
4. Parar los hipoglicemiantes orales, el antidepresivo y el diurético el día de la intervención, y mantener el enalapril.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

La mayoría de los tratamientos médicos se mantienen hasta la víspera o la mañana del día de la intervención salvo algunas excepciones. Los ACO se suspenden 5-7 días antes y se cambia por HBPM. Las HBPM a dosis terapéutica (cada 12h) se retiran 24h antes y a dosis profiláctica (cada 24h) 12h antes. Los ÁINES también se retiran 5-7 días antes. Los betabloqueantes y calcioantagonistas salvo excepciones se siguen administrando durante la intervención para evitar descompensaciones de IC, HTA... Igualmente los IECA's por la misma razón.

209. Niño de 8 meses de edad que su madre trae a Urgencia por rechazo del alimento desde hace 30 días. A la exploración presenta desnutrición y palidez intensa, cefalohematoma parietal izquierdo, manchas equimóticas redondeadas y de borde bien delimitado en ambos muslos y zona escrotal. El niño llora mucho durante la exploración y está muy agitado. El diagnóstico de presunción más probable es:

1. Sepsis fulminante con CID.
2. Niño maltratado.
3. Déficit congénito de antitrombina 3.
4. Varicela hemorrágica.

Respuesta correcta: 2

Comentario:

Indicadores de abuso físico (maltrato) son: heridas y contusiones múltiples, en diferentes momentos evolutivos; fracturas, esguinces y luxaciones recurrentes; lesiones en cara, cuello y cuero cabelludo; quemaduras y arañazos en sitios poco comunes; enfermedades venéreas no explicadas.

210. Mujer de 40 años, con Diabetes Mellitus tipo 1 e historia de ferropenia desde hace años. En estudio en las consultas de Digestivo por cuadros de dolor abdominal difuso y recurrente de características inespecíficas, que ceden de forma espontánea. Presenta un ritmo intestinal normal pero con episodios ocasionales de aumento del número de deposiciones, de consistencia líquida

y sin sangre. La exploración física es normal. En analítica: Hto. 36%, Hb 11,9 g/dl, Fe 37 microgr/dl, ALT 55, Ac Anti-Transglutaminasa TIS IgA 195 u/ml. Se realiza biopsia intestinal. ¿Qué datos histológicos espera encontrar para realizar el diagnóstico en esta paciente?:

1. Atrofia de las criptas.
2. Presencia de granulomas en la mucosa.
3. Abscesos de las criptas.
4. Atrofia subtotal de las vellosidades.

Respuesta correcta: 4

Comentario:

Se trata de una enfermedad o esprúe celiaco (clínica malabsortiva con anemia ferropénica y anticuerpos antitransglutaminasa IgA positivos, enfermedad autoinmune como DM1). La biopsia yeyunal es muy característica pero no patognomónica. En ella existen cambios inflamatorios con infiltrado mononuclear crónico en la lámina propia y típicamente linfocitos intraepiteliales; así como lesiones epiteliales con una mucosa plana con atrofia vellositaria pero con grosor conservado a expensas de la hipertrofia de las criptas (opción 4 CORRECTA). Los granulomas son típicos del Crohn (opción 2 incorrecta), la infiltración de eosinófilos de la enteritis eosinofílica y los abscesos crípticos neutrofilicos o criptitis de la CU (opción 3 incorrecta).

